Psicopatología

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre qué es un trastorno mental y cómo se reconoce: concepto e historia, modelos explicativos, DSM-5-TR, CIE-11 y enfoques dimensionales, psicopatología descriptiva de las funciones psíquicas, ansiedad, TOC, trauma, depresión y bipolaridad, psicosis, personalidad, sueño y sexualidad, disociación y síntomas somáticos, adicciones, conducta alimentaria e impulsos. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 2.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

Índice

Presentación 3
Cómo está organizado 3
Criterios de rigor 3
Aviso 4

Capítulo 1 · Qué es la psicopatología: concepto, historia y enfoques explicativos 5
Unidad 1 · Lo normal y lo patológico: concepto, historia y métodos 5
Unidad 2 · Modelos explicativos de la conducta anormal 14

Capítulo 2 · Clasificar y diagnosticar: del DSM-5-TR y la CIE-11 a las dimensiones 20
Unidad 3 · Los sistemas de clasificación: DSM-5-TR y CIE-11 20
Unidad 4 · Más allá de las categorías: modelos dimensionales y transdiagnósticos 27

Capítulo 3 · Psicopatología descriptiva: cuando fallan las funciones psíquicas 34
Unidad 5 · Conciencia, atención, memoria y psicomotricidad 34
Unidad 6 · Percepción, pensamiento, lenguaje y afectividad 41

Capítulo 4 · Miedo, obsesiones y estrés: la ansiedad y sus trastornos afines 49
Unidad 7 · Trastornos de ansiedad 49
Unidad 8 · Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados 57
Unidad 9 · Trastornos relacionados con el trauma y el estrés 63

Capítulo 5 · Estado de ánimo y psicosis 70
Unidad 10 · Depresión y trastorno bipolar 70
Unidad 11 · Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 77

Capítulo 6 · Personalidad, sueño y sexualidad 84
Unidad 12 · Trastornos de la personalidad 84
Unidad 13 · Trastornos del sueño-vigilia y de la sexualidad 91

Capítulo 7 · Disociación, cuerpo, adicciones e impulsos 98
Unidad 14 · Trastornos disociativos y de síntomas somáticos 98
Unidad 15 · Sustancias y conductas adictivas 105
Unidad 16 · Conducta alimentaria, conducta disruptiva y control de impulsos 112

Apéndices 118
Estudios y datos clave 118
Mitos y correcciones 119
Bibliografía 120
Créditos de las ilustraciones 122

Presentación

Versión 1.0 · noviembre de 2026

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de segundo curso *Psicopatología* (en otros planes de estudio, *Psicopatología general* o *Psicopatología y trastornos psicológicos*) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Empieza por las preguntas de fondo (qué es un trastorno mental, cómo se ha entendido a lo largo de la historia, qué modelos lo explican y cómo se clasifica) y sigue con la psicopatología descriptiva de las funciones psíquicas, imprescindible para reconocer síntomas. Después recorre los grandes grupos de trastornos: ansiedad, obsesiones y trauma; estado de ánimo; psicosis; personalidad; sueño y sexualidad; disociación y síntomas somáticos; adicciones; conducta alimentaria y control de impulsos.

Está actualizado a los sistemas vigentes, el **DSM-5-TR** (2022) y la **CIE-11** (en vigor desde 2022), e incluye los modelos dimensionales y transdiagnósticos (factor p, HiTOP, RDoC) y las propuestas del comité que prepara el futuro DSM. También revisa ideas muy difundidas que la investigación reciente ha corregido, como la depresión por «déficit de serotonina», la interacción entre el gen del transportador de serotonina y el estrés, la interpretación clásica de la indefensión aprendida o la supuesta peligrosidad de las personas con esquizofrenia.

Cómo está organizado

El temario tiene **7 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice, y se presentan las posturas.
- Los criterios diagnósticos se resumen con fines docentes; para el uso clínico deben consultarse las ediciones oficiales del DSM-5-TR y de la CIE-11.
- Los estudios clásicos se presentan junto con sus **réplicas y revisiones** más recientes. Un experimento famoso no es necesariamente un experimento sólido.
- Las prevalencias varían según el país, el método y el periodo; se dan como aproximadas salvo cuando proceden de un estudio concreto citado.
- Los gráficos y esquemas son de elaboración propia; las fotografías e ilustraciones históricas proceden de Wikimedia Commons, con su autoría y licencia en el pie y en los créditos finales.

- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sirve para diagnosticarse ni para diagnosticar a otras personas, y no sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional. Si estás pasando por un mal momento, busca ayuda: en España puedes llamar al **024** (línea de atención a la conducta suicida) o al **112** en caso de urgencia. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

Capítulo 1 · Qué es la psicopatología: concepto, historia y enfoques explicativos

Antes de estudiar trastornos concretos hay que responder a tres preguntas: cuándo una conducta o una experiencia deja de ser normal, cómo se ha llegado a las ideas actuales y desde qué teorías se intenta explicar lo que ocurre. Este capítulo recorre los criterios de anormalidad, la historia de la disciplina, sus métodos de investigación y los grandes modelos explicativos, desde el biomédico hasta los integradores.

Unidad 1 · Lo normal y lo patológico: concepto, historia y métodos

Objetivos: definir la psicopatología y distinguirla de la psicología clínica y la psiquiatría; comparar los criterios de anormalidad y explicar la propuesta de disfunción perjudicial de Wakefield; describir los hitos históricos desde la trepanación hasta el DSM-5-TR y la CIE-11; conocer los métodos de investigación y los datos epidemiológicos de referencia.

1.1 Qué entendemos por trastorno mental: criterios de anormalidad

La **psicopatología** es la disciplina que estudia la naturaleza, las causas, el curso y las manifestaciones de la conducta y la experiencia anormales. Es una ciencia básica y descriptiva: se pregunta qué es un síntoma, cómo se agrupan los síntomas y por qué aparecen. La **psicología clínica** y la **psiquiatría** son disciplinas aplicadas que usan ese conocimiento para evaluar, diagnosticar y tratar.

Para decidir qué es anormal no hay un criterio único, sino varios, cada uno con su lógica y sus límites.

Criterio estadístico. Lo anormal es lo que se aleja de la media de una población de referencia. Si una característica se distribuye de forma normal, aproximadamente el 68 % de las personas queda a menos de una desviación típica de la media, en torno al 95 % a menos de dos y cerca del 99,7 % a menos de tres. Es objetivo, pero califica de anormal lo infrecuente aunque sea deseable (una capacidad intelectual muy alta) y no dice qué variables medir ni dónde poner el corte.

Criterio social o consensual. Lo anormal es lo que se aparta de las normas del grupo. H. S. Sullivan habló de **validación consensual**: la comunidad acuerda qué resulta aceptable. Recoge la adaptación social, que a menudo es un objetivo terapéutico, pero cae en el **relativismo** cultural e histórico: la homosexualidad figuró como trastorno en el DSM hasta 1973-1974, y la «homosexualidad egodistónica» se mantuvo hasta el DSM-III-R (1987).

Criterio subjetivo. La propia persona juzga su malestar. Respeta la vivencia de quien sufre, pero falla cuando falta **conciencia de enfermedad**, algo frecuente en la manía, la psicosis o la anorexia. Además, no todo el que consulta tiene un trastorno.

Criterio biológico. Lo anormal es la disfunción de un sistema del organismo, según el esquema del modelo médico: causa, síntomas, curso, pronóstico y tratamiento. Su riesgo es el **reduccionismo**: para la mayoría de los trastornos mentales no se conoce una lesión o un marcador que los defina.

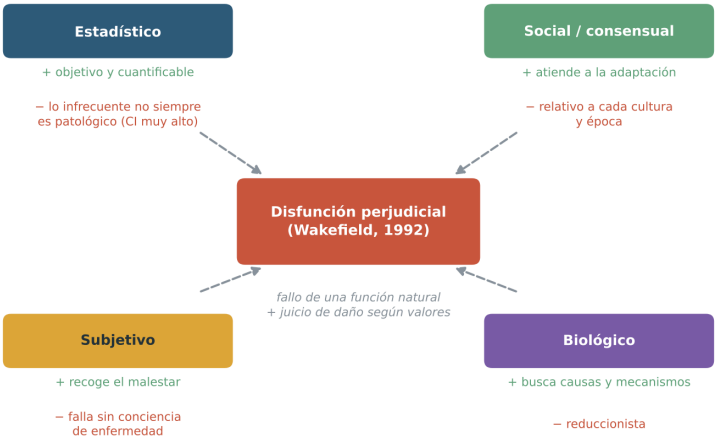


Figura 1.1. **Criterios de anormalidad.** Los cuatro criterios clásicos, cada uno con una ventaja y una limitación, alrededor de la propuesta integradora de la disfunción perjudicial. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 1.1, ningún criterio basta por sí solo. En la práctica se añaden otros indicadores: el **malestar** clínicamente significativo, el **deterioro** en el trabajo, los estudios o las relaciones, la **peligrosidad** para uno mismo o para otros y la conducta **inesperada o desproporcionada** ante la situación. No hay que confundir el criterio estadístico, que habla de frecuencia, con el normativo, que habla de normas: algo puede ser frecuente y estar mal visto.

La disfunción perjudicial. Wakefield (1992) propuso una síntesis muy citada (*harmful dysfunction*). Hay trastorno cuando se cumplen dos condiciones. La primera es **científica**: un mecanismo psicológico o biológico falla en la función que tiene por naturaleza. La segunda es **valorativa**: ese fallo causa un daño según los valores de la sociedad. Asustarse ante un perro suelto que ladra no es un trastorno, porque la alarma hace su trabajo; un miedo que se dispara en cada autobús y obliga a dejar un empleo sí puede serlo.

La definición del DSM-5-TR. El trastorno mental es un **síndrome** con una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación emocional o el comportamiento, que refleja una **disfunción** de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo y suele asociarse a **malestar o deterioro**. Quedan fuera las respuestas esperables o culturalmente aceptadas, como el duelo normal, y la desviación social que no deriva de una disfunción. Están, por tanto, las dos piezas de Wakefield.

1.2 De la trepanación al Renacimiento

La **trepanación**, abrir orificios en el cráneo, es una de las intervenciones más antiguas que se conocen. Desde el Neolítico se han hallado cráneos con orificios cuyos bordes muestran cicatrización, de modo que muchas personas sobrevivieron.



Figura 1.2. **Cráneos trepanados.** Cráneos de la Edad del Bronce hallados en Comps-sur-Artuby (Francia) con orificios de trepanación; los bordes redondeados de algunos indican que la persona sobrevivió. Fuente: Wisi eu, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Como se ve en la figura 1.2, la intervención no era necesariamente mortal. Se repite que servía para «liberar espíritus», pero eso es una **hipótesis**, no un hecho: también pudo tener fines terapéuticos, por ejemplo tras un traumatismo en la cabeza.

En la Grecia clásica, **Hipócrates** (s. V-IV a. C.) defendió que las enfermedades tienen **causas naturales**. Su **teoría de los cuatro humores** (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra) entendía la salud como un equilibrio entre ellos; el exceso de bilis negra dio nombre a la **melancolía**. Los textos hipocráticos describen la melancolía, la manía y la histeria, atribuida a un «útero errante», y tratan la epilepsia como una enfermedad natural, no sagrada. **Galeno** (s. II d. C.) sistematizó la doctrina humoral y la relacionó con los temperamentos.

La Edad Media, sin tópicos. Las explicaciones sobrenaturales convivieron con explicaciones naturales y con instituciones de cuidado. La medicina árabe, con autores como **Avicena**, conservó y amplió la tradición griega, y en el mundo islámico hubo hospitales que atendían a enfermos mentales. En **Valencia, en 1409**, fray **Gilabert Jofré** impulsó el **Hospital de los Inocentes** (Hospital dels Ignoscents, Folls e Orats), considerado uno de los primeros hospitales psiquiátricos de Europa.



Figura 1.3. **El padre Jofré protegiendo a un loco (Joaquín Sorolla).** Recrea la escena que, según la tradición, llevó a fray Gilabert Jofré a impulsar en Valencia el Hospital de los Inocentes (1409). Fuente: Joaquín Sorolla, Wikimedia Commons, dominio público.

La figura 1.3 recoge esa tradición, pintada siglos después. La demonología más dura llega al final del periodo: el *Malleus maleficarum* (Kramer y Sprenger, 1486/1487), un manual para identificar y perseguir la brujería, es de finales del siglo XV.

El Renacimiento. El humanista valenciano **Juan Luis Vives** defendió un trato humano y digno para las personas con trastornos mentales. **Johann Weyer**, en *De praestigiis daemonum* (1563), sostuvo que muchas de las mujeres acusadas de brujería padecían en realidad una enfermedad.

Los asilos. En los siglos XVII y XVIII se extendieron los **asilos de reclusión**, pensados más para apartar a las personas que para curarlas. El más conocido fue el hospital londinense de **Bethlem**, apodado «Bedlam».



Figura 1.4. **En Bedlam (William Hogarth, 1735).** Última lámina de *La carrera del libertino*: el protagonista, internado en el hospital londinense de Bethlem, entre otros internos y dos visitantes elegantes. Fuente: William Hogarth, Yale Center for British Art, Wikimedia Commons, CC0.

Como refleja la figura 1.4, los internos podían convertirse en espectáculo para los visitantes.

1.3 El nacimiento de la psicopatología científica

Pinel y el tratamiento moral. Philippe Pinel (1745-1826) dirigió el hospital de Bicêtre (1793) y después la Salpêtrière, en París, donde impulsó el **tratamiento moral**: trato humano, orden, actividad y observación de cada paciente en lugar de cadenas y castigos. La escena de la «liberación de las cadenas» es en parte leyenda: el supervisor **Jean-Baptiste Pussin** tuvo un papel clave. En Inglaterra, **William Tuke** fundó el York Retreat (1796) con principios parecidos. La figura 1.5 muestra cómo la pintura idealizó la escena.



Figura 1.5. **Pinel en la Salpêtrière (Tony Robert-Fleury).** La pintura idealiza la «liberación de las cadenas»; en la reforma real fue clave también el supervisor Jean-Baptiste Pussin. Fuente: Tony Robert-Fleury, Wikimedia Commons, dominio público.

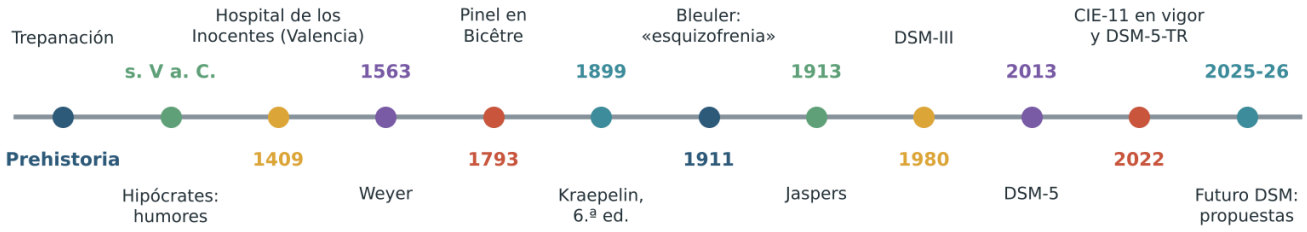


Figura 1.6. **Hitos de la historia de la psicopatología.** Eje temporal desde la trepanación prehistórica hasta las propuestas para el futuro DSM, con Hipócrates, Valencia (1409), Weyer, Pinel, Kraepelin, Bleuler, Jaspers, el DSM-III, el DSM-5, la CIE-11 y el DSM-5-TR. Esquema ilustrativo con fechas reales. Elaboración propia.

El modelo médico del siglo XIX. Como muestra la figura 1.6, el siglo XIX situó los trastornos mentales en el terreno de la medicina. **Griesinger** lo resumió así: «las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro». Lo reforzó un hallazgo: la **parálisis general progresiva**, con síntomas psiquiátricos y demencia, era una consecuencia tardía de la sífilis; Noguchi y Moore (1913) hallaron el *Treponema* en el cerebro de los pacientes.

Kraepelin, Bleuler y Jaspers. Emil Kraepelin clasificó los trastornos por su **curso y pronóstico**. En la 6.ª edición de su tratado (1899) separó la *dementia praecox*, de curso deteriorante, de la **locura maníaco-depresiva**, de curso episódico. **Eugen Bleuler** (1911) acuñó el término **esquizofrenia**, que alude a una escisión de las funciones psíquicas, no de la personalidad, y distinguió síntomas fundamentales, las **cuatro A** (asociaciones laxas, afecto aplanado o inapropiado, ambivalencia y autismo), de síntomas accesorios como delirios y alucinaciones. **Karl Jaspers**, en su *Psicopatología general* (1913), fundó el método fenomenológico y distinguió **comprender** (captar relaciones de sentido) de **explicar** (establecer relaciones causales); de ahí el delirio primario, incomprensible, y la distinción entre **proceso** y **desarrollo**. Después, **Kurt Schneider** describió los **síntomas de primer rango** (Unidad 5).

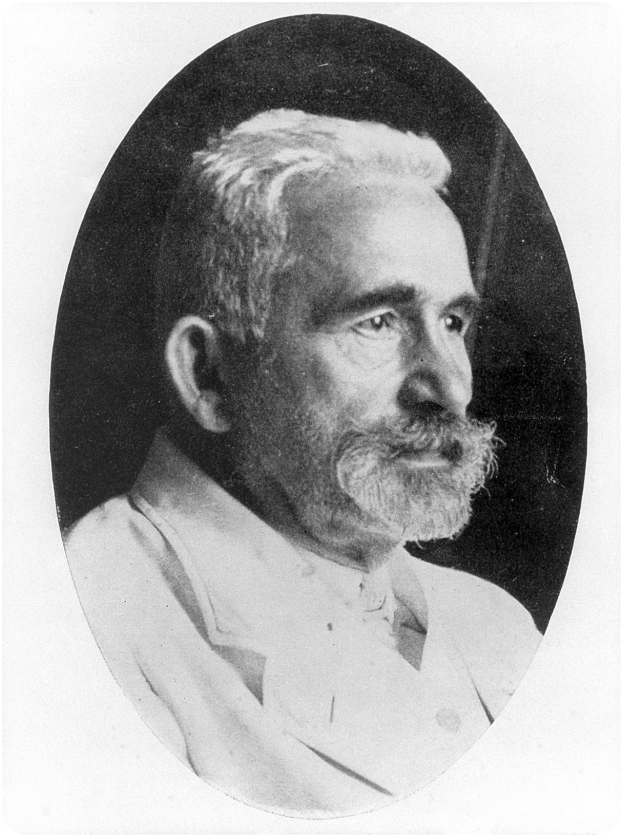


Figura 1.7. **Emil Kraepelin (1856-1926).** Fuente: Wellcome Collection, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

De Charcot a Freud. En la Salpêtrière, **Charcot** estudió la histeria y la hipnosis. **Sigmund Freud**, que se formó con él, publicó con Breuer los *Estudios sobre la histeria* (1895), origen del psicoanálisis (Unidad 2).

El siglo XX. Llegaron el conductismo (Watson, 1913), la revolución cognitiva (Beck, Ellis), los psicofármacos, con la clorpromazina en 1952, y la **desinstitucionalización**; en España, la reforma psiquiátrica se apoyó en la Ley General de Sanidad de 1986. El **DSM-I** (1952) y el DSM-II (1968) tenían fuerte influencia psicodinámica y baja fiabilidad. El **DSM-III** (1980) introdujo **criterios operativos** explícitos, un enfoque **descriptivo y ateórico** y un **sistema multiaxial** de cinco ejes. El **DSM-5** (2013) eliminó los ejes, y el **DSM-5-TR** (2022) es una revisión de texto, no un DSM-6. La OMS incluyó por primera vez un capítulo de trastornos mentales en la **CIE-6** (1948). Los dos sistemas actuales se comparan a fondo en la Unidad 3:

Rasgo	DSM-5-TR	CIE-11
Quién lo elabora	Asociación Americana de Psiquiatría (APA)	Organización Mundial de la Salud (OMS)
Fecha	Publicado en marzo de 2022	Aprobada en 2019; en vigor desde el 1 de enero de 2022

Rasgo	DSM-5-TR	CIE-11
Alcance	Solo trastornos mentales	Todas las enfermedades; los mentales, en el capítulo 6
Cómo describe los trastornos	Criterios operativos con recuentos y duraciones	Características esenciales con flexibilidad clínica

En el Sistema Nacional de Salud español, la codificación oficial sigue siendo la **CIE-10-ES**, vigente desde 2016.

1.4 Cómo se investiga en psicopatología

Epidemiología. Estudia cuántas personas tienen un trastorno y de qué depende. La **prevalencia** es la proporción de personas con el trastorno en una población: en un momento dado (**puntual**), en el último año (**anual**) o en algún momento de la vida (**vital**). La **incidencia** es el número de **casos nuevos** en un periodo. Si en un instituto hay 30 estudiantes con depresión en marzo y 5 empezaron ese mes, 30 es la prevalencia y 5, la incidencia mensual.

Tres fuentes de datos son de referencia:

- **World Mental Health Surveys** (McGrath et al., 2023): prevalencia vital de cualquier trastorno del 28,6 % en hombres y del 29,8 % en mujeres; riesgo acumulado a los 75 años del 46,4 % y del 53,1 %. El pico de inicio está en torno a los 15 años, con una mediana de 19-20 años.
- **ESEMeD-España** (Haro et al., 2006): prevalencia vital del 19,5 % y anual del 8,4 %. El trastorno más frecuente es el episodio depresivo mayor (3,9 % anual y 10,5 % vital), y la fobia específica es el segundo en prevalencia vital. La ansiedad y la depresión son más del doble de frecuentes en mujeres; el abuso de alcohol, en hombres.
- **Carga mundial de enfermedad** (GBD 2021): la depresión es la segunda causa mundial de años vividos con discapacidad (≈56,3 millones) y la ansiedad, la sexta (≈42,5 millones).

Genética conductual. Los **estudios de familias** comprueban si un trastorno se agrupa en parientes, pero no separan genes y ambiente compartido. Los **estudios de gemelos** comparan la concordancia en gemelos monocigóticos, que comparten casi todos sus genes, y dicigóticos, que comparten en promedio la mitad. Los **estudios de adopción** separan la herencia biológica de la crianza. Los **estudios de asociación del genoma completo** (GWAS) buscan variantes comunes asociadas al trastorno y permiten calcular **puntuaciones poligénicas**. Los fundamentos genéticos se estudian en Psicología Fisiológica.

Diseño	Pregunta que responde	Limitación principal
Transversal	¿Cuántas personas tienen el trastorno ahora?	No establece qué fue antes
Longitudinal o de cohorte	¿Qué factores preceden al trastorno?	Caro y lento (p. ej., cohorte de Dunedin, Nueva Zelanda)
Casos y controles	¿En qué se diferencian quienes lo tienen?	Sesgos en la selección y en el recuerdo
Análogo	¿Aparece el proceso en población subclínica o inducido en laboratorio?	Dudas sobre su extrapolación a la clínica
Modelo animal	¿Qué mecanismo biológico interviene?	No reproduce la experiencia humana
Ensayo controlado	¿Funciona una intervención?	Muestras a veces poco representativas

Un estudio polémico: Rosenhan (1973). Rosenhan describió cómo varios colaboradores sin trastorno fingieron oír voces, fueron ingresados en hospitales psiquiátricos y recibieron diagnósticos graves pese a comportarse después con normalidad. Fue muy influyente, pero hoy se considera **polémico**: Cahalan (2019) planteó serias

dudas sobre la veracidad de sus datos. Sirve para reflexionar sobre la fiabilidad del diagnóstico (Unidad 3), no como prueba de que no sirve.

Consenso y debate

Consenso: ningún criterio aislado define la anormalidad; la práctica combina disfunción, malestar y deterioro, como recoge la definición del DSM-5-TR. Los trastornos mentales son frecuentes: cerca de tres de cada diez personas han tenido alguno a lo largo de su vida, y el riesgo acumulado hasta los 75 años ronda la mitad, con inicio típico en la adolescencia y la juventud (McGrath et al., 2023).

Debate: dónde termina el componente científico de la definición de trastorno y dónde empieza el valorativo, y si una «función natural» puede establecerse sin juicios de valor.

Mito frecuente

Mito: «En la Edad Media la locura se explicaba solo como posesión demoníaca y se trataba con exorcismos».

Realidad: la demonología convivió con explicaciones naturales, conservadas por la medicina árabe (Avicena), y con instituciones de cuidado, como el Hospital de los Inocentes que fray Gilabert Jofré impulsó en Valencia en 1409. El *Malleus maleficarum* (Kramer y Sprenger, 1486/1487) es ya de finales del siglo XV.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Psicopatología	Ciencia que estudia la naturaleza, causas, curso y manifestaciones de la conducta anormal
Criterio estadístico	Considera anormal lo que se aleja de la media de la población de referencia
Validación consensual	Idea de Sullivan: la comunidad acuerda qué conducta es normal o aceptable
Disfunción perjudicial	Fallo de una función natural que causa daño según los valores sociales (Wakefield, 1992)
Tratamiento moral	Reforma de Pinel y Pussin: trato humano y orden en lugar de cadenas y castigos
Comprender y explicar	Jaspers: captar relaciones de sentido frente a establecer relaciones causales
Prevalencia	Proporción de personas con un trastorno en un momento, un año o la vida
Incidencia	Número de casos nuevos de un trastorno en un periodo determinado

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué limitación tiene cada criterio de anormalidad, los dos componentes de la disfunción perjudicial y la atribución correcta de los hitos históricos (Kraepelin, Bleuler, Jaspers, DSM-III). Trampas típicas: atribuir a Bleuler la separación kraepeliniana entre *dementia praecox* y locura maníaco-depresiva, creer que el DSM-5 mantiene el sistema multiaxial y confundir prevalencia con incidencia.

Autoevaluación

1. ¿Qué limitación es propia del criterio estadístico de anormalidad?
a) Depende de las normas de cada cultura
b) Considera anormal lo infrecuente aunque sea deseable
c) Falla si la persona no tiene conciencia de enfermedad

2. Según Wakefield (1992), un trastorno exige…
a) un fallo de una función natural y un daño según los valores sociales
b) un malestar subjetivo y una puntuación extrema en un test
c) una lesión cerebral demostrable y un deterioro laboral

3. El Hospital de los Inocentes de Valencia fue impulsado por…
a) Juan Luis Vives en 1563
b) Philippe Pinel en 1793
c) fray Gilabert Jofré en 1409

4. En la 6.ª edición de su tratado (1899), Kraepelin separó…
a) la *dementia praecox* y la locura maníaco-depresiva
b) la esquizofrenia y la personalidad múltiple
c) la neurosis y la psicosis según su causa

5. El número de casos nuevos de un trastorno durante un año es su…
a) prevalencia anual
b) incidencia anual
c) prevalencia vital

Soluciones

1 b. Una capacidad muy alta es infrecuente sin ser patológica; las otras opciones corresponden a los criterios social y subjetivo. **2 a.** Combina un componente científico (disfunción) y uno valorativo (perjuicio). **3 c.** Vives fue humanista, Weyer escribió en 1563 y Pinel llegó a Bicêtre en 1793. **4 a.** Bleuler acuñó después el término «esquizofrenia» (1911). **5 b.** La prevalencia cuenta todos los casos existentes; la incidencia, solo los nuevos.

Unidad 2 · Modelos explicativos de la conducta anormal

Objetivos: describir los supuestos, aportaciones y límites del modelo biomédico e interpretar correctamente la heredabilidad; explicar los conceptos básicos del modelo psicodinámico y valorar su legado; comparar los modelos conductual, cognitivo y sociocultural; explicar los modelos integradores biopsicosocial, de vulnerabilidad-estrés y de psicopatología del desarrollo.

2.1 El modelo biomédico

El **modelo biomédico** entiende el trastorno mental como una **enfermedad** con una base orgánica: alteraciones genéticas, de la neurotransmisión o de la estructura y el funcionamiento cerebral. Traslada a la psicopatología la lógica de la medicina general: busca una **alteración biológica** que explique los síntomas, diagnostica de forma **categorial** (se tiene o no la enfermedad) a partir de signos y síntomas, y espera que el diagnóstico prediga el **curso** y oriente un tratamiento **biológico** dirigido a esa causa.

Aportaciones. El modelo tiene éxitos claros. La parálisis general progresiva resultó ser una infección del cerebro por sífilis (Unidad 1). Los psicofármacos, desde la clorpromazina en 1952, cambiaron el pronóstico de muchas personas y la vida de los hospitales. La genética ha mostrado que casi todos los rasgos y trastornos tienen un componente hereditario. Una revisión de cinco décadas de estudios de gemelos, con 17.804 rasgos y más de 14,5 millones de pares de gemelos, estimó una **heredabilidad media de los rasgos humanos de ≈49 %** (Polderman et al., 2015).

La **heredabilidad** se malinterpreta a menudo. Es la proporción de la **variabilidad entre personas** de una población que se asocia a diferencias genéticas. No dice qué parte del trastorno de una persona concreta «viene de los genes», ni que el trastorno sea inevitable. Además, la arquitectura genética de los trastornos es **poligénica**: intervienen muchas variantes, cada una con un efecto pequeño, y no un «gen de la depresión» o un «gen de la esquizofrenia». En la esquizofrenia, por ejemplo, se han identificado 287 regiones del genoma asociadas (Trubetskoy et al., 2022; Unidad 11).

Límites. Las críticas principales son tres:

- **Reduccionismo**: explicar la experiencia solo por la biología deja fuera la historia personal, el aprendizaje y el contexto.
- **Falta de marcadores**: para casi ningún trastorno mental hay una prueba biológica que lo diagnostique.
- **Explicaciones simplificadas**: la idea de que la depresión es un «desequilibrio químico» por falta de serotonina no se sostiene; una revisión paraguas no encontró apoyo consistente a esa hipótesis (Moncrieff et al., 2022), lo que no equivale a negar la eficacia de los antidepresivos (Unidad 10).

El debate de la «enfermedad cerebral». ¿Son los trastornos mentales enfermedades del cerebro, o constructos prácticos que agrupan problemas de origen diverso? Todo lo psicológico ocurre en un cerebro, pero eso no implica que la mejor explicación de un trastorno sea siempre la biológica: un mismo cuadro puede describirse a la vez en términos de circuitos, de aprendizaje y de circunstancias vitales. El mismo debate reaparece en las adicciones (Unidad 15). Los mecanismos de neurotransmisión se estudian en Psicología Fisiológica y los de los fármacos, en Psicofarmacología; aquí interesan como hipótesis sobre el origen de los trastornos.

2.2 El modelo psicodinámico

El **modelo psicodinámico** nace con **Sigmund Freud** a partir de su trabajo con pacientes con histeria (Unidad 1). Su idea central es que gran parte de la vida mental es **inconsciente** y que los síntomas expresan **conflictos** psicológicos que la persona no reconoce, enraizados en experiencias tempranas.

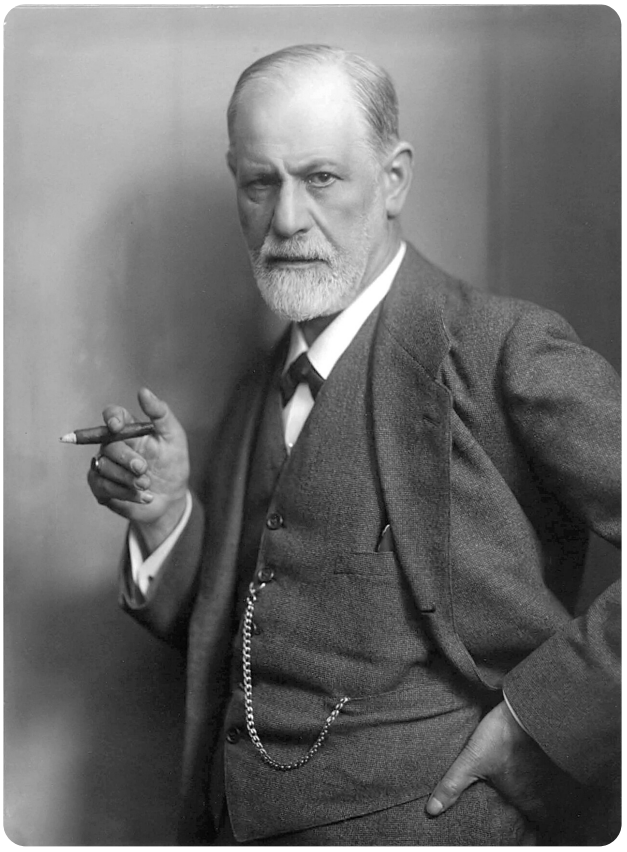


Figura 2.1. **Sigmund Freud (1856-1939)**, fotografiado por Max Halberstadt. Fuente: Max Halberstadt, Wikimedia Commons, dominio público.

La estructura de la mente. Freud, retratado en la figura 2.1, describió tres instancias:

Instancia	Función	Principio que la rige
Ello	Fuente de impulsos y deseos	Principio del placer
Yo	Media entre los impulsos, las normas y la realidad	Principio de realidad
Superyó	Normas e ideales interiorizados; conciencia moral	Exigencia moral

Cuando un deseo choca con las normas o con la realidad aparece la **angustia**, y el yo se protege con **mecanismos de defensa**: la **represión** (mantener fuera de la conciencia un contenido amenazante), la **negación**, la **proyección** (atribuir a otros los propios impulsos), el **desplazamiento** o la **racionalización**. Quien llega tarde a una cita importante y lo achaca al tráfico, cuando en realidad no quería ir, estaría racionalizando. Las defensas son normales; se vuelven problemáticas cuando son rígidas o distorsionan mucho la realidad.

El síntoma como compromiso. Para este modelo, el síntoma es una **formación de compromiso**: satisface de forma parcial y disfrazada el deseo y, a la vez, la defensa contra él. Por eso tendría un **sentido** que el análisis debe descubrir. Freud situó el origen de los conflictos en las **etapas psicosexuales** (oral, anal, fálica, latencia y genital) y en la fijación en alguna de ellas. El modelo supone una **continuidad** entre salud y enfermedad: todos tenemos conflictos y defensas, y la diferencia es de grado.

Un ejemplo para entender la lógica, no para darla por probada: una persona que no se permite reconocer su enfado con un padre exigente desarrolla dolores de cabeza que le impiden ir a las comidas familiares. Desde este modelo, el síntoma la aleja del conflicto sin que tenga que admitir el enfado.

Críticas. Muchos de sus conceptos son difíciles de **falsar**: casi cualquier conducta puede interpretarse como expresión de un deseo o de una defensa contra él. Las hipótesis específicas, como las etapas psicosexuales, tienen **poca evidencia empírica**. Su base procede sobre todo de casos clínicos interpretados por el propio

terapeuta, y sus explicaciones suelen construirse a posteriori, cuando el síntoma ya ha aparecido, lo que permite explicar mucho pero predecir poco.

Legado. Aun así, dejó aportaciones duraderas: la importancia de la **relación terapéutica**, la atención a la historia personal y la idea de que gran parte del procesamiento mental no es consciente. La psicología cognitiva ha estudiado ese **inconsciente cognitivo** con métodos experimentales, aunque lo entiende como procesamiento automático y no como un depósito de deseos reprimidos. Las teorías de la personalidad derivadas se estudian en Personalidad.

2.3 Modelos conductual, cognitivo y sociocultural

El modelo conductual. Sostiene que la conducta anormal se **aprende** con los mismos principios que la normal, y que la diferencia es cuantitativa. Se apoya en tres mecanismos:

- **Condicionamiento clásico**: un estímulo neutro asociado a otro que provoca miedo acaba provocándolo también (Watson y Rayner, 1920; Unidad 7).
- **Condicionamiento operante**: las consecuencias mantienen la conducta. Evitar lo temido produce alivio, y ese alivio refuerza la evitación.
- **Aprendizaje vicario**: se aprende observando a otros, por ejemplo el miedo a las arañas al ver la reacción de un familiar.

En lugar del diagnóstico categorial propone el **análisis funcional**: identificar los **antecedentes** de la conducta, la **conducta** misma y sus **consecuencias**. Un niño que tiene rabietas al salir del parque y consigue quedarse más tiempo está siendo reforzado; el análisis se centra en esa relación y no en una etiqueta. El condicionamiento y la extinción se estudian en Aprendizaje.

El modelo cognitivo. Añade que entre la situación y la emoción **media el procesamiento de la información**: esquemas, creencias, sesgos y distorsiones. Para **Beck** (1967), los esquemas disfuncionales activados por un suceso generan pensamientos automáticos negativos que mantienen la depresión (Unidad 10). **Ellis** propuso el **modelo ABC**: un acontecimiento (A) no causa directamente las consecuencias emocionales y conductuales (C); las causan las **creencias** (B) sobre él. Suspender un examen no produce lo mismo en quien piensa «tengo que estudiar de otra forma» que en quien piensa «soy un fracaso». Hoy ambos enfoques se integran en el **modelo cognitivo-conductual**, que considera cogniciones, emociones, conductas y contexto en interacción. Las técnicas de intervención se estudian en Tratamientos psicológicos.

El modelo sociocultural. Destaca los factores sociales en el origen y el mantenimiento de los trastornos. Mira tanto el entorno cercano (familia, amistades) como las condiciones de la sociedad en su conjunto (economía, desigualdad, normas culturales). La pobreza, la discriminación, el aislamiento, el entorno urbano y la migración se asocian a más psicopatología. También recuerda que lo que se considera síntoma depende en parte de la cultura (Unidad 1).

Su versión más radical fue la **antipsiquiatría** de los años sesenta y setenta. **Thomas Szasz** sostuvo que la «enfermedad mental» es un mito que convierte problemas vitales y desviaciones sociales en enfermedades, y **R. D. Laing** interpretó la psicosis como una respuesta comprensible a situaciones familiares y sociales insoportables. Hoy se estudia como **crítica histórica**: sus tesis más radicales no han recibido apoyo empírico, pero contribuyó a denunciar abusos y a impulsar la reforma psiquiátrica.

Modelo	Causa principal	Unidad de análisis	Crítica principal
Conductual	Aprendizaje	Relación entre conducta y ambiente	Deja fuera la experiencia subjetiva
Cognitivo	Creencias y procesamiento	Pensamientos, esquemas, sesgos	¿La cognición es causa o síntoma?

Modelo	Causa principal	Unidad de análisis	Crítica principal
Sociocultural	Condiciones sociales	Familia, comunidad, cultura	No explica por qué solo algunos enferman

2.4 Integración: biopsicosocial, vulnerabilidad-estrés y psicopatología del desarrollo

Cada modelo explica bien una parte del problema y mal las demás. Por eso la psicopatología actual se apoya en **modelos integradores**.

El modelo biopsicosocial. Engel (1977) criticó en la revista *Science* que el modelo biomédico dejara fuera a la persona y su contexto, y propuso considerar a la vez los factores **biológicos**, **psicológicos** y **sociales**, que interactúan entre sí. Es hoy el marco de referencia general. Su crítica habitual es que resulta **vago**: afirma que todo influye, pero no dice cuánto pesa cada factor ni cómo interactúan en cada trastorno.

El modelo de vulnerabilidad-estrés. Zubin y Spring (1977) lo propusieron para la esquizofrenia, y hoy se aplica a muchos trastornos. Sus supuestos son:

1. La **vulnerabilidad** es una característica relativamente **estable** de la persona, que puede tener raíces genéticas, biológicas o de la historia de aprendizaje.
2. El **estrés** procede de acontecimientos vitales y dificultades cotidianas.
3. Aparece un **episodio** cuando el estrés supera el **umbral** de la persona, y ese umbral es más bajo cuanto mayor es la vulnerabilidad.
4. Los episodios son **temporales**: cuando el estrés baja, la persona puede volver a su nivel previo.

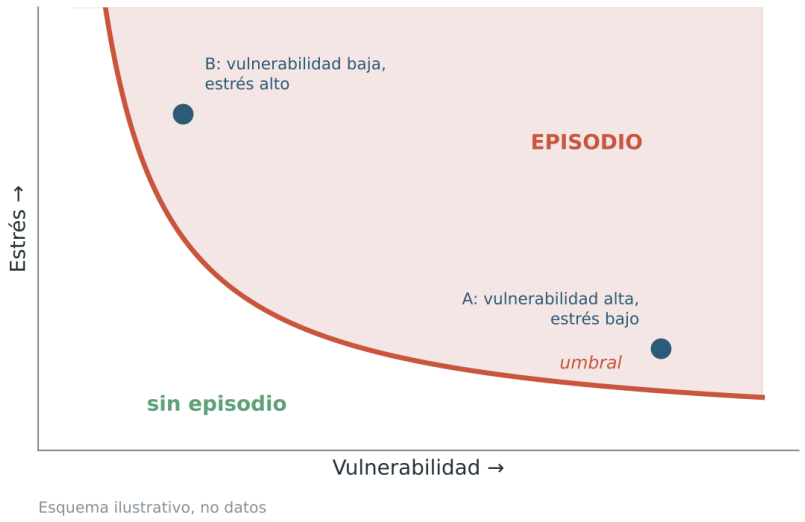


Figura 2.2. **Modelo de vulnerabilidad-estrés.** La curva umbral separa la zona de episodio, encima, de la zona sin episodio, debajo. La persona A, muy vulnerable, cruza el umbral con poco estrés; la persona B, poco vulnerable, lo cruza con un estrés muy alto. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.2, dos personas pueden presentar un episodio por caminos opuestos. Una estudiante con antecedentes familiares y episodios previos puede recaer con la presión de una mudanza; un compañero sin vulnerabilidad conocida puede presentar síntomas tras una acumulación de pérdidas graves. El modelo explica también por qué reducir el estrés o reforzar el afrontamiento ayuda a prevenir recaídas.

La psicopatología del desarrollo. Estudia los trastornos como **trayectorias** a lo largo de la vida, en relación con el desarrollo normal. Dos conceptos son centrales:

- **Equifinalidad**: **distintas vías** llevan al **mismo resultado**. Dos adolescentes llegan a la depresión, uno tras el acoso escolar y otro tras la enfermedad grave de su madre.

- **Multifinalidad**: un **mismo factor** lleva a **resultados distintos**. Entre niños que han sufrido negligencia, unos desarrollan ansiedad, otros problemas de conducta y otros ningún trastorno.

Estos conceptos explican por qué no hay una causa única para cada trastorno ni un destino fijo para cada factor de riesgo. El apego y el desarrollo típico se estudian en Psicología del Desarrollo.

Los manuales diagnósticos no adoptan ninguno de estos modelos como explicación causal, pero sí reflejan parte de su influencia:

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Postura causal	Descriptivo; la causa solo define algunas categorías (sustancias, estrés)	Igualmente descriptiva, con la misma excepción
Ciclo vital	Capítulos ordenados según el momento de aparición en la vida	Sin capítulo de trastornos infantiles; enfoque de ciclo vital
Dimensiones	Modelo alternativo de los trastornos de la personalidad en la Sección III	Gravedad y dominios en personalidad; descriptores de síntomas en psicosis
Contexto psicosocial	Otras afecciones que pueden ser objeto de atención clínica	Factores que influyen en el estado de salud

Estos modelos dimensionales se desarrollan en la Unidad 4.

Consenso y debate

Consenso: la psicopatología es **multicausal**: factores biológicos, psicológicos y sociales interactúan en su origen y su mantenimiento (Engel, 1977). La arquitectura genética de los trastornos es poligénica y la heredabilidad media de los rasgos humanos ronda el 49 % (Polderman et al., 2015). Ningún modelo aislado explica la conducta anormal.

Debate: si los trastornos mentales deben entenderse como enfermedades cerebrales o como constructos prácticos que agrupan problemas diversos. También se discute cómo hacer operativo el modelo biopsicosocial para que genere predicciones contrastables y no se limite a afirmar que «todo influye».

Mito frecuente

Mito: «Si un trastorno es muy heredable, está escrito en los genes y no se puede hacer nada».

Realidad: la heredabilidad describe qué parte de las diferencias entre personas de una población se asocia a diferencias genéticas; no habla del destino de un individuo. Con una heredabilidad media de los rasgos de ≈49 % (Polderman et al., 2015), los factores no genéticos explican, en promedio, una parte parecida de las diferencias. Además, la influencia genética es poligénica, repartida en muchas variantes de efecto pequeño (Trubetskoy et al., 2022), y heredable no significa inmodificable.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Heredabilidad	Proporción de la variabilidad de un rasgo en una población asociada a diferencias genéticas

Concepto	Definición
Formación de compromiso	Síntoma que satisface a la vez un deseo inconsciente y la defensa contra él (Freud)
Análisis funcional	Estudio de los antecedentes, la conducta y las consecuencias que la mantienen
Modelo ABC	Ellis: las creencias (B) sobre un acontecimiento (A) determinan sus consecuencias (C)
Modelo biopsicosocial	Integración de factores biológicos, psicológicos y sociales en interacción (Engel, 1977)
Vulnerabilidad-estrés	Hay episodio cuando el estrés supera el umbral marcado por la vulnerabilidad (Zubin y Spring, 1977)
Equifinalidad	Distintas vías de desarrollo conducen a un mismo trastorno
Multifinalidad	Un mismo factor de riesgo conduce a resultados distintos según la persona

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué supuestos definen cada modelo, la autoría de los modelos integradores y la diferencia entre equifinalidad y multifinalidad a partir de un caso. Trampas típicas: confundir equifinalidad con multifinalidad, atribuir el modelo de vulnerabilidad-estrés a Engel y leer la heredabilidad como el porcentaje del trastorno de una persona que se debe a los genes.

Autoevaluación

1. Interpretar un síntoma como satisfacción parcial de un deseo y defensa contra él es propio del modelo…
a) conductual
b) cognitivo
c) psicodinámico

2. Una heredabilidad media de ≈49 % (Polderman et al., 2015) significa que…
a) en cada persona, la mitad de cada rasgo procede de los genes
b) cerca de la mitad de las diferencias entre personas se asocia a la genética
c) los rasgos dependen sobre todo de un único gen principal

3. En el modelo ABC de Ellis, la letra B corresponde a…
a) las creencias sobre el acontecimiento
b) la conducta observable de la persona
c) las bases biológicas del malestar

4. Según Zubin y Spring (1977), una persona muy vulnerable sometida a poco estrés…
a) no puede presentar un episodio porque el estrés es bajo
b) puede presentar un episodio si ese estrés supera su umbral
c) presentará un episodio permanente e irreversible

5. El maltrato infantil se asocia en unas personas a depresión, en otras a consumo de sustancias y en otras a ningún trastorno. Es un ejemplo de…
a) equifinalidad
b) comorbilidad
c) multifinalidad

Soluciones

1 c. Es la formación de compromiso del modelo psicodinámico. **2 b.** La heredabilidad describe la variabilidad en una población, no a un individuo, y la arquitectura es poligénica. **3 a.** Las creencias median entre el acontecimiento (A) y las consecuencias (C). **4 b.** Cuanto mayor es la vulnerabilidad, más bajo es el umbral; además, los episodios son temporales. **5 c.** Un mismo factor con resultados distintos; la equifinalidad es lo contrario.

Capítulo 2 · Clasificar y diagnosticar: del DSM-5-TR y la CIE-11 a las dimensiones

Para hablar de trastornos mentales con un lenguaje común hacen falta clasificaciones. Este capítulo estudia los dos sistemas que se usan hoy, el DSM-5-TR y la CIE-11, cómo han llegado a ser lo que son y en qué se diferencian. Después revisa sus límites y las propuestas que intentan superarlos: los modelos dimensionales, jerárquicos y transdiagnósticos.

Unidad 3 · Los sistemas de clasificación: DSM-5-TR y CIE-11

Objetivos: explicar las funciones del diagnóstico y distinguir fiabilidad y validez; describir la evolución histórica del DSM y de la CIE y el giro que supuso el DSM-III; conocer la organización y las novedades del DSM-5-TR y de la CIE-11; comparar ambos sistemas y valorar las críticas al modelo categorial.

3.1 Para qué sirve diagnosticar y cómo han evolucionado los sistemas

Una **clasificación** es un sistema ordenado de categorías. El **diagnóstico** es el acto de aplicar esa clasificación a un caso concreto. La **nosología** es la disciplina que estudia cómo construir las clasificaciones. Clasificar no explica por qué alguien sufre, pero ordena la información.

Las funciones principales del diagnóstico son cinco:

1. **Comunicación.** Una etiqueta compartida resume mucha información. «Trastorno de pánico» orienta a cualquier profesional sobre lo que le ocurre a la persona.
2. **Investigación.** Comparar estudios exige participantes que cumplan los mismos criterios.
3. **Pronóstico.** Saber qué categoría encaja ayuda a prever el curso más probable.
4. **Decisión terapéutica.** Muchos tratamientos se han probado en grupos definidos por su diagnóstico.
5. **Estadística sanitaria.** Los servicios de salud cuentan casos y planifican recursos con códigos diagnósticos.

Dos propiedades deciden si una clasificación es buena. La **fiabilidad** es el grado de acuerdo entre clínicos que evalúan a la misma persona; se mide con índices como el **kappa** de Cohen, que descuenta el acuerdo esperable por azar. La **validez** es que la categoría corresponda a algo real y útil: que agrupe a personas con causas, curso o respuesta al tratamiento parecidos. Un sistema puede ser fiable y poco válido. Si todos los clínicos aplican la misma etiqueta equivocada, el acuerdo es alto, pero la etiqueta no informa de nada. La fiabilidad es necesaria para la validez, pero no suficiente.

Hay dos grandes sistemas. El **DSM** (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) lo elabora la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). La **CIE** (Clasificación Internacional de Enfermedades) la elabora la Organización Mundial de la Salud (OMS) y abarca todas las enfermedades, no solo las mentales. Como muestra la figura 3.1, ambos han evolucionado en paralelo y con influencias mutuas.

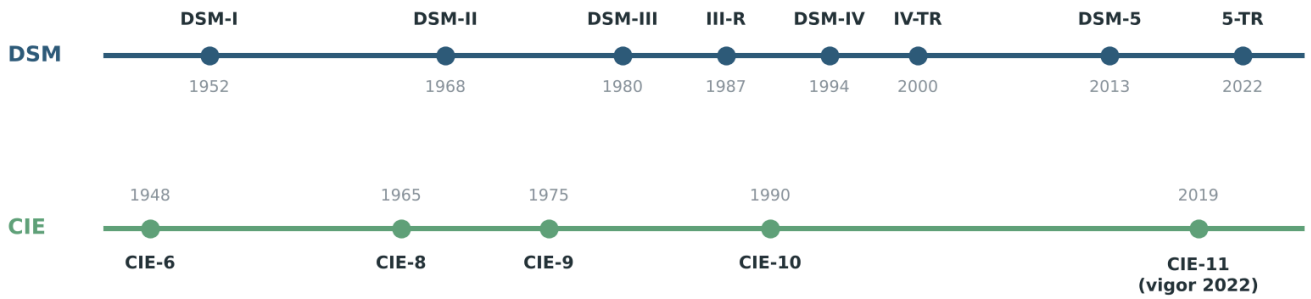


Figura 3.1. **Cronología del DSM y de la CIE.** Ediciones del DSM, de 1952 a 2022, y de la CIE, desde la CIE-6 (1948), la primera con un capítulo de trastornos mentales, hasta la CIE-11 (aprobada en 2019 y en vigor desde 2022). Elaboración propia.

El **DSM-I** (1952) y el **DSM-II** (1968) eran manuales breves, con descripciones en prosa e influidos por el concepto de «reacción» de Adolf Meyer y por el psicoanálisis; conservaban términos como «neurosis». El DSM-II se alineó con la CIE-8 (1965). Sus descripciones eran vagas y la fiabilidad, baja: el mismo paciente podía recibir diagnósticos distintos según el clínico o el país.

El **DSM-III** (1980) fue el gran giro. Tomó como antecedentes los criterios de Feighner y los criterios diagnósticos de investigación (RDC) del grupo de Spitzer, e introdujo tres cambios:

- **Criterios operativos explícitos**: lista de síntomas, número mínimo que debe cumplirse, duración y criterios de exclusión.
- **Enfoque descriptivo y ateórico**: los trastornos se definen por lo observable, sin suponer una causa. «Ateórico» no significa libre de supuestos, sino neutral respecto a las escuelas.
- **Sistema multiaxial** de cinco ejes: I, trastornos clínicos; II, trastornos de la personalidad y retraso mental; III, enfermedades médicas; IV, problemas psicosociales y ambientales; V, evaluación global del funcionamiento.

La fiabilidad mejoró mucho; la validez sigue siendo el problema central. Siguieron el DSM-III-R (1987), el DSM-IV (1994) y el DSM-IV-TR (2000). El **DSM-5** (2013) **eliminó el sistema multiaxial** y la división entre ejes I y II, agrupó los trastornos por espectros y por ciclo vital, y creó una Sección III para modelos y afecciones que requieren más estudio. En la CIE, la CIE-9 (1975) y la CIE-10 (aprobada en 1990, con su volumen de trastornos mentales en 1992) dieron paso a la CIE-11.

3.2 El DSM-5-TR (2022): organización, novedades y Sección III

El **DSM-5-TR** se publicó el 18 de marzo de 2022. Es una **revisión del texto** del DSM-5, no una edición nueva: mantiene la estructura de 2013 y actualiza las descripciones, la prevalencia, los factores de riesgo y algunos criterios (First et al., 2023).

Organización. El manual tiene tres secciones:

Sección	Contenido
I	Fundamentos: uso del manual, definición de trastorno mental, advertencias para el uso forense
II	Criterios diagnósticos y códigos, organizados en capítulos por espectros y desde el neurodesarrollo
III	Instrumentos de evaluación, formulación cultural, modelo alternativo de la personalidad y afecciones para estudio

Los capítulos empiezan por el neurodesarrollo y sitúan juntos los trastornos afines, como ansiedad, obsesivo-compulsivos y trauma.

Novedades del DSM-5-TR. Las principales son estas:

- **Trastorno de duelo prolongado**, nuevo diagnóstico en el capítulo de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Se exige que hayan pasado al menos 12 meses desde la muerte (6 meses en menores) (Unidad 9).
- **Trastorno del estado de ánimo no especificado**, para cuadros afectivos que no encajan aún en el grupo depresivo ni en el bipolar (Unidad 10).
- **Trastorno neurocognitivo leve inducido por estimulantes**.
- **Códigos de síntoma** para la **conducta suicida** y la **autolesión no suicida**, actual o como antecedente. Están en «Otras afecciones que pueden ser objeto de atención clínica» y pueden usarse sin otro diagnóstico. Así, el riesgo queda registrado aunque la persona no cumpla criterios de ningún trastorno.
- **Aclaraciones de criterios** en más de 70 trastornos. Por ejemplo, se precisa que los síntomas subumbrales ante un estresor se codifican como trastorno de adaptación.
- **Cambios de nombre**: «trastorno depresivo persistente», sin «distimia» como sinónimo; «trastorno de ansiedad social», sin «fobia social»; «trastorno de síntomas neurológicos funcionales (trastorno de conversión)»; «antipsicóticos» en lugar de «neurolépticos». En la disforia de género se habla de «género experimentado» y «género asignado al nacer».
- **Revisión de equidad**: un grupo de trabajo sobre equidad etnorracial revisó el texto para evitar sesgos y estereotipos al describir la prevalencia y los factores culturales.

La Sección III. Recoge lo que todavía no se considera listo para el uso clínico ordinario o lo que complementa el diagnóstico categorial. Incluye medidas de evaluación, la entrevista de formulación cultural, el **modelo alternativo de los trastornos de la personalidad** (AMPD; Unidades 4 y 12) y las **afecciones que necesitan más estudio**, como el trastorno por juego en internet (Unidad 15). Que algo esté en la Sección III significa que no es un diagnóstico oficial del manual.

El DSM-5-TR no recupera el sistema multiaxial: los factores psicosociales se registran con los códigos de «otras afecciones que pueden ser objeto de atención clínica».

Un ejemplo: Marta, de 34 años, tuvo un intento de suicidio hace meses y hoy no cumple criterios de ningún trastorno. Con el DSM-5-TR puede anotarse ese antecedente, que antes podía perderse en la historia clínica.

3.3 La CIE-11 (vigente desde 2022)

La **CIE-11** fue aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019 y está **en vigor desde el 1 de enero de 2022**. Los trastornos mentales se agrupan en el **capítulo 6**: trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Las **CDDR** (descripciones clínicas y requisitos diagnósticos), el texto completo para uso clínico, se publicaron en 2024 (Reed et al., 2019; OMS, 2024).

Características esenciales en lugar de recuentos. La CIE-11 describe para cada trastorno sus **características esenciales**, los rasgos que deben estar presentes, y deja margen al **juicio clínico**. En general evita umbrales numéricos arbitrarios, como «cinco de nueve síntomas», salvo cuando hay justificación empírica. Algunas duraciones sí se mantienen, como las dos semanas del episodio depresivo. Las descripciones incluyen también los límites con la normalidad y los rasgos culturales.

Enfoque de ciclo vital. Desaparece el capítulo de trastornos de la infancia. Cada trastorno describe cómo se presenta en la niñez, la adolescencia y la vejez.

Dimensiones dentro del sistema. La CIE-11 incorpora elementos dimensionales en su sistema oficial:

- En **personalidad**, sustituye los tipos por un diagnóstico de gravedad (leve, moderado, grave) con especificadores de cinco dominios de rasgos y un especificador de patrón límite (Unidad 12).
- En **psicosis**, la esquizofrenia **pierde los subtipos** y se añaden descriptores de síntomas para valorar la intensidad de cada dimensión (Unidad 11).

Categorías nuevas o reubicadas. Entre otras, la **catatonía** como agrupación propia; el **bipolar II**; en el grupo obsesivo-compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, el **síndrome de referencia olfativa**, la acumulación, la

excoriación y la **hipocondría**; el **TEPT complejo** y el **duelo prolongado**; el trastorno por atracón y el ARFID; la disforia de integridad corporal; el **trastorno por videojuegos**; el trastorno de **conducta sexual compulsiva**; el explosivo intermitente y el trastorno disfórico premenstrual. El **trastorno de distrés corporal** sustituye a la mayoría de los antiguos trastornos somatomorfos (la hipocondría pasa al grupo obsesivo-compulsivo) (Unidad 14).

Lo que sale del capítulo de trastornos mentales. La **reacción de estrés agudo** deja de ser un trastorno y pasa a los factores que influyen en el estado de salud: se entiende como una respuesta esperable ante un suceso extremo. Los trastornos del **sueño-vigilia** y las afecciones relacionadas con la **salud sexual** tienen capítulos propios. La **incongruencia de género** se sitúa en el capítulo de salud sexual, **fuera de los trastornos mentales**, para reducir el estigma sin dejar de dar acceso a la atención sanitaria (Unidad 13).

Rasgo	CIE-10	CIE-11
Formato	Descripciones y pautas	Características esenciales y requisitos diagnósticos (CDDR)
Infancia	Capítulo propio de trastornos infantiles	Enfoque de ciclo vital en cada trastorno
Personalidad	Tipos específicos	Gravedad + dominios de rasgos
Esquizofrenia	Con subtipos	Sin subtipos, con descriptores de síntomas
Reacción de estrés agudo	Trastorno	No es trastorno

Un ejemplo de esta flexibilidad: ante un adolescente con preocupación constante, tensión e insomnio desde hace meses, el clínico no cuenta síntomas; valora si están las características esenciales de la ansiedad generalizada y si causan malestar o deterioro.

3.4 DSM frente a CIE, uso en España y críticas al modelo categorial

Diferencias clave. Ambos sistemas son categoriales, pero difieren en formato y en decisiones concretas. El DSM-5-TR usa **criterios operativos** con recuentos y duraciones; la CIE-11, **características esenciales** flexibles pensadas para la práctica clínica. Como muestra la figura 3.2, las diferencias de contenido se concentran en unos pocos trastornos.

	DSM-5-TR (2022)	CIE-11 (2022)
Enfoque	Criterios operativos con recuentos y duraciones	Características esenciales y flexibilidad clínica
Personalidad	10 TP categoriales (grupos A, B, C)	Gravedad + 5 dominios + patrón límite
TEPT complejo	No existe	Sí
Estrés agudo	Trastorno (3 días-1 mes)	No es trastorno mental
Duelo prolongado	≥ 12 meses	> 6 meses
Videojuegos	Sección III (en estudio)	Diagnóstico oficial
Género	Disforia de género (en el manual)	Incongruencia de género (fuera de trastornos mentales)

Figura 3.2. **DSM-5-TR frente a CIE-11.** Comparación de enfoque y de decisiones concretas: personalidad, TEPT complejo, estrés agudo, duelo prolongado, videojuegos e incongruencia de género. Elaboración propia.

Las duraciones son una fuente habitual de preguntas y confusiones:

Trastorno	DSM-5-TR	CIE-11
Estrés agudo	3 días-1 mes	No es trastorno
TEPT	Más de 1 mes	Varias semanas
Duelo prolongado	12 meses o más (6 en menores)	Más de 6 meses
Episodio depresivo	2 semanas o más	2 semanas o más
Hipomanía / manía	4 días / 7 días o más	Varios días / 1 semana o más
Esquizofrenia	6 meses o más (1 mes de fase activa)	1 mes o más
Esquizofreniforme	1-6 meses	No existe
Psicótico breve / agudo y transitorio	1 día-1 mes	Hasta 3 meses
Delirante	1 mes o más	3 meses o más

Uso en España. En el Sistema Nacional de Salud, la codificación oficial de los diagnósticos sigue siendo la **CIE-10-ES**, desde 2016. No hay fecha oficial de implantación de la CIE-11. En la clínica, la docencia y la investigación se usan mucho los criterios del DSM, así que conviene conocer ambos.

Críticas al modelo categorial. Las principales son cuatro:

- **Comorbilidad masiva.** Muchas personas cumplen criterios de varios trastornos a la vez, sobre todo de ansiedad y depresión. Puede indicar que las categorías dividen en trozos un mismo problema de fondo.
- **Heterogeneidad.** Dos personas con el mismo diagnóstico pueden parecerse poco. En la depresión mayor, que exige cinco de nueve síntomas, dos pacientes pueden coincidir en un solo criterio, e incluso ese puede

manifestarse en sentidos opuestos: insomnio en uno, hipersomnia en otro.

- **Umbrales arbitrarios.** ¿Por qué cinco síntomas y no cuatro? Quien cumple cuatro puede sufrir casi lo mismo que quien cumple cinco, pero queda fuera.
- **Uso masivo de las categorías residuales.** Las etiquetas «no especificado» u «otro especificado» se usan mucho porque muchos cuadros reales no encajan en las categorías.

A ello se suman el **estigma** y la **cosificación**: tratar la etiqueta como una entidad natural. Las ventajas también son reales: comunicación sencilla y decisiones de sí o no, como tratar o ingresar. Las críticas no llevan a abandonar las categorías, sino a completarlas con dimensiones, como se ve en la Unidad 4. Los instrumentos de entrevista diagnóstica, como la SCID-5, se estudian en Evaluación Psicológica.

Consenso y debate

Consenso: las clasificaciones son herramientas útiles para comunicar, investigar y decidir, no catálogos de entidades naturales con límites nítidos. El DSM-III (1980) mejoró la fiabilidad con criterios operativos, pero la validez sigue siendo el problema central. La CIE-11 está en vigor desde 2022 y el DSM-5-TR es una revisión del texto del DSM-5.

Debate: cuánto margen debe dejarse al juicio clínico frente a los criterios operativos, si la flexibilidad de la CIE-11 reduce la fiabilidad en la práctica, y si decisiones como sacar la reacción de estrés agudo de los trastornos mentales o incluir el trastorno por videojuegos están suficientemente justificadas.

Mito frecuente

Mito: «La CIE-11 funciona igual que el DSM: cada trastorno tiene una lista cerrada de síntomas, un número mínimo y un plazo exacto».

Realidad: la CIE-11 describe características esenciales con flexibilidad clínica y en general evita los recuentos y umbrales numéricos, salvo cuando hay justificación empírica (Reed et al., 2019). Algunas duraciones se mantienen, pero el clínico valora el cuadro completo en lugar de contar síntomas.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Fiabilidad diagnóstica	Grado de acuerdo entre clínicos que evalúan al mismo caso; se mide con el índice kappa
Validez diagnóstica	Grado en que una categoría corresponde a algo real y útil (causas, curso, tratamiento)
Criterios operativos	Síntomas, número mínimo, duración y exclusiones explícitos; introducidos por el DSM-III (1980)
Sistema multiaxial	Registro en cinco ejes del DSM-III y el DSM-IV; eliminado por el DSM-5 (2013)
Sección III	Parte del DSM con medidas, formulación cultural, AMPD y afecciones para estudio
Características esenciales	Rasgos centrales de un trastorno en la CIE-11, aplicados con juicio clínico
CDDR	Descripciones clínicas y requisitos diagnósticos de la CIE-11, publicadas en 2024

Concepto	Definición
CIE-10-ES	Clasificación con la que se codifican oficialmente los diagnósticos en el SNS desde 2016

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué aportó el DSM-III, qué eliminó el DSM-5, qué novedades trae el DSM-5-TR y en qué difiere la CIE-11 (TEPT complejo, estrés agudo, personalidad, duelo prolongado). Trampas típicas: creer que el DSM-5-TR es el DSM-6 o que mantiene los ejes, creer que la CIE-11 fija recuentos como el DSM y confundir los 12 meses del duelo prolongado del DSM-5-TR con los 6 de la CIE-11.

Autoevaluación

1. ¿Qué edición del DSM introdujo los criterios operativos y el sistema multiaxial?
a) El DSM-III (1980)
b) El DSM-II (1968)
c) El DSM-IV (1994)

2. Que todos los clínicos coincidan al aplicar una etiqueta indica, sobre todo, que el diagnóstico es…
a) válido
b) fiable
c) etiológico

3. ¿Cuál de estas es una novedad del DSM-5-TR?
a) La recuperación del sistema multiaxial
b) El diagnóstico de TEPT complejo
c) El trastorno de duelo prolongado

4. En la CIE-11, la reacción de estrés agudo…
a) exige síntomas durante 3 días a 1 mes
b) deja de considerarse un trastorno mental
c) se integra en el TEPT complejo

5. En el Sistema Nacional de Salud español, los diagnósticos se codifican oficialmente con…
a) el DSM-5-TR
b) la CIE-11
c) la CIE-10-ES

Soluciones

1 a. El DSM-III (1980) introdujo criterios explícitos y cinco ejes, y mejoró la fiabilidad. **2 b.** El acuerdo entre jueces es fiabilidad; una etiqueta fiable puede no ser válida. **3 c.** El duelo prolongado es nuevo en el DSM-5-TR; el TEPT complejo solo existe en la CIE-11 y los ejes desaparecieron en 2013. **4 b.** Pasa a los factores que influyen en el estado de salud; los 3 días a 1 mes corresponden al trastorno de estrés agudo del DSM. **5 c.** Se usa desde 2016 y no hay fecha oficial para implantar la CIE-11.

Unidad 4 · Más allá de las categorías: modelos dimensionales y transdiagnósticos

Objetivos: explicar los argumentos a favor de los modelos dimensionales; describir el factor p y la estructura jerárquica de HiTOP; diferenciar RDoC como marco de investigación y presentar el modelo alternativo de la personalidad; identificar los principales procesos transdiagnósticos y las propuestas para el futuro DSM.

4.1 Problemas del modelo categorial y argumentos dimensionales

Un modelo **categorial** decide si algo está presente o ausente: se tiene un trastorno o no se tiene. Un modelo **dimensional** sitúa a cada persona en un continuo, con más o menos intensidad de un rasgo o de un síntoma. La tensión entre ambos no es nueva, pero en las últimas décadas los datos se han inclinado hacia las dimensiones. El consenso actual es que la psicopatología es **mayoritariamente dimensional**: las categorías son herramientas útiles, no entidades naturales con límites nítidos.

Los problemas que se vieron en la Unidad 3 son el punto de partida:

- La **comorbilidad** es la norma y no la excepción. Si dos trastornos aparecen juntos tan a menudo, quizá comparten un mismo proceso de fondo.
- La **heterogeneidad** dentro de cada categoría hace que personas con el mismo diagnóstico tengan perfiles muy distintos.
- Los **umbrales** son convenciones. Quien queda justo por debajo puede necesitar ayuda tanto como quien queda justo por encima.
- Las **categorías residuales** se usan tanto que revelan que la clasificación no recoge bien los casos reales.

A estos problemas se añade un argumento de fondo. Si los trastornos fueran categorías naturales, cabría esperar **«zonas de rareza»** entre ellos: pocos casos intermedios entre un trastorno y otro, o entre el trastorno y la normalidad. Los análisis de los grupos de trabajo del futuro DSM concluyen que esas zonas no aparecen con claridad (Öngür et al., 2026). Lo habitual es una gradación continua.

Las ventajas que se atribuyen a los modelos dimensionales son varias:

Aspecto	Modelo categorial	Modelo dimensional
Información	Se pierde al reducir a sí o no	Se conserva la intensidad
Casos subumbral	Quedan fuera	Se registran
Comorbilidad	Muchos diagnósticos a la vez	Perfiles en varias dimensiones
Decisiones clínicas	Directas (tratar o no)	Exigen fijar puntos de corte
Comunicación	Sencilla, con una etiqueta	Más compleja

La tabla muestra también el precio de las dimensiones: para decidir si se trata o se ingresa a alguien hace falta, al final, un punto de corte. Por eso las propuestas actuales no eliminan las categorías, sino que buscan **combinarlas** con dimensiones.

El cambio ya está en los manuales. La comparación siguiente resume dónde aparecen hoy los elementos dimensionales:

Elemento	DSM-5-TR	CIE-11
Personalidad	Diez TP categoriales; el modelo dimensional (AMPD), solo en la Sección III	Gravedad y cinco dominios de rasgos como sistema oficial

Elemento	DSM-5-TR	CIE-11
Psicosis	Cinco dominios de síntomas definen el espectro	Esquizofrenia sin subtipos, con descriptores de síntomas
Gravedad	Especificadores de gravedad en muchos trastornos	Gravedad en personalidad y en distrés corporal, entre otros
Organización	Capítulos por espectros	Agrupaciones con enfoque de ciclo vital

Un ejemplo cotidiano ayuda a verlo. La tensión arterial es una variable continua, y la «hipertensión» es un punto de corte acordado porque a partir de cierto valor conviene tratar. Muchos autores proponen entender así la ansiedad o la depresión: dimensiones continuas con umbrales prácticos, no enfermedades que se tienen o no se tienen.

4.2 El factor p y la taxonomía jerárquica HiTOP

El factor p. Caspi et al. (2014) analizaron los síntomas de los participantes de la cohorte de Dunedin (Nueva Zelanda), seguidos durante décadas. Con un **modelo bifactorial** encontraron que la covariación entre trastornos se explicaba bien con un **factor general de psicopatología**, que llamaron **p**, más tres factores específicos: **internalizante**, **externalizante** y de **trastorno del pensamiento**. Como muestra la figura 4.1, p se conecta con todos los trastornos y cada factor específico, solo con los suyos.

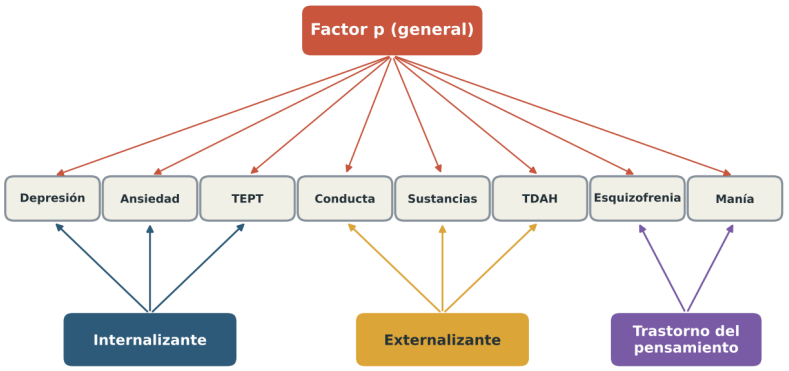


Figura 4.1. **Modelo bifactorial del factor p.** Un factor general (p) se conecta con todos los trastornos observados; los factores internalizante, externalizante y de trastorno del pensamiento explican lo que comparten los trastornos de cada grupo. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

La analogía es el **factor g** de inteligencia: igual que quien rinde bien en una prueba cognitiva tiende a rendir bien en otras, quien presenta un trastorno tiende a presentar otros. Una implicación importante es que, si buena parte del riesgo es general, será difícil encontrar **causas o biomarcadores específicos** de cada trastorno: muchos factores de riesgo elevarían p, no un diagnóstico concreto.

El factor p está en **debate**. Para unos autores es una dimensión sustantiva, quizá relacionada con la regulación emocional o con el deterioro general. Para otros es en parte un **artefacto estadístico**: el modelo bifactorial tiende a ajustar bien casi cualquier conjunto de datos correlacionados. Caspi et al. (2024) revisaron las distintas interpretaciones sin cerrar la cuestión.

HiTOP. La **taxonomía jerárquica de la psicopatología** (*Hierarchical Taxonomy of Psychopathology*; Kotov et al., 2017) es una clasificación construida a partir de los datos: agrupa los síntomas según cómo covarían realmente, no según la tradición clínica. Como muestra la figura 4.2, se organiza en niveles, de lo más general a lo más específico.

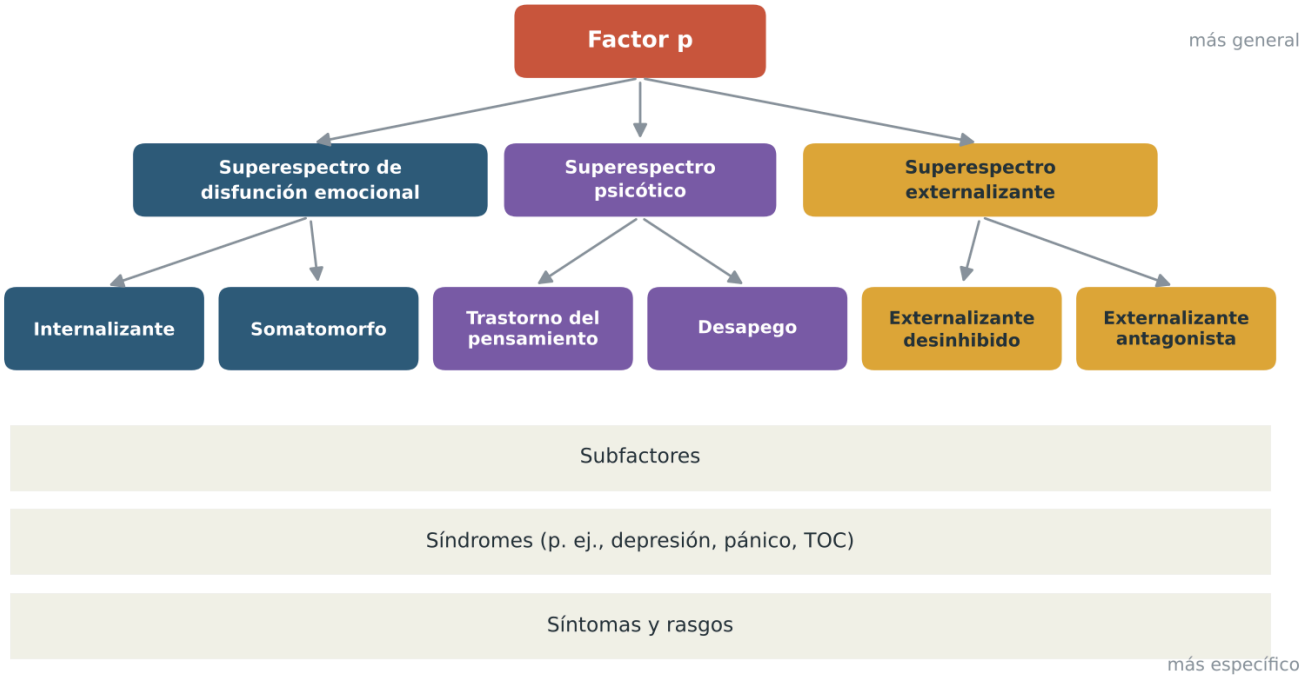


Figura 4.2. **Estructura jerárquica de HiTOP.** De arriba abajo: factor p, superespectros, seis espectros (internalizante, trastorno del pensamiento, desapego, externalizante desinhibido, externalizante antagonista y somatomorfo), síndromes y, en la base, síntomas y rasgos. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Los niveles son:

1. **Factor p**, en la cúspide.
2. **Superespectros**, agrupaciones amplias de espectros.
3. **Espectros**: seis grandes dimensiones.
4. **Subfactores** y **síndromes**, que se parecen a los trastornos tradicionales.
5. **Componentes o síntomas** y **rasgos**, en la base.

Espectro	Ejemplos de lo que agrupa
Internalizante	Ansiedad, depresión, malestar emocional
Trastorno del pensamiento	Síntomas psicóticos, rasgos esquizotípicos
Desapego	Retraimiento social, afecto restringido
Externalizante desinhibido	Impulsividad, consumo de sustancias
Externalizante antagonista	Hostilidad, manipulación, conducta antisocial
Somatomorfo	Síntomas corporales sin explicación médica suficiente

La principal fortaleza de HiTOP es su **validez estructural**: refleja cómo se agrupan de verdad los síntomas. Su punto débil está en debate: la **utilidad clínica**. Los profesionales están formados para pensar en categorías, y no está claro cómo se traduce un perfil en seis espectros en decisiones concretas de tratamiento.

4.3 RDoC y el modelo alternativo de los trastornos de la personalidad

RDoC. Los **criterios de dominios de investigación** (*Research Domain Criteria*) los propuso el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH; Insel et al., 2010). Lo primero que hay que saber es que **RDoC no es un sistema diagnóstico**, sino un **marco de investigación**. En lugar de partir de los trastornos del DSM, parte

de **funciones** psicológicas y biológicas básicas y estudia cómo varían, de lo normal a lo patológico, en distintos **niveles de análisis**.

RDoC se organiza como una **matriz**. Las filas son **dominios funcionales**, cada uno con varios constructos; las columnas son **unidades de análisis**: genes, moléculas, células, circuitos, fisiología, conducta, autoinforme y paradigmas experimentales. La tabla resume los dominios con un constructo de ejemplo y cómo se estudiaría en algunas unidades:

Dominio	Constructo de ejemplo	Circuitos	Conducta o paradigma	Autoinforme
Sistemas de valencia negativa	Amenaza aguda (miedo)	Amígdala	Respuesta de sobresalto	Escalas de miedo
Sistemas de valencia positiva	Respuesta a la recompensa	Estriado ventral	Tareas de esfuerzo por recompensa	Escalas de anhedonia
Sistemas cognitivos	Memoria de trabajo	Corteza prefrontal dorsolateral	Tarea n-back	Quejas de memoria
Procesos sociales	Percepción de los demás	Redes de cognición social	Reconocimiento de emociones faciales	Escalas de funcionamiento social
Sistemas de *arousal* y regulación	Ritmos circadianos y sueño	Circuitos del sueño-vigilia	Actigrafía	Diarios de sueño
Sistemas sensoriomotores (añadido después)	Control motor	Circuitos motores	Tareas de tiempo de reacción	—

La idea es que un mismo constructo, como la sensibilidad a la amenaza, puede estar alterado en personas con diagnósticos distintos (pánico, TEPT, fobias), y estudiarlo directamente puede ser más fructífero que comparar grupos definidos por el DSM. Las bases biológicas de cada circuito se estudian en Psicología Fisiológica. Su límite es que no ofrece por ahora herramientas para el diagnóstico clínico.

El modelo alternativo de los trastornos de la personalidad (AMPD). Está en la Sección III del DSM-5 y del DSM-5-TR, como alternativa al modelo categorial de diez trastornos. Tiene dos criterios principales:

- **Criterio A: deterioro del funcionamiento de la personalidad**, en dos áreas. La del **self** incluye la **identidad** y la **autodirección**; la **interpersonal**, la **empatía** y la **intimidad**. Se valora con la **Escala de nivel de funcionamiento de la personalidad** (LPFS).
- **Criterio B: rasgos patológicos**, 25 facetas agrupadas en cinco dominios: **afectividad negativa**, **desapego**, **antagonismo**, **desinhibición** y **psicoticismo**. Se evalúan, por ejemplo, con el inventario PID-5 (Evaluación Psicológica).

El AMPD conserva seis trastornos definidos con esta lógica (antisocial, evitativo, límite, narcisista, obsesivo-compulsivo y esquizotípico) y añade el **trastorno de la personalidad con rasgos especificados** para los demás casos. Los cinco dominios guardan relación con los Cinco Grandes de la personalidad normal, que se estudian en Psicología de la Personalidad. El modelo, su comparación con la CIE-11 y los trastornos concretos se desarrollan en la Unidad 12.

4.4 Procesos transdiagnósticos y el futuro del DSM

Un **proceso transdiagnóstico** es un mecanismo psicológico que aparece en varios trastornos y contribuye a mantenerlos. En lugar de preguntar «qué trastorno tiene», se pregunta «qué procesos mantienen su malestar».

Los más estudiados son:

Proceso	Qué es	Dónde aparece
Rumiación y preocupación	Pensamiento negativo repetitivo, sobre el pasado o sobre el futuro	Depresión, TAG, TEPT, insomnio
Evitación experiencial	Intentos de no sentir emociones, pensamientos o sensaciones molestas	Ansiedad, TOC, consumo de sustancias
Intolerancia a la incertidumbre	Vivir lo incierto como inaceptable y amenazante	TAG, TOC, ansiedad social
Perfeccionismo	Exigencia excesiva con autocrítica intensa ante los fallos	TCA, TOC, depresión
Déficits de regulación emocional	Dificultad para modular la intensidad y la duración de las emociones	TLP, depresión, sustancias
Sesgos atencionales	Atención preferente a lo amenazante o negativo	Trastornos de ansiedad, depresión

En la base de muchos de ellos está el **neuroticismo**, la tendencia estable a experimentar emociones negativas. Un ejemplo: Lucía tiene ansiedad social y Andrés, depresión. Parecen problemas distintos, pero ambos dan vueltas durante horas a lo que hicieron mal y evitan situaciones por miedo a sentirse peor. Intervenir sobre la rumiación y la evitación puede ayudar a los dos. Esta lógica ha dado lugar a tratamientos como el **protocolo unificado** de Barlow, que se estudia en las asignaturas de Tratamientos e Intervención. La rumiación y la intolerancia a la incertidumbre se retoman en las Unidades 7 y 10.

El futuro del DSM. En marzo de 2024 la APA aprobó un **comité estratégico** para el futuro del DSM, activo desde mayo de ese año y presidido por Maria Oquendo. Sus propuestas, publicadas en el *American Journal of Psychiatry* entre 2025 y 2026, son estas (Oquendo et al., 2026; Öngür et al., 2026):

- Un modelo de **cuatro dominios interactivos**: factores **contextuales**, **diagnósticos**, **biológicos** (incluidos posibles biomarcadores) y **rasgos transdiagnósticos**.
- Un **«documento vivo»**, que se actualice de forma continua cuando haya evidencia, en lugar de grandes ediciones cada muchos años.
- **Combinar categorías y dimensiones** con distintos niveles de especificidad. El subcomité de Estructura y Dimensiones, dirigido por Dost Öngür, propone poder diagnosticar en un nivel amplio («psicosis») o en uno más concreto («esquizofrenia») según la información disponible.
- La posibilidad de cambiar la «S» de *Statistical* por *Scientific* en el nombre del manual.

Todo esto son **propuestas**, no un manual. No existe un «DSM-6» ni hay fecha para un nuevo DSM. El manual vigente es el DSM-5-TR (2022). La dirección, en cualquier caso, es clara: un sistema que conserve categorías útiles para decidir y que integre dimensiones, procesos comunes y contexto.

Consenso y debate

Consenso: la psicopatología es mayoritariamente dimensional y muy comórbida; las categorías son útiles para decidir, pero no tienen límites nítidos. Existen procesos transdiagnósticos que contribuyen a mantener varios trastornos. RDoC es un marco de investigación, no un sistema diagnóstico.

Debate: si el factor p es una dimensión sustantiva o en parte un artefacto del modelo bifactorial (Caspi et al., 2014, 2024); si HiTOP, con alta validez estructural, tiene utilidad clínica suficiente (Kotov et al., 2017); y cómo se concretarán las propuestas del comité estratégico para el futuro DSM.

Mito frecuente

Mito: «El DSM-5-TR es el DSM-6, y el próximo manual ya está publicado con un sistema totalmente dimensional».

Realidad: el DSM-5-TR (APA, 2022) es una revisión del texto del DSM-5. Para el futuro solo hay propuestas del comité estratégico creado en 2024, publicadas entre 2025 y 2026, que plantean un «documento vivo» y combinar categorías y dimensiones (Oquendo et al., 2026). No hay un «DSM-6» ni fecha de publicación.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Modelo dimensional	Sitúa a cada persona en un continuo de intensidad en lugar de decidir presencia o ausencia
Comorbilidad	Presencia simultánea de dos o más trastornos en la misma persona
Factor p	Factor general que explica la covariación entre trastornos (Caspi et al., 2014)
HiTOP	Taxonomía jerárquica empírica, del factor p a los síntomas y rasgos (Kotov et al., 2017)
RDoC	Marco de investigación del NIMH: dominios funcionales × unidades de análisis (Insel et al., 2010)
AMPD	Modelo alternativo de TP de la Sección III: funcionamiento (criterio A) y rasgos (criterio B)
Proceso transdiagnóstico	Mecanismo presente en varios trastornos que contribuye a mantenerlos
Documento vivo	Propuesta de un DSM actualizado de forma continua en lugar de por ediciones

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué es el factor p y con qué se compara, los niveles y espectros de HiTOP, la naturaleza de RDoC y los dominios del AMPD. Trampas típicas: presentar RDoC como un sistema diagnóstico, confundir los dominios del AMPD (antagonismo, psicoticismo) con los de la CIE-11 (disocialidad, anancastia) y hablar de un «DSM-6» publicado.

Autoevaluación

1. El factor p de Caspi et al. (2014) se describe como análogo a…
a) el neuroticismo de los Cinco Grandes
b) el factor g de inteligencia
c) el criterio A del AMPD

2. ¿Cuál de estos es uno de los seis espectros de HiTOP?
a) Externalizante antagonista
b) Valencia negativa
c) Autodirección

3. RDoC se define correctamente como…
a) el sistema dimensional oficial de la CIE-11
b) la Sección III del DSM-5-TR
c) un marco de investigación del NIMH

4. ¿Cuál de estos dominios pertenece al criterio B del AMPD?
a) Anancastia
b) Disocialidad
c) Psicoticismo

5. Según las propuestas del comité estratégico sobre el futuro DSM…
a) el DSM-6 se publicó en 2025
b) el manual podría ser un documento vivo
c) se eliminarán todas las categorías

Soluciones

1 b. Igual que g explica la correlación entre pruebas cognitivas, p explica la covariación entre trastornos. **2 a.** La valencia negativa es un dominio de RDoC y la autodirección, un área del funcionamiento del AMPD. **3 c.** RDoC es un marco de investigación por dominios y unidades de análisis, no un sistema diagnóstico. **4 c.** Anancastia y disocialidad son dominios de la CIE-11. **5 b.** Se propone actualizarlo de forma continua y combinar categorías y dimensiones; no hay DSM-6.

Capítulo 3 · Psicopatología descriptiva: cuando fallan las funciones psíquicas

Antes de hablar de trastornos hay que saber describir síntomas. Este capítulo recorre las funciones psíquicas una por una (conciencia, atención, memoria, psicomotricidad, vivencia del yo, percepción, pensamiento, lenguaje y afectividad) y define con precisión sus alteraciones, que son el vocabulario básico de la exploración clínica y de los capítulos siguientes.

Unidad 5 · Conciencia, atención, memoria y psicomotricidad

Objetivos: distinguir las alteraciones cuantitativas y cualitativas de la conciencia y reconocer el delirium; describir las alteraciones de la atención y los sesgos atencionales; diferenciar los tipos de amnesia, las hipermnesias y las paramnesias; identificar las alteraciones psicomotrices, de la conciencia del yo y del insight.

5.1 Conciencia y orientación

En psicopatología, **conciencia** no tiene el sentido moral de la palabra. Designa el estado que permite darse cuenta de uno mismo y del entorno en un momento dado. La exploración clínica distingue dos ejes: el **nivel** de conciencia (cuánta claridad hay) y su **contenido o campo** (qué se capta y cómo se organiza). De ahí salen dos grupos de alteraciones.

Alteraciones cuantitativas. Afectan al nivel de alerta y forman un continuo. Por encima de la vigilia normal se sitúa la **hipervigilancia**, un estado de alerta aumentada propio de la ansiedad intensa, la manía o algunos tóxicos estimulantes. Por debajo, el descenso sigue una secuencia ordenada:

- **Obnubilación**: la persona está despierta, pero lenta, poco clara y con dificultad para captar lo que ocurre.
- **Somnolencia**: tiende a dormirse si no se la estimula, aunque se despierta con facilidad.
- **Estupor**: solo responde a estímulos intensos, y de forma breve e incompleta.
- **Coma**: no hay respuesta voluntaria ni con estímulos dolorosos.

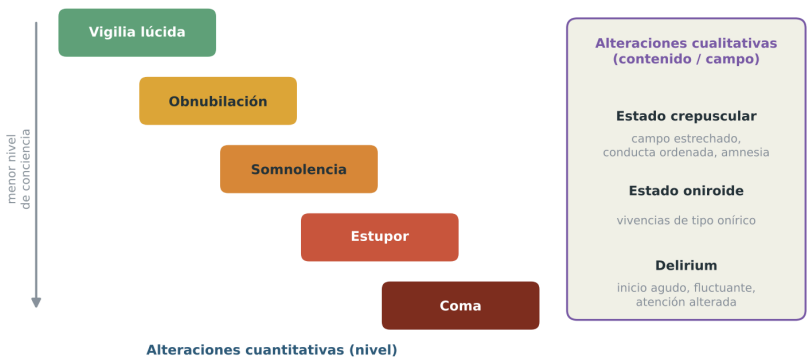


Figura 5.1. **Niveles y alteraciones de la conciencia.** A la izquierda, la escalera descendente de las alteraciones cuantitativas, de la vigilia al coma; a la derecha, las alteraciones cualitativas: estado crepuscular, estado oniroide y delirium. Elaboración propia.

Alteraciones cualitativas. Como muestra la figura 5.1, no todo es cuestión de «más» o «menos» conciencia. En las alteraciones cualitativas cambia la **organización** de lo que se capta:

- **Estado crepuscular**: el campo de la conciencia se **estrecha** sobre unas pocas vivencias. La persona puede realizar conductas que parecen ordenadas (caminar, coger un autobús) y después tiene **amnesia** del episodio. Aparece en la epilepsia y en cuadros disociativos.
- **Estado oniroide**: la vivencia se parece a un sueño; se mezclan percepciones reales con escenas imaginadas muy vívidas, a menudo con alucinaciones visuales.
- **Confusión**: el pensamiento pierde claridad y coherencia, con desorientación.

El delirium. Es el síndrome confusional por excelencia y una urgencia médica. Según el DSM-5-TR, consiste en una alteración de la **atención** y de la **conciencia del entorno** que se instaura de forma **aguda** (horas o días), **fluctúa** a lo largo del día y se acompaña de otras alteraciones cognitivas. Siempre tiene una **causa médica**, una sustancia o su abstinencia. No debe confundirse con el término «delirio» (una idea delirante; Unidad 6). Pensemos en un hombre de 80 años operado de cadera que, la segunda noche, intenta arrancarse el gotero, cree estar en su casa y ve insectos en la pared; por la mañana está tranquilo y por la tarde vuelve a empeorar. El curso fluctuante y el inicio brusco orientan hacia el delirium y obligan a buscar la causa.

Orientación. Es la capacidad de situarse respecto a uno mismo y al entorno. Se diferencian dos tipos:

Tipo	Qué explora	Pregunta típica
Autopsíquica	La propia identidad: quién es uno	«¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica?»
Alopsíquica	El tiempo y el espacio	«¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos?»

En los cuadros orgánicos, como el delirium o las demencias, suele perderse antes la orientación **temporal**, luego la **espacial** y, por último, la **autopsíquica**. En las psicosis la orientación suele conservarse, aunque puede aparecer una **doble orientación**: la persona sabe que está en un hospital y, a la vez, afirma que es un cuartel secreto donde la vigilan. Las dos versiones conviven sin que la contradicción le inquiete.

5.2 Atención

La **atención** permite seleccionar unos estímulos, mantenerse en ellos y desplazarla cuando hace falta. Los procesos normales se estudian en Atención y Percepción; aquí interesan sus alteraciones. La terminología clásica usa la raíz **prosexia** (del griego, «atención»).

Alteraciones cuantitativas:

- **Hipoprosexia**: disminución de la capacidad de atender. Es frecuente en la depresión, la fatiga, la ansiedad intensa y los cuadros orgánicos.
- **Aprosexia**: ausencia total de atención, propia de estados graves como el estupor o el delirium avanzado.
- **Hiperprosexia**: aumento de la atención, casi siempre hacia un foco concreto. Su forma más relevante es la **hipervigilancia**, el rastreo continuo del entorno en busca de peligros, típica de la ansiedad y del TEPT (Unidad 9).

Alteraciones cualitativas:

- **Distraibilidad**: la atención salta con demasiada facilidad a estímulos irrelevantes. Es característica de la **manía**: en mitad de una frase, la persona se fija en el reloj del entrevistador y cambia de tema (Unidad 10).
- **Inatención selectiva**: se dejan de atender aspectos que resultan amenazantes o incómodos.
- **Fijación** o atención **atrapada**: la atención queda pegada a un contenido del que cuesta salir, como sucede en el TOC o en la rumiación depresiva.

Sesgos atencionales. Además de capacidad, la atención tiene **dirección**. En los trastornos de ansiedad se ha descrito de forma consistente un **sesgo atencional hacia la amenaza**: los estímulos relacionados con el peligro

captan la atención de manera preferente y rápida. Dos paradigmas experimentales son clásicos:

Paradigma	Tarea	Resultado típico en la ansiedad
Stroop emocional	Nombrar el color de la tinta de palabras neutras y amenazantes	Más lentitud con las palabras amenazantes, porque su significado interfiere
Dot-probe	Detectar una sonda que aparece donde antes había un estímulo neutro o amenazante	Respuesta más rápida cuando la sonda sustituye al estímulo amenazante

En el Stroop emocional, una persona con ansiedad social tarda más en decir «azul» ante la palabra «ridículo» escrita en azul que ante «ventana». En el *dot-probe*, la rapidez ante la sonda que ocupa el lugar de la cara enfadada indica que la atención ya estaba allí. Estos sesgos se consideran un **proceso transdiagnóstico** (Unidad 4): aparecen en varios trastornos y podrían contribuir a mantenerlos, porque quien atiende sobre todo al peligro encuentra más confirmaciones de que el mundo es peligroso.

Conviene distinguir este patrón del que se observa en la **esquizofrenia**. Aquí no hay tanto un sesgo hacia un contenido como **déficits atencionales generales**: dificultad para mantener la atención, para filtrar la información irrelevante y para procesar con rapidez, dentro de un perfil más amplio de alteraciones cognitivas (Unidad 11).

Un error habitual es pensar que la persona ansiosa atiende «peor». En sentido estricto, atiende **demasiado bien** a ciertos estímulos, y ese exceso le resta recursos para lo demás. Por eso a muchos estudiantes les cuesta concentrarse en un examen que temen: la atención está ocupada en las señales de amenaza.

5.3 Memoria

Los procesos normales de codificación, almacenamiento y recuperación se estudian en Psicología de la Memoria. Aquí se describen sus alteraciones clínicas, que se agrupan en **amnesias** (pérdida), **hipermnesias** (exceso) y **paramnesias** (distorsión).

Amnesias. Según su relación temporal con el inicio del problema (un traumatismo, una enfermedad), se distinguen:

- **Amnesia anterógrada**: incapacidad de **fijar información nueva** desde el inicio del problema. La persona olvida lo que ha comido o lo que le acaban de decir.
- **Amnesia retrógrada**: pérdida de recuerdos **anteriores** al inicio.

En la amnesia retrógrada de causa orgánica se cumple con frecuencia la **ley de Ribot**: los recuerdos **más recientes** se pierden antes y los **más antiguos** se conservan mejor. Un hombre que sufrió un traumatismo craneal no recuerda los meses previos al accidente, pero conserva con detalle los recuerdos de su boda o de su infancia.

Amnesia orgánica frente a disociativa. Es una distinción básica para el diagnóstico:

Rasgo	Amnesia orgánica	Amnesia disociativa
Causa	Lesión, enfermedad o sustancia	Suceso traumático o muy estresante
Qué se pierde	Sobre todo información nueva; gradiente de Ribot	Información **autobiográfica** importante
Fijación de información nueva	Suele estar alterada	Suele conservarse
Identidad personal	Se pierde tarde, solo en casos graves	Puede perderse (fuga disociativa)

La amnesia disociativa se estudia en la Unidad 14. Su marca es el olvido de información personal relevante, incompatible con el olvido ordinario, mientras la persona sigue aprendiendo cosas nuevas sin dificultad.

Hipermnesias. Son un recuerdo excesivo o intrusivo. La forma clínica más relevante son los **recuerdos intrusivos** del TEPT, que irrumpen sin buscarlos y con gran carga emocional (Unidad 9). Más que «recordar mejor», la persona no puede dejar de recordar.

Paramnesias. Son distorsiones del recuerdo o del reconocimiento:

- ***Déjà vu***: sensación de haber vivido ya una situación nueva. Es frecuente en la población general y no es patológica por sí misma; puede aparecer en la epilepsia del lóbulo temporal.
- ***Jamais vu***: sensación de no haber vivido nunca algo conocido.
- **Falsos reconocimientos**: identificar como conocido algo o a alguien que no lo es.
- **Criptomnesia**: un recuerdo se vive como una idea **nueva** y propia. Le ocurre a quien «inventa» una melodía que en realidad escuchó hace años.
- **Ecmnesia**: se reviven sucesos del pasado como si estuvieran ocurriendo en el presente.

Confabulación frente a pseudología fantástica. Las dos producen relatos falsos, pero su naturaleza es muy distinta. La **confabulación** consiste en rellenar las lagunas de memoria con contenidos inventados **sin intención de engañar**: la persona cree lo que dice. Es típica del **síndrome de Korsakoff**, asociado al consumo crónico de alcohol (Unidad 15). Un paciente ingresado cuenta con naturalidad que esa mañana ha ido al mercado. La **pseudología fantástica** es una **mentira patológica**: relatos elaborados, a menudo fantasiosos, que la persona construye y en parte llega a creerse, sin un déficit de memoria que los explique.

La pregunta clínica para separarlas es si existe una **laguna de memoria** que el relato está tapando. En la confabulación la hay; en la pseudología fantástica, no.

5.4 Psicomotricidad, conciencia del yo e insight

Psicomotricidad. Se refiere a la expresión motora de la vida psíquica. Sus alteraciones principales son:

- **Agitación psicomotriz**: aumento desorganizado de la actividad motora, con inquietud y a veces agresividad. Aparece en la manía, el delirium, las psicosis agudas y las intoxicaciones.
- **Inhibición o retardo psicomotor**: lentitud de movimientos, gestos y habla, típica de la depresión grave.
- **Catatonía**: síndrome que reúne alteraciones motoras muy llamativas: **estupor**, **catalepsia** (mantener posturas impuestas), **flexibilidad cérea** (el cuerpo se deja moldear como si fuera de cera), **negativismo**, mutismo, **ecolalia** y **ecopraxia** (repetir palabras o gestos ajenos), muecas, manierismos y estereotipias. Puede aparecer en psicosis, trastornos del ánimo y enfermedades médicas (Unidad 11).
- **Acatisia**: inquietud subjetiva y necesidad de moverse, como efecto adverso de los antipsicóticos (se estudia en Psicofarmacología).

Cuatro movimientos repetitivos se confunden a menudo:

Fenómeno	Rasgo esencial	Ejemplo
Estereotipia	Movimiento repetitivo **sin finalidad**	Balancearse durante horas
Manierismo	Movimiento **con finalidad**, pero hecho de forma extravagante	Saludar con un giro teatral de muñeca
Tic	Movimiento **involuntario**, súbito y breve	Parpadeo o carraspeo repentinos
Compulsión	Acto **intencional** que reduce el malestar, vivido como forzado	Lavarse las manos tras tocar un pomo (Unidad 8)

Conciencia del yo. Normalmente vivimos nuestros pensamientos y actos como propios, nuestro cuerpo como real y el mundo como familiar. En la **despersonalización** la persona se siente extraña a sí misma, como si se observara desde fuera o fuera un autómata; en la **desrealización**, lo extraño es el entorno, que parece irreal, lejano o «de cartón piedra». Lo esencial es que el **juicio de realidad se conserva**: la persona dice «es **como si**

no fuera yo», no «no soy yo». Estas vivencias son frecuentes en la ansiedad intensa y el cansancio, y constituyen un trastorno cuando son persistentes (Unidad 14). Distinto es lo que ocurre en las psicosis, donde se pierde ese «como si» y el yo se vive invadido o controlado desde fuera.

Síntomas de primer rango de Schneider. Kurt Schneider propuso una lista de vivencias que consideraba muy indicativas de esquizofrenia en ausencia de causa orgánica: sonorización o eco del pensamiento; voces que dialogan o discuten; voces que comentan los actos; vivencias de influencia corporal; inserción, robo y difusión del pensamiento; percepción delirante; y vivencias de que los sentimientos, impulsos o actos están controlados desde fuera. Muchos de ellos son alteraciones del yo: la frontera entre lo propio y lo ajeno se rompe. Hoy tienen **menos peso diagnóstico**, porque también aparecen en otros cuadros.

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Catatonía	Especificador o diagnóstico asociado a otro trastorno o afección médica (≥3 de 12 síntomas)	Agrupación diagnóstica propia
Síntomas de Schneider	El DSM-5 retiró el trato especial a las voces que comentan o dialogan	Su peso en el diagnóstico se reduce
Despersonalización/desrealización	Trastorno disociativo, con juicio de realidad conservado	Trastorno disociativo, con juicio de realidad conservado
Fuga disociativa	Especificador de la amnesia disociativa	Calificador de la amnesia disociativa

Insight. Es la **conciencia de enfermedad**: reconocer que se tiene un problema, atribuir los síntomas a ese problema y aceptar que puede necesitar ayuda. No es un todo o nada, sino una **dimensión**. Suele ser **pobre** en las psicosis y en la manía, y es variable en el TOC. Una persona con manía que duerme dos horas, gasta sus ahorros y afirma estar «mejor que nunca» muestra un insight muy bajo; esto complica la búsqueda de ayuda y la adherencia al tratamiento.

Consenso y debate

Consenso: la conciencia tiene alteraciones de nivel (de la obnubilación al coma) y de contenido (estado crepuscular, onirismo, delirium), y el delirium es un síndrome agudo y fluctuante que siempre exige buscar una causa médica. La amnesia orgánica suele afectar a la fijación de información nueva y sigue el gradiente de Ribot, mientras que la disociativa afecta a información autobiográfica. El insight es dimensional.

Debate: los síntomas de primer rango de Schneider fueron durante décadas la base del diagnóstico de esquizofrenia, pero hoy se cuestiona su especificidad, y el DSM-5 y la CIE-11 les han restado peso.

Mito frecuente

Mito: «Quien confabula está mintiendo».

Realidad: la confabulación rellena lagunas de memoria sin intención de engañar; la persona cree lo que cuenta. Es típica del síndrome de Korsakoff. La mentira patológica sin déficit de memoria es la pseudología fantástica.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Obnubilación	Descenso leve del nivel de conciencia: despierto, pero lento y con poca claridad
Estado crepuscular	Estrechamiento del campo de conciencia con conducta ordenada en apariencia y amnesia posterior
Delirium	Alteración aguda y fluctuante de la atención y la conciencia con causa médica o tóxica
Doble orientación	Coexistencia de la orientación real y de una interpretación delirante del lugar o la situación
Distraibilidad	Desplazamiento excesivo de la atención hacia estímulos irrelevantes, típico de la manía
Ley de Ribot	En la amnesia retrógrada orgánica, lo reciente se pierde antes que lo antiguo
Confabulación	Relleno de lagunas de memoria con contenidos inventados sin intención de engañar
Despersonalización	Vivencia de extrañeza de uno mismo con el juicio de realidad conservado

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la secuencia de alteraciones cuantitativas de la conciencia, la diferencia entre amnesia anterógrada y retrógrada con la ley de Ribot, la confabulación del síndrome de Korsakoff y la distinción entre estereotipia, manierismo, tic y compulsión. Trampas típicas: confundir delirium (síndrome confusional) con delirio (idea delirante), aplicar la ley de Ribot al revés y atribuir intención de engañar a la confabulación. También se pregunta qué síntomas formaban parte de la lista de Schneider.

Autoevaluación

1. Una paciente responde solo a estímulos dolorosos intensos, de forma breve e incompleta. Su nivel de conciencia corresponde a…
a) obnubilación
b) estupor
c) somnolencia

2. Tras un traumatismo craneal, un hombre ha perdido los recuerdos de los meses previos, pero recuerda bien su infancia. Es un ejemplo de…
a) la ley de Ribot
b) amnesia disociativa
c) pseudología fantástica

3. En el paradigma *dot-probe*, las personas con ansiedad suelen responder más rápido cuando la sonda…
a) aparece en el centro de la pantalla
b) sustituye al estímulo neutro
c) sustituye al estímulo amenazante

4. Un movimiento repetitivo, con una finalidad reconocible pero ejecutado de forma extravagante, se denomina…
a) manierismo
b) estereotipia
c) tic

5. ¿Qué rasgo distingue la despersonalización de una alteración psicótica del yo?
a) La duración superior a un mes
b) La conservación del juicio de realidad
c) La presencia de alucinaciones visuales

Soluciones

1 b. El estupor solo cede de forma parcial ante estímulos intensos; en la somnolencia la persona se despierta con facilidad. **2 a.** En la amnesia orgánica lo reciente se pierde antes que lo antiguo. **3 c.** La atención ya estaba en la

amenaza, lo que acelera la detección de la sonda. **4 a.** La estereotipia carece de finalidad y el tic es involuntario. **5 b.** La persona vive la extrañeza «como si» y sabe que no es real.

Unidad 6 · Percepción, pensamiento, lenguaje y afectividad

Objetivos: diferenciar distorsiones, ilusiones, alucinaciones, pseudoalucinaciones y alucinosis; identificar los trastornos formales del pensamiento; definir el delirio y distinguirlo de la idea sobrevalorada y de la obsesión; describir las alteraciones del lenguaje y de la afectividad.

6.1 Percepción e imaginación

Percibir es construir una representación del mundo a partir de los sentidos; los procesos normales se estudian en Atención y Percepción. Las alteraciones se dividen en dos grandes grupos: las **distorsiones**, en las que se percibe un objeto real, pero alterado, y los **engaños perceptivos**, en los que la percepción no corresponde a lo que hay.

Distorsiones. El estímulo existe y se capta, pero cambia alguna de sus propiedades:

- De **intensidad**: hiperestesia (los sonidos o la luz resultan insoportables, como en la migraña o la resaca) e hipoestesia (todo parece apagado, como en la depresión).
- De **cualidad**: cromatopsias, en las que los objetos se ven teñidos de un color.
- De **forma** o tamaño: dismegalopsias (macropsia y micropsia: ver los objetos más grandes o más pequeños) y metamorfopsias (verlos deformados).
- De **integración**: escisión perceptiva, cuando no se integran elementos que deberían ir juntos, como la voz y la imagen de quien habla.
- Del **tiempo**: el tiempo se vive acelerado, detenido o fragmentado.

Engaños perceptivos. Aquí está el núcleo del apartado, y la figura 6.1 resume cómo diferenciarlos.

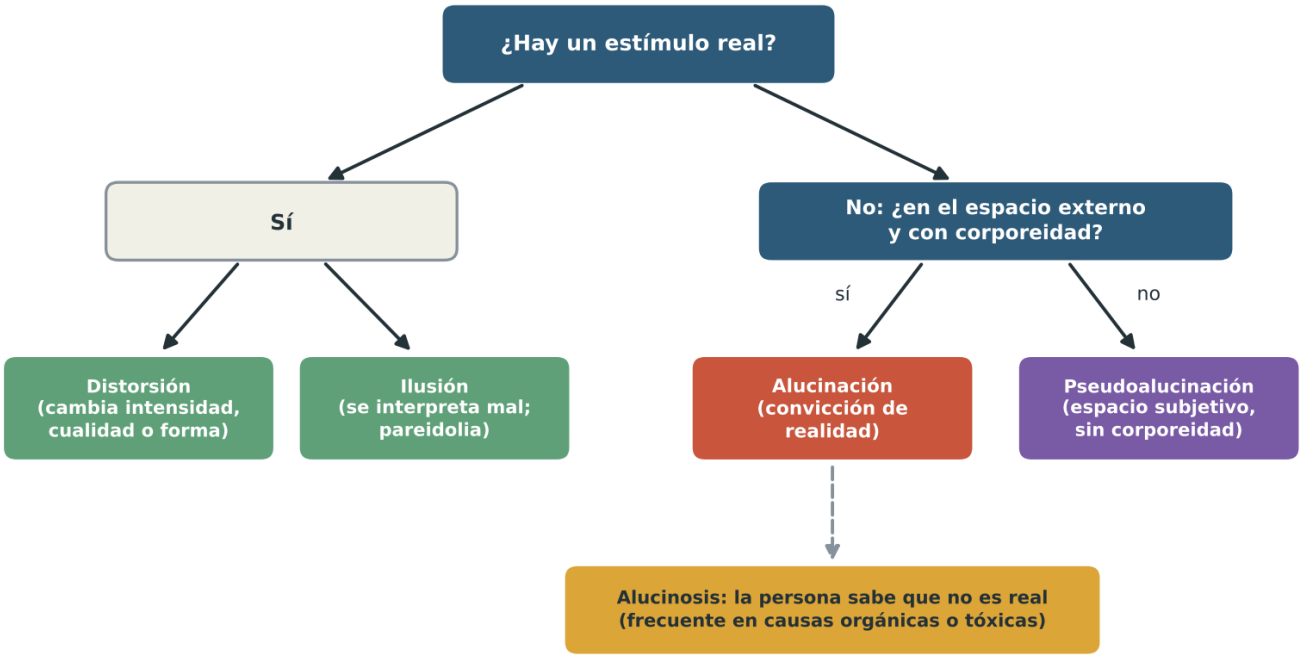


Figura 6.1. **Árbol de decisión de las alteraciones perceptivas.** Si hay un estímulo real, se trata de una distorsión (cambia su intensidad, cualidad o forma) o de una ilusión (se interpreta mal). Si no lo hay, la localización externa y la corporeidad separan la alucinación de la pseudoalucinación, y el reconocimiento de su irrealidad define la alucinosis. Elaboración propia.

- **Ilusión**: un estímulo real se **interpreta mal**. De noche, el abrigo colgado en la puerta parece una persona. Las **pareidolias** son ilusiones que forman imágenes con sentido (caras en las nubes o en un enchufe) sin que se pierda el juicio de realidad.
- **Alucinación**: percepción **sin objeto**, vivida en el **espacio externo**, con **corporeidad** (nitidez de percepción real) y **convicción** de realidad.
- **Pseudoalucinación**: descrita por Kandinsky y precisada por Jaspers, se localiza en el **espacio subjetivo interno** («la voz suena dentro de la cabeza»), carece de corporeidad y a menudo se reconoce como anómala.
- **Alucinosis**: alucinación que la persona **reconoce como irreal**. Es típica de causas orgánicas o tóxicas, como la alucinosis alcohólica.

Modalidades. Las alucinaciones **auditivas** son las más frecuentes en la esquizofrenia, sobre todo voces que comentan o dialogan. Las **visuales** apuntan más a causas orgánicas, al delirium o al consumo de sustancias. Las **táctiles** pueden adoptar la forma de **formicación** (sentir bichos bajo la piel) en la abstinencia o el consumo de cocaína. Las **olfativas** y **gustativas** aparecen en la epilepsia del lóbulo temporal. Las **cenestésicas** afectan a sensaciones corporales internas («tengo los órganos podridos») y las **cinestésicas**, al movimiento.

Formas especiales:

Tipo	Rasgo definitorio
Funcional	La desencadena un estímulo real de la **misma** modalidad y coexiste con él: oír voces en el ruido del agua
Refleja	Un estímulo en una modalidad produce una alucinación en **otra**: ver destellos al oír música
Extracampina	Fuera del campo sensorial: «ver» a alguien detrás de la cabeza
Negativa	No percibir algo que está presente
Autoscópica	Verse a uno mismo
Hipnagógica / hipnopómpica	Al dormirse / al despertar; frecuentes sin patología y en la narcolepsia (Unidad 13)

Imágenes anómalas. Están a medio camino entre la percepción y la imaginación: **eidéticas** (imágenes muy nítidas de algo visto antes), **consecutivas** o postimágenes (la mancha que queda tras mirar una luz), **parásitas** (imágenes que se repiten sin buscarlas) y **alucinoides**. No implican, por sí solas, un trastorno.

6.2 Pensamiento: forma y curso

El pensamiento se explora en dos planos: su **forma** o curso (cómo se encadenan las ideas) y su **contenido** (qué se piensa). Los **trastornos formales del pensamiento** se infieren del **discurso**, porque solo a través del lenguaje se accede al pensamiento ajeno. La referencia para describirlos es la **escala TLC** (*Thought, Language and Communication*) de Andreasen (1979), que definió cada alteración con ejemplos y criterios para evaluarla de forma fiable.

Alteraciones de la velocidad:

- **Taquipsiquia**: pensamiento acelerado. Suele acompañarse de **presión del habla**, una necesidad de hablar rápido y sin pausa difícil de interrumpir.
- **Bradipsiquia**: pensamiento lento, con respuestas tardías y escasas, típico de la depresión.

Alteraciones de la dirección y la conexión. Son las más preguntadas, y la figura 6.2 las muestra como trayectorias del discurso.



Esquema ilustrativo, no datos

Figura 6.2. **Trayectorias del discurso en los trastornos formales.** Desde un punto de partida hasta una meta: el discurso normal va directo; el circunstancial da un rodeo pero llega; el tangencial se desvía y no llega; la fuga de ideas encadena saltos rápidos; el descarrilamiento salta sin conexión; el bloqueo se corta de golpe. Elaboración propia.

- **Circunstancialidad**: el discurso se llena de detalles innecesarios y rodeos, **pero llega a la meta**. Ante «¿cómo ha dormido?», alguien habla del colchón, de la vecina y del calor, y acaba diciendo «al final, mal».
- **Tangencialidad**: la respuesta se aleja de la pregunta desde el principio y **no llega** a contestarla.
- **Fuga de ideas**: sucesión muy rápida de ideas que saltan por asociaciones superficiales, como asonancias o juegos de palabras, pero **conservan cierta conexión** entre una y la siguiente. Es típica de la **manía**: «Vengo de la playa, playa de arena, arena de reloj, ¿qué hora es?, hora de comer».
- **Descarrilamiento** o pérdida de asociaciones: las ideas se suceden **sin relación** comprensible entre ellas. Es característico de la **esquizofrenia**.
- **Incoherencia** o «ensalada de palabras»: la desorganización alcanza a la propia frase, que pierde la gramática.
- **Bloqueo**: interrupción **brusca** del curso del pensamiento; la persona se queda en blanco a mitad de frase y no sabe cómo seguir.
- **Perseveración**: repetición de la misma idea o palabra ante preguntas diferentes.

Alteraciones de la producción:

- **Neologismos**: palabras inventadas o usos idiosincrásicos de palabras existentes.
- **Pobreza del lenguaje**: se habla poco, con respuestas breves.
- **Pobreza del contenido**: se habla en cantidad suficiente, pero se transmite muy poca información; las frases son vagas o repetitivas.

Dos parejas generan la mayoría de los errores:

Pareja	Primero	Segundo	Clave para distinguirlos
Circunstancial / tangencial	Llega a la meta	No llega	¿Termina respondiendo a la pregunta?

Pareja	Primero	Segundo	Clave para distinguirlos
Fuga de ideas / descarrilamiento	Manía; saltos con conexión superficial	Esquizofrenia; saltos sin conexión	¿Se entiende el paso de una idea a la siguiente?

Estos fenómenos no son exclusivos de un trastorno. La pobreza del lenguaje forma parte de los **síntomas negativos** de la esquizofrenia (alogia), pero también aparece en la depresión grave; la circunstancialidad es frecuente en personas mayores sin patología o en algunos trastornos neurológicos. Lo que orienta el diagnóstico es el conjunto, no un síntoma aislado. En el DSM-5-TR, el **discurso desorganizado** es uno de los cinco síntomas que definen la esquizofrenia (Unidad 11).

6.3 Pensamiento: contenido

El delirio. Una **idea delirante** es una creencia **falsa**, sostenida con **firmeza**, **incorregible** pese a las pruebas en contra y **no compartida** por el grupo cultural de la persona. Jaspers propuso tres criterios: **certeza subjetiva**, **incorregibilidad** e **imposibilidad del contenido**. Este último está hoy matizado: un delirio celotípico puede tener un contenido posible, e incluso ser cierto por casualidad, y sigue siendo delirio porque la convicción no se basa en razones.

Jaspers distinguió dos tipos según su origen:

- **Delirio primario**: es **incomprensible**; no deriva de ninguna otra vivencia. Adopta tres formas: la **percepción delirante** (una percepción normal recibe un significado delirante: «la farola parpadeó y supe que me habían elegido»; Schneider la incluyó entre los síntomas de primer rango), la **ocurrencia o intuición delirante** (la idea surge de golpe, sin percepción previa) y el **temple o humor delirante** (la sensación inquietante de que algo extraño está pasando, sin saber qué, que suele preceder a las anteriores).
- **Delirio secundario**: es **comprensible** a partir de otra vivencia. La culpa de un delirio depresivo deriva del ánimo; la persecución puede derivar de oír voces.

Temas y síndromes. El tema más frecuente es el de **persecución**. Le siguen los de **referencia** (todo alude a uno), **grandeza**, **culpa** y **ruina** (típicos de la depresión psicótica), **somático** y de **control** o influencia. Varios temas tienen nombre propio:

Síndrome	Contenido delirante
Cotard	Nihilista: «estoy muerto», «no tengo órganos»
Otelo	Celotípico: convicción de que la pareja es infiel
Clérambault	Erotomaníaco: alguien, a menudo de mayor estatus, está enamorado de uno
Capgras	Un allegado ha sido sustituido por un doble idéntico
Frégoli	Personas desconocidas son en realidad la misma persona disfrazada

Capgras y Frégoli son **síndromes de identificación errónea**. Cuando dos personas que conviven comparten un delirio, se habla de **folie à deux** o trastorno psicótico compartido.

Idea sobrevalorada. Es una creencia **aceptable en sí misma**, pero sostenida con una intensidad afectiva desproporcionada que acaba **dominando la vida** de la persona. A diferencia del delirio, su contenido no es extraño y suele compartirse en parte con el entorno. Es el caso de la convicción de estar gorda en la anorexia (Unidad 16), de la preocupación por un defecto físico en el trastorno dismórfico corporal (Unidad 8) o de la querulancia, la necesidad de pleitear sin descanso por un agravio.

Obsesión frente a inserción del pensamiento. Ambas son pensamientos que la persona no quiere tener, pero su vivencia es opuesta:

Rasgo	Obsesión	Inserción del pensamiento
Autoría	Se reconoce como **propio**	Se vive como **ajeno**, metido desde fuera
Actitud	Egodistónico y resistido	Se acepta como algo que le hacen
Juicio	Insight variable	Forma parte de una vivencia psicótica
Trastorno típico	TOC (Unidad 8)	Esquizofrenia (Unidad 11)

Una madre que piensa una y otra vez «¿y si hago daño a mi bebé?» sabe que esa idea sale de su cabeza, le horroriza y trata de neutralizarla: es una obsesión. Quien afirma que un vecino le introduce pensamientos con una antena vive una inserción.

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Trastorno delirante: duración	≥1 mes	≥3 meses
Esquizofrenia: duración	≥6 meses (≥1 mes de fase activa)	≥1 mes
Síntomas de primer rango	Sin trato privilegiado	Peso reducido
Descripción de los síntomas	Escala de gravedad por dimensiones en la Sección III	Descriptores de síntomas (positivos, negativos, depresivos, maníacos, psicomotores, cognitivos)

6.4 Lenguaje y afectividad

Lenguaje y habla. Las **afasias** tienen causa orgánica y se estudian en Psicología del Lenguaje y en Neuropsicología. En psicopatología interesan sobre todo estas alteraciones:

- **Logorrea** o verborrea: habla excesiva y difícil de frenar, típica de la manía.
- **Bradilalia**: habla lenta.
- **Mutismo**: ausencia de habla sin lesión que la explique; aparece en la catatonía, la depresión grave y algunos cuadros disociativos. No debe confundirse con el mutismo selectivo infantil (Unidad 7).
- **Ecolalia**: repetir las palabras del interlocutor; aparece en la catatonía y en el trastorno del espectro autista.
- **Palilalia**: repetir las propias palabras o sílabas finales.
- **Verbigeración**: repetición de palabras o frases sin sentido, de forma monótona.
- **Coprolalia**: emisión involuntaria de palabras obscenas, propia del síndrome de Tourette.
- **Mussitación**: murmullo en voz muy baja, casi sin mover los labios.
- **Glosolalia**: emisión de un pseudolenguaje sin significado.
- **Disartria** (dificultad para articular, de causa neurológica) y **disfemia** (tartamudez).

Afectividad. Incluye el **humor** o estado de ánimo de fondo, que puede ser deprimido, eufórico, **disfórico** (malhumorado y desagradable) o irritable, y las emociones concretas, como la ansiedad y la angustia. Las teorías de la emoción se estudian en Motivación y Emoción. Las alteraciones principales son:

- **Anhedonia**: pérdida de la capacidad de disfrutar de lo que antes resultaba placentero. Es central en la depresión y forma parte de los síntomas negativos.
- **Aplanamiento** o embotamiento afectivo: reducción de la expresión emocional (rostro inexpresivo, voz monótona, pocos gestos). Es un **síntoma negativo** de la esquizofrenia.
- **Labilidad afectiva**: cambios emocionales rápidos ante estímulos mínimos. En la **incontinencia afectiva**, la persona no puede contener la expresión emocional (llanto o risa) aunque quiera, como ocurre tras algunas

lesiones cerebrales.

- **Paratimia**: afecto **incongruente** con el contenido: reír al contar la muerte de un familiar.
- **Ambivalencia**: sentimientos opuestos simultáneos hacia lo mismo. Bleuler la consideró un rasgo fundamental de la esquizofrenia.
- **Alexitimia**: dificultad para identificar y describir las propias emociones (Sifneos, 1973). Es un rasgo dimensional, no un diagnóstico.
- **Apatía** y **abulia**: falta de interés y falta de voluntad para iniciar acciones.
- **Sentimiento de falta de sentimientos**: la persona sufre por no sentir nada, ni siquiera ante sus seres queridos. Es típico de la depresión grave.
- ***La belle indifférence***: aparente despreocupación ante un síntoma grave, descrita en la conversión; hoy se considera poco específica (Unidad 14).

Aplanamiento y paratimia se confunden con frecuencia:

Rasgo	Aplanamiento afectivo	Paratimia
Qué falla	La **cantidad** de expresión	La **congruencia** con el contenido
Ejemplo	Contar una buena noticia sin ningún cambio en la cara	Sonreír al describir un accidente
Contexto típico	Síntomas negativos de la esquizofrenia	Esquizofrenia, otras psicosis

Una diferencia similar separa la **anhedonia**, que afecta a la capacidad de sentir placer, de la **apatía**, que afecta al interés y a la iniciativa. Alguien puede no tener ganas de salir con sus amigos (apatía) y, si lo arrastran, disfrutar (sin anhedonia).

Consenso y debate

Consenso: la alucinación se define por la percepción sin objeto con corporeidad, localización externa y convicción de realidad; el delirio, por la convicción firme e incorregible no compartida culturalmente, no por la imposibilidad de su contenido. La fuga de ideas orienta a la manía y el descarrilamiento a la esquizofrenia, aunque ningún síntoma aislado basta para diagnosticar. La psicopatología es mayoritariamente dimensional: muchas de estas experiencias aparecen, de forma leve, en personas sin trastorno.

Debate: se discute la utilidad del concepto de pseudoalucinación, porque sus criterios (localización interna, falta de corporeidad, conciencia de anomalía) no siempre coinciden en la misma persona. También se debate hasta qué punto es útil el criterio jaspersiano de incomprensibilidad para separar el delirio primario del secundario, y la especificidad de los síntomas de primer rango.

Mito frecuente

Mito: «Si alguien oye o ve algo que no está, es que tiene un trastorno psicótico».

Realidad: una alucinación no implica psicosis. Las hipnagógicas e hipnopómpicas son frecuentes en personas sanas; en el duelo, muchas personas oyen o ven brevemente a quien han perdido; la privación sensorial y el síndrome de Charles Bonnet (alucinaciones visuales en personas con pérdida de visión) también las producen. Lo que importa es el contexto, la convicción y el resto de la clínica.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Ilusión	Interpretación errónea de un estímulo real
Alucinación	Percepción sin objeto, en el espacio externo, con corporeidad y convicción de realidad
Pseudoalucinación	Percepción sin objeto localizada en el espacio interno, sin corporeidad (Kandinsky, Jaspers)
Alucinación funcional	Alucinación desencadenada por un estímulo real de la misma modalidad, que coexiste con él
Circunstancialidad	Discurso con rodeos y detalles innecesarios que finalmente llega a la meta
Fuga de ideas	Sucesión rápida de ideas con asociaciones superficiales y cierta conexión; típica de la manía
Percepción delirante	Percepción normal a la que se atribuye un significado delirante; síntoma de primer rango
Paratimia	Afecto incongruente con el contenido de lo que se piensa o se dice

Clave PIR

Prioridad alta. Es uno de los bloques más preguntados: se pide identificar el fenómeno a partir de una viñeta (ilusión, alucinación, pseudoalucinación, alucinosis; circunstancialidad o tangencialidad; síndrome de Capgras o de Frégoli). Trampas típicas: confundir la alucinación funcional (misma modalidad) con la refleja (otra modalidad), la fuga de ideas con el descarrilamiento, la obsesión (propia) con la inserción del pensamiento (ajena) y la idea sobrevalorada con el delirio.

Autoevaluación

1. Un hombre oye insultos cada vez que abre el grifo, y solo mientras suena el agua. Es una alucinación…
a) refleja
b) extracampina
c) funcional

2. Una persona con consumo crónico de alcohol oye voces amenazantes nítidas que suenan en la habitación, pero sabe que no son reales. Es…
a) una alucinosis
b) una pseudoalucinación
c) una ilusión

3. Al preguntarle por su trabajo, un paciente habla de su coche, del tráfico y de su cuñado, y acaba explicando a qué se dedica. Presenta…
a) tangencialidad
b) circunstancialidad
c) descarrilamiento

4. Una mujer está convencida de que su marido ha sido sustituido por un impostor idéntico. Es un síndrome de…
a) Frégoli
b) Clérambault
c) Capgras

5. ¿Qué distingue una obsesión de la inserción del pensamiento?
a) La obsesión se reconoce como un pensamiento propio
b) La obsesión se vive como impuesta desde fuera
c) La obsesión no produce ningún malestar

Soluciones

1 c. El estímulo real y la alucinación son de la misma modalidad y coexisten; en la refleja la modalidad cambia. **2 a.** La persona reconoce la irrealidad de la percepción, algo típico de causas tóxicas. **3 b.** El discurso da rodeos, pero llega a la meta; en la tangencialidad no llegaría. **4 c.** En Frégoli, los desconocidos son la misma persona disfrazada. **5 a.** La obsesión es propia, egodistónica y resistida; la inserción se vive como ajena.

Capítulo 4 · Miedo, obsesiones y estrés: la ansiedad y sus trastornos afines

El miedo y la ansiedad son emociones útiles que, cuando se disparan sin motivo, duran demasiado o llevan a evitar media vida, se convierten en un problema clínico. Este capítulo estudia los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y sus afines, y los trastornos que aparecen tras un trauma, un estresor o una pérdida. En todos ellos se repite una misma idea: lo que alivia a corto plazo, como evitar, comprobar o no pensar, suele ser lo que mantiene el problema.

Unidad 7 · Trastornos de ansiedad

Objetivos: distinguir miedo, ansiedad normal y ansiedad patológica; describir los criterios y tipos de fobia específica y sus modelos de adquisición; diferenciar el trastorno de ansiedad social de la timidez y explicar sus modelos cognitivos; explicar el trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizada con sus principales modelos.

7.1 Miedo, ansiedad y fobia específica

El **miedo** es la respuesta a una amenaza **presente e inmediata**: un perro que ladra al lado. La **ansiedad** es la **anticipación** de una amenaza futura, a menudo difusa: pensar la noche anterior en la entrevista de trabajo. Ambas se expresan en el **triple sistema de respuesta** (Lang, 1968): **cognitivo** (pensamientos de peligro), **fisiológico** (taquicardia, sudoración, tensión) y **motor** (huida, evitación, paralización).

La ansiedad es adaptativa. Según la **ley de Yerkes-Dodson**, el rendimiento sigue una **U invertida**: es máximo con una activación moderada y cae con poca o con demasiada. La ansiedad es **patológica** cuando es desproporcionada a la amenaza real, persiste e interfiere en la vida. Los trastornos de ansiedad son más frecuentes en mujeres (en torno a 2:1) y su heredabilidad se sitúa aproximadamente entre el 30 y el 50 %. El DSM-5-TR agrupa aquí la ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, la ansiedad social, el pánico, la agorafobia, el TAG y los cuadros inducidos por sustancias o por otra afección médica; el TOC y el TEPT salieron del capítulo en el DSM-5 (Unidades 8 y 9).

La **fobia específica** es un miedo o ansiedad intensos ante un objeto o situación concretos, que casi siempre provoca miedo inmediato, se evita o se soporta con gran malestar, es desproporcionado y dura **típicamente 6 meses o más**. Se especifica el tipo: **animal**, **entorno natural** (alturas, tormentas, agua), **sangre-inyecciones-heridas**, **situacional** (aviones, ascensores) y **otros**. Suele empezar en la infancia: las fobias a animales, pronto; las situacionales, más tarde. En el estudio ESEMeD-España fue el segundo trastorno en prevalencia vital.

La fobia a la **sangre-inyecciones-heridas** (SIH) es una excepción fisiológica: produce una **respuesta bifásica**, con un aumento inicial de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial seguido de una caída vasovagal que puede acabar en desmayo. Por eso se trata con la **tensión aplicada** de Öst: tensar los músculos para evitar la caída de la tensión arterial.

¿Cómo se adquiere una fobia? Watson y Rayner (1920) condicionaron el miedo en un bebé de unos 11 meses, «Albert B.», emparejando una rata blanca, que no le asustaba, con el ruido de un golpe en una barra metálica.

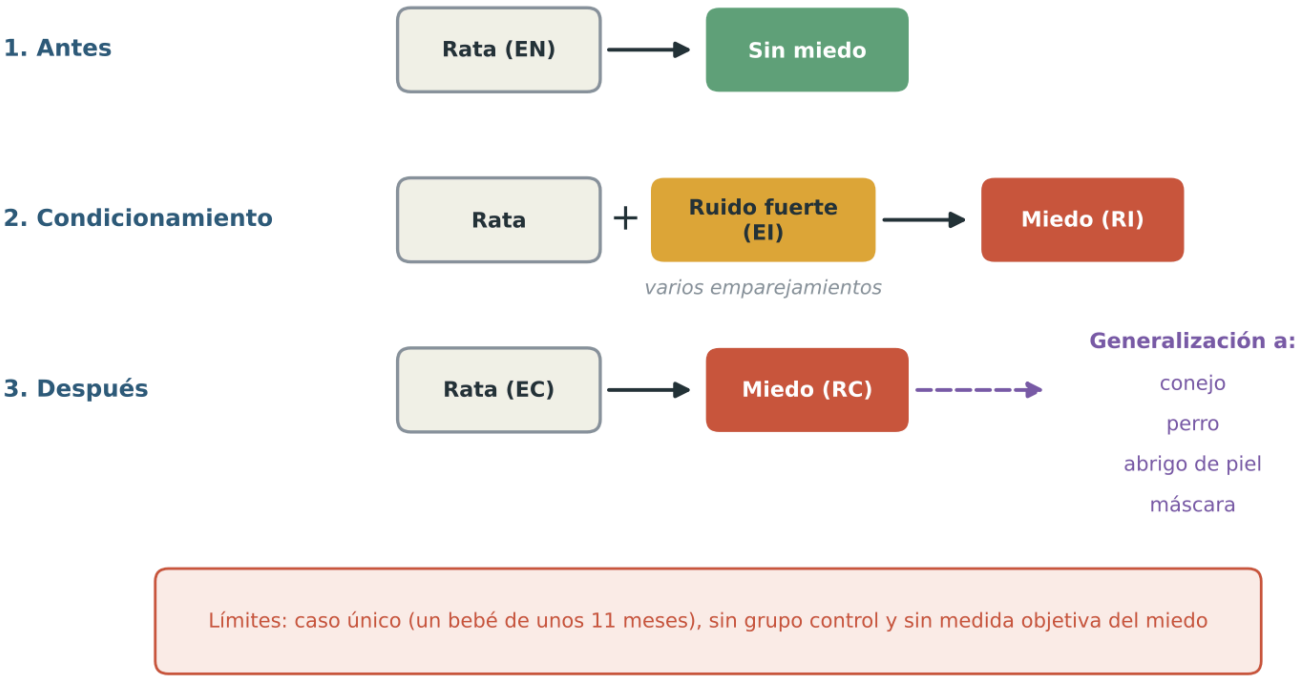


Figura 7.1. **El condicionamiento de Albert.** La rata, al principio neutra, se empareja con el ruido y pasa a provocar miedo, que se generaliza a otros estímulos peludos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.1, la rata acabó provocando miedo por sí sola, y el miedo se **generalizó** a estímulos parecidos (figura 7.2). Fue un caso único, sin control ni medidas objetivas, y a menudo se ha contado con distorsiones (Harris, 1979).



Figura 7.2. **El pequeño Albert.** Imagen de la filmación de Watson y Rayner reproducida en una publicación de la época, con su pie original en inglés («Ahora teme incluso a Papá Noel»): una máscara con barba blanca fue uno de los estímulos con que se comprobó la generalización del miedo. Fuente: John B. Watson, Wikimedia Commons, dominio público.

El condicionamiento no explica por qué el miedo no se extingue. La **teoría bifactorial** de Mowrer (1947) lo resuelve en dos fases (figura 7.3).

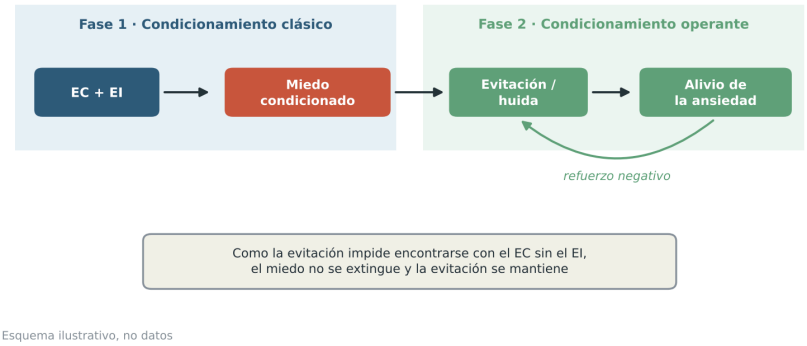


Figura 7.3. **Teoría bifactorial de Mowrer.** En la fase 1 el miedo se adquiere por condicionamiento clásico; en la fase 2 la evitación reduce la ansiedad, se refuerza negativamente y el miedo no llega a extinguirse. Elaboración propia.

Seligman (1971) propuso la **preparación** (*preparedness*): los miedos a estímulos con relevancia evolutiva, como serpientes, arañas o alturas, se adquieren con facilidad y resisten la extinción, algo que apoyaron los experimentos de Öhman. Rachman (1977) describió **tres vías** de adquisición: condicionamiento directo, aprendizaje **vicario** (ver a la madre gritar ante una cucaracha) y **transmisión de información** («los perros muerden»). Menzies y Clarke defendieron que algunos miedos son innatos (teorías **no asociativas**). El tratamiento de elección es la **exposición** *in vivo*, que actúa por aprendizaje inhibitorio más que por «borrado» del miedo (Craske y colaboradores; véanse Tratamientos y Aprendizaje).

7.2 Trastorno de ansiedad social

El **trastorno de ansiedad social** es un miedo o ansiedad intensos en situaciones sociales en las que la persona puede ser **examinada** por otros: conversar con desconocidos, comer en público, hablar en una reunión. El núcleo es el miedo a la **evaluación negativa**: actuar o mostrar síntomas de ansiedad (ruborizarse, temblar, sudar) que lleven a la humillación, al rechazo o a ofender a alguien. Las situaciones casi siempre provocan ansiedad, se evitan o se soportan con malestar intenso, la respuesta es desproporcionada y dura **típicamente 6 meses o más**. Existe el especificador **«solo actuación»**, cuando el miedo se limita a hablar o actuar en público. El DSM-5-TR ya no usa «fobia social» como sinónimo.

La prevalencia anual en Estados Unidos ronda el **7 %**, según el DSM. Suele empezar en la **adolescencia** y, sin tratamiento, tiende a la cronicidad. En el triple sistema de respuesta:

Sistema	Manifestaciones típicas
Cognitivo	«Se van a dar cuenta de que estoy nervioso»; repaso posterior de la conversación
Fisiológico	Rubor, temblor, sudoración; preocupan sobre todo los síntomas visibles
Motor	Evitación, escape y conductas de seguridad, como no mirar a los ojos

Timidez no es ansiedad social. La **timidez** es un rasgo dimensional y muy frecuente; la mayoría de las personas tímidas **no** cumple criterios del trastorno. La diferencia está en la intensidad, la evitación, el malestar y el deterioro. Nuria, tímida, tarda en soltarse en una cena con gente nueva, pero acaba disfrutando. Marcos ha rechazado un ascenso para no hablar en reuniones y pasa días repasando cada frase que dijo: solo él tiene un trastorno. Como factor temperamental de riesgo se ha estudiado la **inhibición conductual** descrita por Kagan: la tendencia infantil a retraerse ante lo nuevo. El solapamiento con el trastorno de la personalidad evitativa es grande; el evitativo es más generalizado (Unidad 12).

Modelos cognitivos. Dos modelos explican por qué la ansiedad social se mantiene aunque las situaciones temidas no acaben en catástrofe:

- **Clark y Wells (1995).** En la situación social, la persona centra la atención en sí misma y se **procesa a sí misma como objeto social**: construye una imagen de cómo cree que la ven los demás a partir de sus

sensaciones internas («me noto rojo, luego se me ve rojísimo»). Usa **conductas de seguridad** que impiden comprobar que lo temido no ocurre y que, a veces, empeoran la actuación. Antes de la situación hay **procesamiento anticipatorio** y, después, un **procesamiento posterior** o rumiación post-evento que refuerza la idea de fracaso.

- **Rapee y Heimberg (1997).** La persona forma una **representación mental de sí misma tal como la vería la audiencia** y la compara con el **estándar** que cree que los demás esperan. Cuanto mayor es la distancia percibida, mayor es la probabilidad estimada de evaluación negativa y más ansiedad aparece.

En ambos, el problema no es la falta de habilidades sociales, sino la atención autocentrada y las conductas que impiden desmentir las predicciones negativas (Tratamientos).

7.3 Trastorno de pánico y agorafobia

Una **crisis o ataque de pánico** es la aparición súbita de miedo o malestar intenso que alcanza su **máximo en minutos**, con **al menos 4 de 13 síntomas**: palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de falta de aire, de ahogo, dolor torácico, náuseas, mareo, escalofríos o calor, parestesias, desrealización o despersonalización, miedo a perder el control o a volverse loco y miedo a morir. Puede aparecer tanto en reposo como cuando la persona ya estaba ansiosa.

El **trastorno de pánico** exige crisis **inesperadas y recurrentes**, y que al menos a una le siga **un mes o más** de inquietud persistente por nuevas crisis o sus consecuencias («¿y si me da un infarto?») o un cambio desadaptativo de la conducta (dejar el gimnasio para no acelerar el corazón). Las crisis **esperadas**, ligadas a una situación temida, también existen: por eso el ataque de pánico es, además, un **especificador** aplicable a cualquier trastorno («depresión con ataques de pánico»). La prevalencia anual ronda el **2-3 %**, según el DSM, y suele iniciarse en la adultez temprana.

Modelos explicativos.

- **Modelo cognitivo de Clark (1986).** La clave es la **interpretación catastrófica** de sensaciones corporales normales o propias de la ansiedad: unas palpitaciones tras subir la escalera se leen como un infarto inminente.

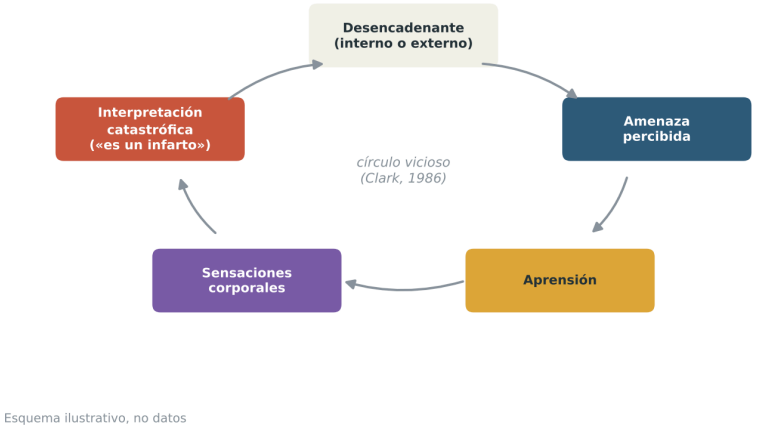


Figura 7.4. **Círculo vicioso del pánico (Clark, 1986).** Un desencadenante interno o externo se percibe como amenaza, produce aprensión y sensaciones corporales, que se interpretan de forma catastrófica y realimentan la amenaza. Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.4, el ciclo se cierra sobre sí mismo: la ansiedad intensifica las sensaciones y estas confirman la interpretación.

- **Sensibilidad a la ansiedad** (Reiss y McNally, 1985). Es la creencia de que los síntomas de ansiedad son dañinos («si me mareo, me desmayaré y haré el ridículo»). Se mide con el Índice de Sensibilidad a la

Ansiedad (ASI; Evaluación Psicológica) y predice de forma prospectiva la aparición de crisis.

- **Barlow** distingue la **falsa alarma** (una reacción de miedo sin peligro real), la **alarma aprendida** (que queda condicionada a señales) y el condicionamiento **interoceptivo**: las propias sensaciones corporales se convierten en señales de una nueva crisis.
- **Klein (1993)** propuso la hipótesis de la **falsa alarma de asfixia**: un detector de asfixia demasiado sensible se dispararía sin motivo. Estas hipótesis se estudian con **pruebas de provocación** (CO_2, hiperventilación, lactato).

La agorafobia es un miedo o ansiedad intensos en **al menos 2 de 5 situaciones**: transporte público, espacios abiertos, sitios cerrados, hacer cola o estar entre una multitud, y estar fuera de casa solo. Se temen porque escapar sería difícil o no habría ayuda si aparecieran síntomas de pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos (caerse, en una persona mayor; perder el control de esfínteres). Las situaciones se evitan, exigen un acompañante o se soportan con gran malestar, durante **típicamente 6 meses o más**. Su prevalencia es aproximadamente del 1-2 %.

Hasta el DSM-IV se hablaba de «trastorno de pánico con o sin agorafobia». Desde el DSM-5 son **diagnósticos independientes**: la agorafobia puede existir sin pánico y, si se cumplen ambos, se diagnostican los dos. Ana ha tenido varias crisis inesperadas, vive pendiente de que se repitan y desde hace más de 6 meses evita el metro y las colas o solo sale acompañada: tiene ambos trastornos. El tratamiento con más apoyo es la exposición *in vivo* dentro de la terapia cognitivo-conductual (Tratamientos).

7.4 Trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos de ansiedad

El **trastorno de ansiedad generalizada** (TAG) se define por **ansiedad y preocupación excesivas**, difíciles de controlar, la mayoría de los días durante **6 meses o más**, sobre **diversos temas**: el trabajo, la salud de los hijos, el dinero, llegar tarde. Se asocia a **al menos 3 de 6 síntomas** (solo 1 en niños): inquietud, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. La CIE-11 sitúa el núcleo en la preocupación o aprensión general, con una duración de «varios meses», y permite que coexista con la depresión. La prevalencia anual ronda el **3 %**; empieza más tarde que otros trastornos de ansiedad, tiene un curso crónico y fluctuante y es muy comórbido con la depresión.

Modelos del TAG. La preocupación del TAG no es un simple exceso de pensamiento: cumple funciones que la mantienen.

- **Evitación cognitiva (Borkovec).** La preocupación es una actividad **verbal-lingüística** que reduce la activación somática y las imágenes aversivas. Ese alivio la **refuerza negativamente**, pero impide procesar del todo el miedo.
- **Intolerancia a la incertidumbre** (Dugas et al., 1998). La persona vive la incertidumbre como inaceptable y se preocupa para intentar reducirla.
- **Modelo metacognitivo** (Wells, 1995). Distingue dos tipos de preocupación y el papel de las creencias sobre ella.

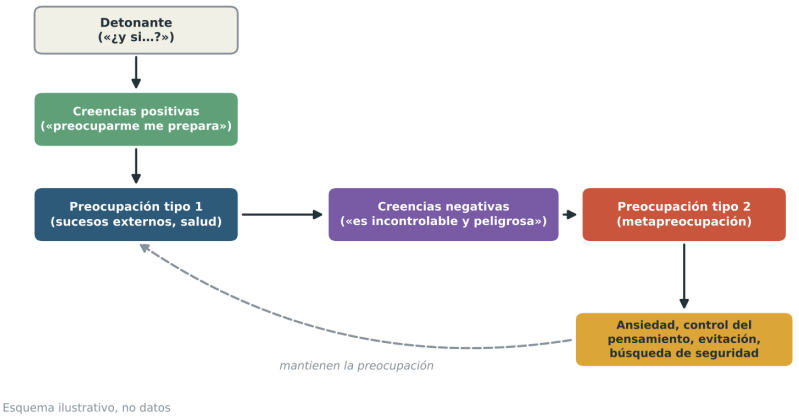


Figura 7.5. **Modelo metacognitivo del TAG (Wells, 1995).** Las creencias positivas activan la preocupación tipo 1; las creencias negativas sobre ella dan lugar a la preocupación tipo 2, que alimenta la ansiedad, las conductas de control y la evitación. Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.5, ante un detonante se activan **creencias positivas** («preocuparme me prepara») y aparece la **preocupación tipo 1**, sobre sucesos externos y síntomas no cognitivos. Después se activan **creencias negativas** sobre la propia preocupación (que es incontrolable o peligrosa) y surge la **preocupación tipo 2** o **metapreocupación**: «si sigo así, me voy a volver loco».

- **Triple vulnerabilidad (Barlow).** Una vulnerabilidad **biológica general**, una vulnerabilidad **psicológica general** (sensación de que los acontecimientos son incontrolables) y una vulnerabilidad **psicológica específica**, aprendida, que orienta la ansiedad hacia ciertos temas.

Otros trastornos de ansiedad. El **trastorno de ansiedad por separación** es un miedo excesivo e inapropiado para el desarrollo a separarse de las figuras de apego; desde el DSM-5 puede diagnosticarse también en adultos. El **mutismo selectivo** consiste en no hablar en situaciones sociales concretas, como el colegio, pese a hacerlo en otras, como en casa, durante al menos un mes, sin contar el primer mes de escolarización.

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Nombre del grupo	Trastornos de ansiedad	Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo
Criterios	Recuentos de síntomas y duraciones fijas	Características esenciales, sin recuentos
Fobias, ansiedad social, agorafobia, TAG	6 meses o más	Varios meses
Agorafobia	Al menos 2 de 5 situaciones	Miedo a resultados incapacitantes o embarazosos
Pánico	Un mes o más de inquietud tras una crisis	Requisito temporal similar

Consenso y debate

Consenso: la ansiedad es una emoción adaptativa que se vuelve patológica por su desproporción, persistencia e interferencia. La evitación y las conductas de seguridad mantienen los trastornos de ansiedad, y la exposición es eficaz porque genera aprendizaje inhibitorio. Las interpretaciones catastróficas y la sensibilidad a la ansiedad son centrales en el pánico (Clark, 1986).

Debate: el peso relativo de las vías de adquisición de las fobias (directa, vicaria, informativa o miedos innatos) y el valor del caso de Albert, un caso único sin control (Harris, 1979), aunque el condicionamiento aversivo humano está bien establecido con paradigmas modernos.

Mito frecuente

Mito: «Un ataque de pánico puede provocar un infarto o la muerte».

Realidad: la crisis de pánico es muy intensa, pero no es peligrosa en sí misma. Lo que la mantiene es la interpretación catastrófica de las sensaciones corporales, que alimenta el círculo vicioso de la ansiedad (Clark, 1986).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Triple sistema de respuesta	Expresión cognitiva, fisiológica y motora de la ansiedad (Lang, 1968)
Respuesta bifásica	Subida de frecuencia cardiaca y tensión seguida de caída vasovagal, típica de la fobia SIH
Teoría bifactorial	Adquisición del miedo por condicionamiento clásico y mantenimiento por evitación (Mowrer, 1947)
Preparación	Facilidad biológica para condicionar miedos a estímulos con relevancia evolutiva (Seligman, 1971)
Conductas de seguridad	Acciones para prevenir lo temido que impiden comprobar que no ocurre
Interpretación catastrófica	Lectura de sensaciones corporales como signo de peligro inminente (Clark, 1986)
Sensibilidad a la ansiedad	Creencia de que los síntomas de ansiedad son dañinos (Reiss y McNally, 1985)
Metapreocupación	Preocupación tipo 2: preocupación sobre la propia preocupación (Wells, 1995)

Clave PIR

Prioridad alta. Se preguntan los criterios y duraciones (6 meses en fobias, ansiedad social, agorafobia y TAG; un mes de inquietud en el pánico), los tipos de fobia y los modelos con su autor. Trampas típicas: negar la respuesta bifásica de la fobia SIH, creer que pánico y agorafobia siguen unidos, confundir la preocupación tipo 1 con la tipo 2 y mezclar a Clark (1986) con Clark y Wells (1995).

Autoevaluación

1. En la fobia a la sangre-inyecciones-heridas, la respuesta fisiológica característica es…
a) un aumento sostenido de la frecuencia cardiaca
b) un aumento inicial seguido de una caída vasovagal
c) una bajada de la tensión desde el primer momento

2. En el DSM-5-TR, el trastorno de pánico y la agorafobia…
a) son diagnósticos independientes que pueden coexistir
b) se diagnostican siempre como un único trastorno
c) solo se distinguen por la edad de inicio

3. En el modelo de Wells (1995), la preocupación tipo 2 es la preocupación…
a) por sucesos externos de la vida diaria
b) por síntomas físicos no cognitivos
c) por el hecho mismo de preocuparse

4. Que el miedo a las serpientes se adquiera con facilidad y resista la extinción se explica mejor por…
a) la preparación de Seligman (1971)
b) la transmisión de información de Rachman
c) la interpretación catastrófica de Clark

5. Según Clark y Wells (1995), en la ansiedad social es central…
a) la intolerancia a la incertidumbre
b) el procesamiento de uno mismo como objeto social
c) el condicionamiento interoceptivo

Soluciones

1 b. La respuesta bifásica puede llevar al desmayo. **2 a.** Desde el DSM-5 son diagnósticos separados y, si se cumplen ambos, se asignan los dos. **3 c.** Es la metapreocupación; la tipo 1 trata sobre sucesos externos y síntomas no cognitivos. **4 a.** Los estímulos con relevancia evolutiva se condicionan con más facilidad. **5 b.** La intolerancia a la incertidumbre corresponde al TAG.

Unidad 8 · Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados

Objetivos: describir las obsesiones, las compulsiones, las dimensiones de síntomas y los especificadores del TOC; explicar los modelos conductual, cognitivos y neurobiológicos del TOC y la evidencia sobre la supresión del pensamiento; describir el trastorno dismórfico corporal, la acumulación, la tricotilomanía y la excoriación y los cambios de la CIE-11; diferenciar el TOC del TPOC, la rumiación depresiva y la preocupación.

8.1 El TOC: clínica, dimensiones, insight y epidemiología

El **trastorno obsesivo-compulsivo** (TOC) se define por **obsesiones**, **compulsiones** o, lo más habitual, ambas.

- Las **obsesiones** son pensamientos, impulsos o imágenes **recurrentes y persistentes** que se viven como **intrusivos y no deseados** y que causan ansiedad o malestar. La persona intenta ignorarlos, suprimirlos o **neutralizarlos** con otro pensamiento o acto.
- Las **compulsiones** son conductas (lavarse, comprobar, ordenar) o **actos mentales** (contar, rezar, repetir frases en silencio) repetitivos que la persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión o según reglas rígidas. Buscan reducir el malestar o evitar algo temido, pero no están conectadas de forma realista con lo que pretenden evitar o son claramente excesivas.

Para el diagnóstico, los síntomas deben consumir **más de una hora al día** o causar malestar o deterioro significativos. Que una compulsión pueda ser mental es un punto clave: hay personas con TOC sin rituales visibles, que pasan horas «comprobando» recuerdos o repitiendo frases para anular un pensamiento.

El TOC es **egodistónico**: la persona vive las obsesiones como ajenas a lo que quiere y a cómo es. Un ejemplo: Raúl, padre reciente, tiene la imagen intrusiva de hacer daño a su bebé al pasar junto a un cuchillo. Le horroriza, esconde los cuchillos, evita bañar al niño solo y repasa mentalmente cada momento del día para asegurarse de que no hizo nada. El contenido del pensamiento choca con sus valores, y precisamente por eso le angustia tanto.

Dimensiones de síntomas. Más que subtipos cerrados, se describen dimensiones que pueden combinarse en la misma persona:

Dimensión	Obsesión típica	Compulsión típica
Contaminación y limpieza	Miedo a gérmenes, a contagiar o a ensuciarse	Lavados, duchas largas, desinfectar
Comprobación y daño	Miedo a causar un accidente, un incendio o un robo	Comprobar puertas, el gas, repasar trayectos
Simetría y orden	Necesidad de que las cosas estén «exactamente bien»	Ordenar, alinear, repetir hasta que «encaje»
Pensamientos inaceptables	Contenidos sexuales, religiosos o agresivos	Neutralización mental, rezar, buscar tranquilización

La **acumulación**, que antes se consideraba una dimensión del TOC, es hoy un trastorno separado (apartado 8.4).

Especificadores. El DSM-5-TR pide indicar el grado de *insight*: **bueno o aceptable** (la persona reconoce que sus creencias obsesivas probablemente no son ciertas), **pobre** (cree que probablemente lo son) o **ausente, con creencias delirantes** (está convencida de que son ciertas). En este último caso se mantiene el diagnóstico de TOC y **no** se diagnostica un trastorno psicótico. También se especifica si está **relacionado con tics**, cuando hay

historia actual o pasada de un trastorno de tics. La distinción entre obsesión e inserción de pensamiento se vio en la Unidad 6.

Epidemiología y curso. La prevalencia anual se sitúa aproximadamente entre el **1,1 y el 1,8 %**. El inicio es **bimodal**: un pico en la infancia, más frecuente en varones, y otro en la adultez temprana; la mediana de inicio ronda los 19-20 años. El curso suele ser crónico, con fluctuaciones, y muchas personas tardan años en consultar por vergüenza del contenido de sus obsesiones. La gravedad se evalúa con instrumentos como la Y-BOCS (Evaluación Psicológica).

8.2 Por qué se mantiene el TOC: modelos explicativos

El modelo conductual. La teoría bifactorial de Mowrer (Unidad 7) se aplicó al TOC: la obsesión adquiere capacidad de generar ansiedad y la **compulsión**, al reducirla, se **refuerza negativamente**. Cada ritual impide comprobar que el malestar habría bajado solo y que lo temido no ocurre. Este modelo fundamenta la **exposición con prevención de respuesta**, el tratamiento psicológico de elección (Tratamientos).

El modelo cognitivo de Salkovskis (1985). Su punto de partida es que las **intrusiones son normales**: casi toda la población tiene pensamientos intrusivos de contenido parecido a las obsesiones (Rachman y De Silva, 1978). Lo patológico no es el pensamiento, sino **cómo se valora**.

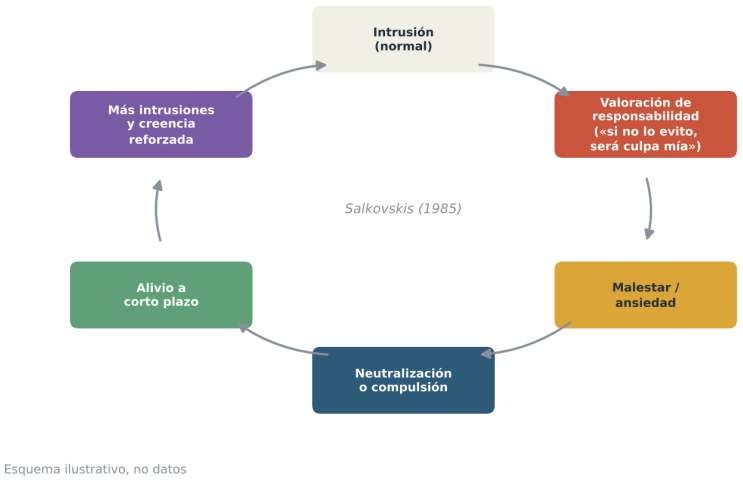


Figura 8.1. **Modelo cognitivo de Salkovskis.** Una intrusión normal se valora como señal de responsabilidad, genera malestar y lleva a neutralizar; el alivio inmediato refuerza la creencia y aumenta las intrusiones. Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.1, la clave es la **valoración de responsabilidad excesiva**: «si he pensado que la puerta podría estar abierta y entran a robar, seré culpable». Esa valoración motiva la **neutralización**, que alivia a corto plazo y, a la larga, confirma la creencia y vuelve más frecuente la intrusión.

Rachman (1997, 1998) subrayó la **interpretación catastrófica del significado** de las intrusiones («si pienso esto, es que en el fondo soy peligroso») y describió la **fusión pensamiento-acción**, con dos formas:

- **Moral**: pensar algo es tan malo como hacerlo.
- **Probabilidad**: pensar algo hace más probable que ocurra.

Las creencias del OCCWG. El grupo internacional de trabajo sobre cogniciones obsesivo-compulsivas (OCCWG) identificó **seis dominios de creencias**: responsabilidad excesiva, sobrestimación de la amenaza, importancia de los pensamientos, necesidad de controlarlos, perfeccionismo e intolerancia a la incertidumbre. Ninguno es exclusivo del TOC, pero juntos describen bien su terreno cognitivo.

La supresión del pensamiento: el oso blanco. Wegner et al. (1987) pidieron a los participantes que no pensaran en un oso blanco.

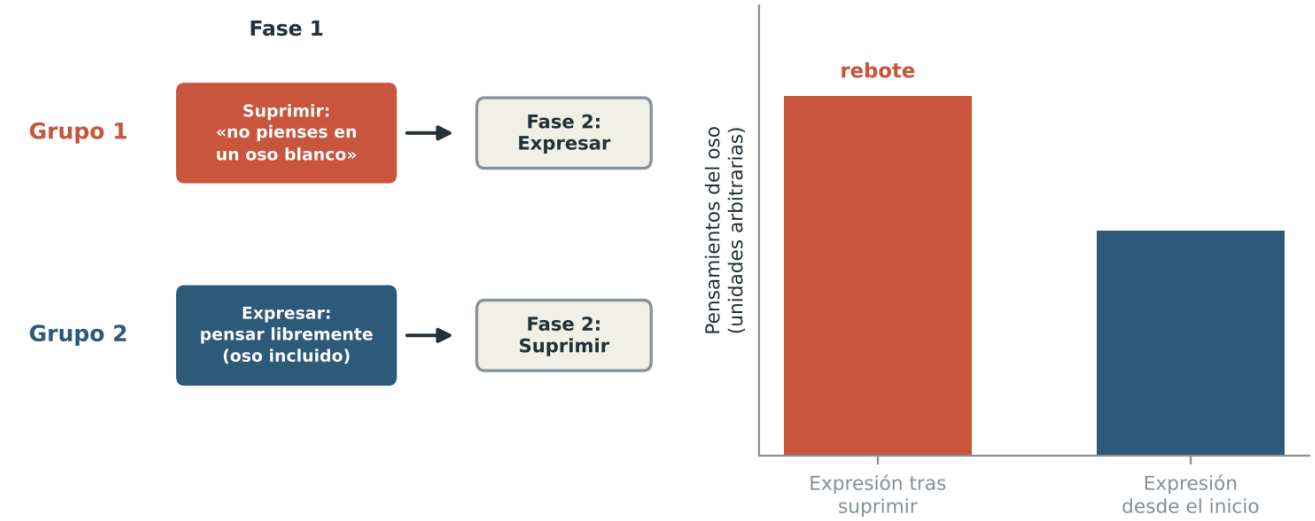


Figura 8.2. **El diseño del oso blanco (Wegner et al., 1987).** Un grupo suprime primero y luego puede expresar el pensamiento; otro lo expresa desde el inicio. Las barras ilustran el rebote en la fase de expresión del primer grupo. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.2, el grupo que primero suprimía mostraba después **más** pensamientos sobre el oso que el que lo expresaba desde el principio: el **efecto rebote**. La idea se popularizó como «intentar no pensar en algo siempre lo multiplica», pero el metaanálisis de Abramowitz, Tolin y Street (2001) encontró un rebote **pequeño-moderado** y ningún efecto inmediato consistente durante la propia supresión. El efecto parece relacionarse con la **carga cognitiva** (Wang et al., 2020). La conclusión práctica se mantiene, aunque con menos dramatismo: intentar controlar las intrusiones no las elimina y puede hacerlas más salientes.

Bases neurobiológicas. Los estudios de neuroimagen implican los **circuitos corticoestriado-talamocorticales** (CSTC), en especial la corteza orbitofrontal, el cingulado anterior y el núcleo caudado. Su anatomía y neurotransmisión se estudian en Psicología Fisiológica; aquí interesa que el TOC es un buen ejemplo de trastorno en el que los modelos cognitivos y los neurobiológicos se complementan.

8.3 Trastorno dismórfico corporal, referencia olfativa e hipocondría en la CIE-11

El trastorno dismórfico corporal (TDC) consiste en la preocupación por uno o más **defectos percibidos en el aspecto** que no son observables o parecen leves a los demás: la nariz, la piel, el pelo, la simetría de la cara. En algún momento aparecen **conductas o actos mentales repetitivos** en respuesta a la preocupación: mirarse al espejo durante mucho tiempo (o evitarlo), compararse, camuflar la zona, buscar que otros confirmen que no se nota. Al igual que en el TOC, se especifica el grado de *insight*, que a menudo es pobre. Existe el especificador **dismorfia muscular**, cuando la preocupación es que el cuerpo es demasiado pequeño o poco musculoso, más frecuente en varones. Su prevalencia ronda el **2 %**, y el **riesgo de suicidio es elevado**, por lo que no debe tomarse como simple vanidad. Si la preocupación se refiere a la grasa o al peso en el contexto de un trastorno alimentario, el diagnóstico es este último (Unidad 16).

Un ejemplo: Iván, de 19 años, está convencido de que tiene la mandíbula torcida. Ha dejado de subir fotos, pasa horas comparando su perfil con el de otros y ha pedido presupuesto para dos cirugías. Sus amigos no ven nada raro.

El síndrome de referencia olfativa. Es una categoría **nueva de la CIE-11**. La persona está preocupada de forma persistente por la creencia de **desprender un olor corporal desagradable** (mal aliento, sudor) que los demás no perciben o apenas notan. Se acompaña de mucha autoconciencia, a menudo de ideas de referencia («se han apartado porque huelo») y de conductas repetitivas como ducharse una y otra vez, oler la ropa, usar perfume en exceso o evitar el contacto social. En el DSM-5-TR no tiene categoría propia y se incluiría entre los otros trastornos especificados del grupo.

La hipocondría. La CIE-11 coloca la **hipocondría** dentro del grupo obsesivo-compulsivo. La define como la preocupación persistente o el miedo a padecer una o más enfermedades graves o progresivas, con conductas repetitivas (examinarse el cuerpo, buscar información, pedir pruebas) o una evitación desadaptativa. El DSM-5-TR sigue otro camino: ya no usa el término «hipocondría» y la reparte entre la **ansiedad por enfermedad** y el **trastorno de síntomas somáticos**, en el capítulo de síntomas somáticos (Unidad 14). La ubicación distinta refleja un debate de fondo: ¿la hipocondría se parece más al TOC, por sus comprobaciones y su búsqueda de seguridad, o a los cuadros centrados en el cuerpo?

Trastorno	DSM-5-TR	CIE-11
TOC	TOC y trastornos relacionados	Trastornos obsesivo-compulsivos o relacionados
Dismórfico corporal	TOC y relacionados	Obsesivo-compulsivos o relacionados (reubicado)
Referencia olfativa	Sin categoría propia	Categoría nueva del grupo
Hipocondría	Ansiedad por enfermedad, en síntomas somáticos	Hipocondría, en el grupo obsesivo-compulsivo
Acumulación	TOC y relacionados	Obsesivo-compulsivos o relacionados (nueva)
Tricotilomanía y excoriación	TOC y relacionados	Conductas repetitivas centradas en el cuerpo, en el mismo grupo

La tabla muestra la tendencia común de ambos sistemas: reunir en un mismo capítulo los cuadros que comparten **preocupaciones repetitivas** y **conductas repetitivas** dirigidas a reducir el malestar. La CIE-11 lleva esta lógica más lejos al incluir la referencia olfativa y la hipocondría.

8.4 Acumulación, tricotilomanía y excoriación; TOC frente a TPOC, rumiación y preocupación

El trastorno de acumulación es una **dificultad persistente para desprenderse de posesiones**, con independencia de su valor real. Se debe a la necesidad percibida de guardarlas y al malestar que produce deshacerse de ellas. El resultado es una acumulación que **congestiona los espacios vitales** hasta impedir su uso: no se puede cocinar porque la cocina está llena de periódicos, o no se puede dormir en la cama. Si hay zonas despejadas es porque otras personas han intervenido. Se especifica si hay **adquisición excesiva** (comprar o recoger cosas que no se necesitan) y el grado de *insight*, que a menudo es pobre: la persona no ve el problema que sí ven sus familiares. Su prevalencia se estima aproximadamente entre el 2 y el 6 % y el cuadro **empeora con la edad**. A diferencia del TOC, guardar no suele vivirse como absurdo ni como algo impuesto.

La tricotilomanía (arrancarse el pelo) y **la excoriación** (pellizcarse o rascarse la piel hasta producir lesiones) son **conductas repetitivas centradas en el cuerpo**. Ambas exigen intentos repetidos de reducir o dejar la conducta y causan malestar o deterioro. A diferencia de las compulsiones, **no suelen estar precedidas por una obsesión**: muchas veces aparecen en momentos de aburrimiento o tensión, y pueden hacerse de forma casi automática, mientras se estudia o se ve una serie. La prevalencia de la tricotilomanía ronda el 1-2 % y la de la excoriación, el 1,4-2 %, con mayoría de mujeres.

Diagnóstico diferencial. Varios fenómenos se parecen al TOC y conviene distinguirlos con precisión:

Fenómeno	Contenido	Cómo se vive	Qué lo acompaña
Obsesión (TOC)	Intrusiones a menudo irracionales o contrarias a los valores	Egodistónica, ajena y no deseada	Compulsiones o neutralización
Rasgos del TPOC	Orden, perfeccionismo, control, reglas	Egosintónica: «así deben hacerse las cosas»	Rigidez generalizada, sin intrusiones

Fenómeno	Contenido	Cómo se vive	Qué lo acompaña
Rumiación depresiva	Pérdidas, culpa, fracasos, sobre todo del pasado	Congruente con el ánimo bajo	Tristeza e inutilidad
Preocupación (TAG)	Problemas cotidianos y realistas, orientada al futuro	Egosintónica, se vive como útil	Tensión y ansiedad difusa

El contraste más preguntado es el del **TOC** frente al **trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva** (TPOC). Elena revisa diez veces que el gas está cerrado aunque sabe que lo cerró, sufre al hacerlo y querría dejarlo: es TOC. Su jefe exige que cada informe siga un formato rígido, no delega y cree que su forma de trabajar es la correcta, aunque no sufre por ello: son rasgos de TPOC (Unidad 12). Pueden coexistir, pero no son lo mismo.

Con la **rumiación** y la **preocupación**, el TOC comparte el pensamiento repetitivo, un proceso transdiagnóstico (Unidad 4). La diferencia está en el contenido y en la vivencia: la rumiación da vueltas a lo ocurrido; la preocupación anticipa problemas reales posibles; la obsesión irrumpe como algo extraño y obliga a neutralizar.

Consenso y debate

Consenso: los pensamientos intrusivos son casi universales; lo que define el TOC es la valoración que se hace de ellos y las conductas de neutralización, que se refuerzan negativamente (Salkovskis, 1985). El TOC es egodistónico y se distingue del TPOC. La exposición con prevención de respuesta es el tratamiento psicológico de referencia.

Debate: el tamaño real del efecto rebote de la supresión, que el metaanálisis sitúa en pequeño-moderado (Abramowitz, Tolin y Street, 2001), y su relación con la carga cognitiva. También se discute qué cuadros deben formar el grupo obsesivo-compulsivo: la CIE-11 incluye la hipocondría y la referencia olfativa, y el DSM-5-TR no.

Mito frecuente

Mito: «Tener TOC es ser muy ordenado y maniático con la limpieza».

Realidad: el TOC es un trastorno **egodistónico** que causa gran malestar y consume tiempo: las obsesiones se viven como intrusas y los rituales, como algo que la persona querría dejar de hacer. Muchas obsesiones no tienen nada que ver con el orden, como las de daño o las religiosas. El gusto por el orden y el perfeccionismo vividos como propios y correctos se acercan más a los rasgos del TPOC (Unidad 12).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Obsesión	Pensamiento, impulso o imagen recurrente, intrusivo y no deseado que genera malestar
Compulsión	Conducta o acto mental repetitivo para reducir el malestar o prevenir algo temido
Neutralización	Acción manifiesta o mental que intenta anular una intrusión o sus consecuencias
Egodistonía	Vivencia de un pensamiento o conducta como ajeno, no deseado y contrario a uno mismo

Concepto	Definición
Responsabilidad excesiva	Creencia de poder causar o tener que impedir daños graves (Salkovskis, 1985)
Fusión pensamiento-acción	Creer que pensar algo equivale a hacerlo o lo hace más probable (Rachman)
Efecto rebote	Aumento de un pensamiento tras intentar suprimirlo (Wegner et al., 1987)
Dismorfia muscular	Especificador del TDC: creer que el cuerpo es demasiado pequeño o poco musculoso

Clave PIR

Prioridad alta. Se preguntan la definición de obsesión y compulsión (incluidos los actos mentales), los especificadores de *insight*, el modelo de Salkovskis, la fusión pensamiento-acción y qué trastornos forman el grupo en cada sistema. Trampas típicas: creer que el *insight* ausente obliga a diagnosticar psicosis, confundir TOC y TPOC, situar la hipocondría en el mismo capítulo en el DSM-5-TR y en la CIE-11, y exagerar el efecto del oso blanco.

Autoevaluación

1. Según Salkovskis (1985), lo que convierte una intrusión en obsesión es…
a) la mera presencia de pensamientos intrusivos
b) un déficit primario en los circuitos motores
c) la valoración de responsabilidad excesiva

2. Creer que pensar en un accidente hace más probable que ocurra es un ejemplo de…
a) fusión pensamiento-acción de probabilidad
b) fusión pensamiento-acción moral
c) intolerancia a la incertidumbre

3. Según el metaanálisis de Abramowitz, Tolin y Street (2001), el efecto rebote de la supresión es…
a) grande y constante durante la supresión
b) pequeño-moderado y sin efecto inmediato consistente
c) inexistente cuando se controla la carga cognitiva

4. En la CIE-11, la hipocondría se clasifica en el grupo de…
a) trastornos de distrés corporal
b) trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo
c) trastornos obsesivo-compulsivos o relacionados

5. Un perfeccionismo rígido que la persona considera correcto y que no le causa malestar sugiere…
a) rasgos de TPOC
b) un TOC de simetría
c) un trastorno de acumulación

Soluciones

1 c. Las intrusiones son normales; lo patológico es valorarlas como señal de responsabilidad y neutralizarlas. **2 a.** La fusión moral equipara pensar y hacer; la de probabilidad supone que pensar provoca lo temido. **3 b.** El rebote existe, pero es más modesto de lo que sugiere la versión popular. **4 c.** El DSM-5-TR, en cambio, la reparte entre ansiedad por enfermedad y síntomas somáticos. **5 a.** Es egosintónico; el TOC es egodistónico y produce malestar.

Unidad 9 · Trastornos relacionados con el trauma y el estrés

Objetivos: describir los criterios del TEPT en el DSM-5-TR, sus especificadores y sus principales modelos; comparar el TEPT y el TEPT complejo de la CIE-11 y valorar la evidencia sobre la memoria traumática; diferenciar el estrés agudo, los trastornos de adaptación y los trastornos de apego de la infancia; distinguir el duelo normal, la depresión y el trastorno de duelo prolongado.

9.1 Trastorno de estrés postraumático

En el DSM-5-TR, el grupo de trastornos relacionados con el trauma y el estrés incluye el trastorno de apego reactivo, el de relación social desinhibida, el **trastorno de estrés postraumático** (TEPT), el trastorno de estrés agudo, los trastornos de adaptación y el **trastorno de duelo prolongado**, añadido en 2022. Todos exigen un **suceso o estresor** identificable en su origen.

Criterios del DSM-5-TR. El **criterio A** exige la exposición a la **muerte, una lesión grave o violencia sexual**, reales o como amenaza, por una de estas vías: vivirla directamente, presenciarla, saber que le ocurrió a un familiar o amigo íntimo (si es una muerte, debe haber sido violenta o accidental) o exponerse de forma repetida o extrema a detalles aversivos, como los primeros intervinientes. Verlo en los medios no cuenta, salvo por trabajo. Después se exigen cuatro grupos de síntomas:

Grupo	Mínimo	Ejemplos
B. Intrusión	1	Recuerdos involuntarios, pesadillas, *flashbacks* disociativos, malestar o reacciones fisiológicas ante señales
C. Evitación	1	Evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos; evitar personas, lugares o conversaciones
D. Alteraciones negativas de cogniciones y ánimo	2	Amnesia de aspectos del suceso, creencias negativas, culpa distorsionada, desapego, incapacidad de sentir emociones positivas
E. Alteraciones de la activación y la reactividad	2	Irritabilidad, conducta imprudente o autodestructiva, hipervigilancia, sobresalto, problemas de concentración y sueño

La alteración debe durar **más de un mes** y causar malestar o deterioro. Hay dos especificadores: **con síntomas disociativos** (despersonalización o desrealización persistentes) y **con expresión retardada**, cuando los criterios completos no se cumplen hasta **al menos 6 meses** después del suceso, aunque algunos síntomas aparezcan antes. Para los **menores de 6 años** hay criterios adaptados, que piden menos síntomas: al menos uno de intrusión, uno de evitación o de alteración cognitiva y del ánimo, y dos de activación; los recuerdos intrusivos pueden expresarse en el juego.

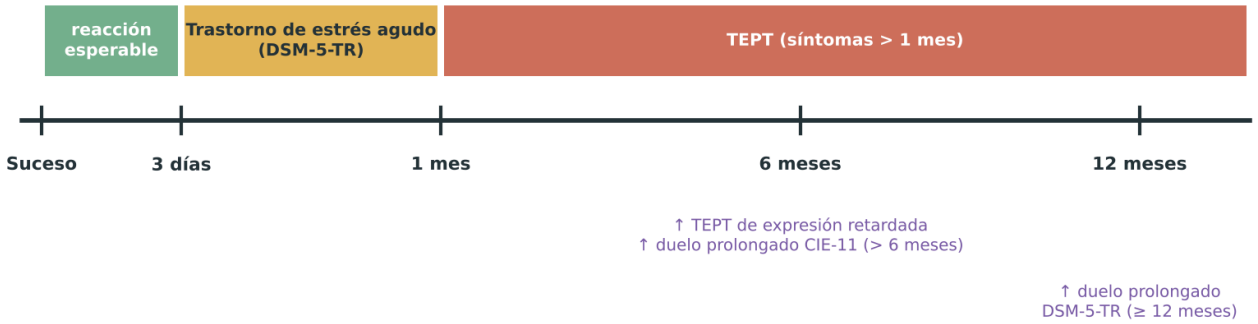


Figura 9.1. **Qué diagnóstico corresponde según el tiempo transcurrido.** Desde el suceso: reacción esperable en los primeros días, trastorno de estrés agudo hasta el mes, TEPT a partir del mes, expresión retardada y duelo prolongado de la CIE-11 desde los 6 meses, y duelo prolongado del DSM-5-TR desde los 12. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.1, el tiempo es clave en el diagnóstico diferencial del grupo.

Epidemiología. La **mayoría de las personas expuestas a un trauma no desarrolla TEPT**. La prevalencia vital se estima aproximadamente en un 4-8 % en países de renta alta, mayor en mujeres y tras la violencia interpersonal, sobre todo la sexual. Aumentan el riesgo la gravedad del trauma, la falta de apoyo social, la disociación peritraumática y la historia psicopatológica previa.

Modelos explicativos.

- **Bifactorial de Mowrer.** Las señales del trauma quedan condicionadas al miedo y la evitación lo mantiene (Unidad 7).
- **Procesamiento emocional** (Foa y Kozak, 1986). El trauma deja una **estructura de miedo patológica** que se modifica cuando se **activa** y se le aporta **información incompatible** con ella. Fundamenta la exposición prolongada (Tratamientos).
- **Modelo cognitivo** (Ehlers y Clark, 2000). El TEPT persiste cuando la persona siente una **amenaza actual**, no pasada. Esa sensación procede de **valoraciones negativas** del trauma o de sus secuelas («nunca estaré a salvo», «fue culpa mía») y de una **memoria del trauma mal elaborada** y poco contextualizada, que se reactiva con claves sensoriales y se vive como si ocurriera ahora. La evitación y la supresión impiden actualizar esa memoria.
- **Representación dual** (Brewin y colaboradores). Distingue **memorias sensoriales**, que se activan ante señales situacionales y explican los *flashbacks*, de **memorias verbales** contextualizadas, que sitúan el suceso en el pasado.

Un ejemplo: Sara sufrió un atropello hace tres meses. Cuando oye un frenazo nota el golpe «como si estuviera pasando», evita esa calle, se culpa, está convencida de que ya no hay ningún lugar seguro, se sobresalta con cualquier ruido y duerme mal: el cuadro es compatible con un TEPT.

9.2 El TEPT complejo de la CIE-11 y el debate sobre la memoria traumática

El TEPT en la CIE-11. La CIE-11 adopta una definición más estrecha, centrada en **tres núcleos**: **reexperimentación en el presente** (recuerdos vívidos, *flashbacks* o pesadillas que se viven como si ocurrieran ahora), **evitación** y **sensación persistente de amenaza actual** (hipervigilancia, sobresalto). Los síntomas deben durar **al menos varias semanas**.

El TEPT complejo. Es una categoría que **solo existe en la CIE-11**. Aparece tras sucesos **prolongados o repetidos** de los que es difícil o imposible escapar, como la tortura, la esclavitud, la violencia doméstica

prolongada o el abuso infantil repetido. Exige cumplir los criterios del TEPT y, además, **alteraciones de la autoorganización**:

- **Desregulación afectiva**: reacciones emocionales intensas, dificultad para calmarse o, al contrario, embotamiento.
- **Autoconcepto negativo**: sentirse inútil, derrotado o sin valor, con culpa o vergüenza ligadas al trauma.
- **Dificultades en las relaciones**: problemas para mantener vínculos y sentirse cerca de los demás.

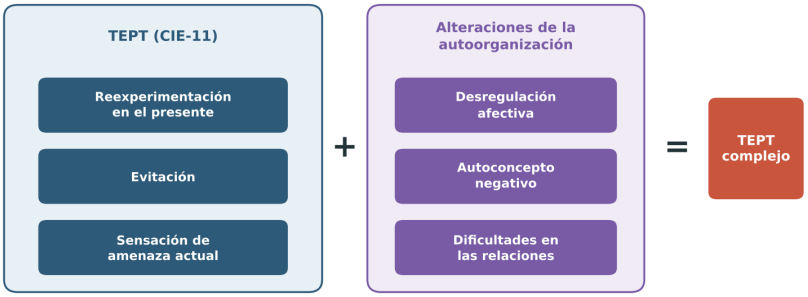


Figura 9.2. **Del TEPT al TEPT complejo en la CIE-11.** A los tres núcleos del TEPT (reexperimentación, evitación y amenaza actual) se suman tres alteraciones de la autoorganización: desregulación afectiva, autoconcepto negativo y dificultades relacionales. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.2, el TEPT complejo incluye los requisitos del TEPT más un segundo bloque de síntomas; se diagnostica uno u otro, no ambos. Sustituye a la «transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica» de la CIE-10, y los estudios de campo apoyan la distinción entre TEPT y TEPT complejo. El solapamiento con el trastorno límite de la personalidad es un tema de discusión clínica (Unidad 12).

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Estructura del TEPT	Cuatro grupos: intrusión, evitación, cogniciones y ánimo, activación	Tres núcleos: reexperimentación, evitación, amenaza actual
Duración del TEPT	Más de un mes	Al menos varias semanas
TEPT complejo	No existe	Sí, con alteraciones de la autoorganización
Estrés agudo	Trastorno (3 días-1 mes)	Reacción de estrés agudo, no es trastorno mental
Duelo prolongado	12 meses o más (6 en menores)	Más de 6 meses

El debate sobre la memoria traumática. El TEPT plantea una paradoja aparente: los recuerdos intrusivos son vívidos y persistentes, pero el criterio D incluye la amnesia de aspectos importantes del suceso. De ahí surge una pregunta polémica: ¿pueden los recuerdos traumáticos **reprimirse** durante años y **recuperarse** después con fidelidad?

La revisión de Otgaar et al. (2019) concluyó que el apoyo científico a la **represión inconsciente** es débil. La creencia en ella, sin embargo, está muy extendida: alrededor del 58 % en una muestra de 4.745 personas. Además, las técnicas sugestivas, como la imaginación guiada de supuestos abusos o la hipnosis para «recuperar» recuerdos, pueden generar **recuerdos falsos** vividos con total convicción. Brewin (2021) matizó algunos de estos argumentos, pero existe acuerdo en que un recuerdo recuperado sin corroboración no debe aceptarse sin reservas. Esto no significa negar el trauma: los supervivientes suelen recordarlo demasiado, no demasiado poco. La memoria reconstructiva se estudia en Memoria, y la amnesia disociativa, en la Unidad 14.

9.3 Estrés agudo y trastornos de adaptación

El trastorno de estrés agudo (TEA) del DSM-5-TR exige el mismo tipo de exposición que el TEPT y la presencia de **al menos 9 de 14 síntomas** de cinco categorías: **intrusión, estado de ánimo negativo, disociación, evitación y alerta**. Se diagnostica entre **3 días y 1 mes** después del trauma. Si los síntomas persisten más de un mes, hay que valorar un TEPT. Aunque se pensó como un modo de detectar pronto a las personas en riesgo, el TEA **no predice bien** quién desarrollará un TEPT: muchas personas con TEA se recuperan y otras desarrollan TEPT sin haber tenido TEA.

En la **CIE-11**, la **reacción de estrés agudo no es un trastorno mental**: se considera una respuesta esperable ante un suceso extremo y se clasifica entre los factores que influyen en el estado de salud. El mensaje es útil: sentirse aturdido o dormir mal los primeros días tras una catástrofe es normal.

Los trastornos de adaptación son síntomas emocionales o conductuales que aparecen en respuesta a un **estresor identificable**, no necesariamente traumático: un despido, una ruptura, una mudanza o una enfermedad. Sus requisitos en el DSM-5-TR son:

- Inicio en los **3 meses** siguientes al estresor.
- Malestar desproporcionado a la intensidad del estresor, teniendo en cuenta el contexto cultural, o deterioro significativo.
- No cumplir criterios de otro trastorno ni ser una exacerbación de uno previo, y no corresponder a un duelo normal.
- Remisión en los **6 meses** siguientes al fin del estresor o de sus consecuencias.

Se especifican subtipos: con estado de ánimo deprimido, con ansiedad, mixto con ansiedad y estado de ánimo deprimido, con alteración de la conducta, mixto con alteración de las emociones y la conducta, y no especificado. El DSM-5-TR aclara que los síntomas **subumbrales** que aparecen ante un estresor se codifican como trastorno de adaptación. La CIE-11 lo describe a partir de dos rasgos: la **preocupación** por el estresor y sus consecuencias, y el **fallo de adaptación**, que interfiere en la vida diaria; suele resolverse en unos 6 meses.

Un ejemplo: Pablo empezó a dormir mal, a irritarse con su pareja y a faltar al trabajo dos semanas después de que anunciaran el cierre de su empresa. No tiene síntomas suficientes para una depresión, pero su malestar es mayor de lo esperable y le impide funcionar. Es un trastorno de adaptación mixto con alteración de las emociones y la conducta.

Trastornos de la infancia ligados a la privación de cuidados. Dos diagnósticos del grupo aparecen en niños que han sufrido un **cuidado gravemente insuficiente**: negligencia, cambios repetidos de cuidadores o crianza en instituciones con pocos adultos por niño.

- **Trastorno de apego reactivo**: patrón inhibido y emocionalmente retraído con los cuidadores; el niño rara vez busca consuelo cuando está mal ni responde a él.
- **Trastorno de relación social desinhibida**: el niño se acerca e interactúa con adultos desconocidos sin la reticencia habitual, no comprueba si su cuidador está cerca y podría irse con un extraño.

El desarrollo del apego se estudia en Psicología del Desarrollo.

9.4 El trastorno de duelo prolongado

El **duelo** es la reacción normal a la muerte de un ser querido. Puede ser muy intenso y durar mucho tiempo sin ser patológico. El DSM-5-TR incorporó en 2022 el **trastorno de duelo prolongado**, que la CIE-11 ya incluía. Ambos sistemas lo describen como un duelo que persiste más allá de lo esperable y causa malestar o deterioro significativos.

DSM-5-TR. Exige que hayan pasado **al menos 12 meses** desde la muerte (**6 meses en niños y adolescentes**) y una respuesta de duelo persistente, presente la mayoría de los días y casi a diario durante al menos el último

mes, con **anhelo intenso** de la persona fallecida o **preocupación** constante por ella. Debe acompañarse de **al menos 3 síntomas** de una lista que incluye:

- Alteración de la identidad, como si una parte de uno hubiera muerto.
- Marcada incredulidad ante la muerte.
- Evitación de lo que recuerda que la persona ha muerto.
- Dolor emocional intenso (rabia, amargura, tristeza).
- Dificultad para reintegrarse en las relaciones y actividades.
- Embotamiento emocional.
- Sensación de que la vida no tiene sentido.
- Soledad intensa.

CIE-11. Exige que la respuesta persista **más de 6 meses** tras la pérdida y que **supere claramente las normas** sociales, culturales o religiosas de la persona. Esta referencia cultural es importante: en algunas comunidades, el luto visible durante años es lo esperable.

La prevalencia se estima aproximadamente entre el 4 y el 10 % de las personas en duelo: la gran mayoría elabora la pérdida sin necesidad de diagnóstico.

Duelo normal, depresión y duelo prolongado. La distinción es clínica y se pregunta a menudo:

Rasgo	Duelo normal	Episodio depresivo	Duelo prolongado
Foco	La pérdida	Generalizado: uno mismo, el mundo, el futuro	La persona fallecida
Curso del malestar	En oleadas, con momentos de alivio	Ánimo bajo persistente	Anhelo persistente que no cede con el tiempo
Autoestima	Conservada	Culpa e inutilidad generalizadas	Puede haber alteración de la identidad
Placer	Posible con recuerdos agradables	Anhedonia amplia	Dificultad para implicarse en la vida

Desde el DSM-5 desapareció la exclusión por duelo del episodio depresivo: si tras una pérdida se cumplen los criterios de depresión, puede diagnosticarse, y el clínico juzga el contexto (Unidad 10).

Un ejemplo: Carmen perdió a su hija hace año y medio. Sigue poniendo la mesa para dos, no ha vuelto a ver a sus amigas, siente que una parte de ella murió también y no consigue imaginar un futuro. Su dolor no aparece en oleadas, sino que lo ocupa todo, y la ha apartado de su vida. Es un cuadro compatible con un trastorno de duelo prolongado. El debate de fondo es el riesgo de **patologizar** el dolor normal; por eso ambos sistemas exigen duraciones largas, un deterioro claro y el respeto a las normas culturales.

Consenso y debate

Consenso: la mayoría de las personas expuestas a un trauma no desarrolla TEPT. La evitación y una memoria del trauma mal integrada contribuyen a mantenerlo (Ehlers y Clark, 2000). El duelo intenso es normal y solo una minoría desarrolla un duelo prolongado.

Debate: la validez del TEPT complejo como entidad separada, que la CIE-11 reconoce y el DSM-5-TR no, y su relación con el trastorno límite de la personalidad. También se discute la naturaleza de la memoria traumática: Otgaar et al. (2019) y Brewin (2021) difieren en sus matices, aunque coinciden en la cautela ante los recuerdos recuperados sin corroboración.

Mito frecuente

Mito: «Los recuerdos traumáticos suelen reprimirse y pueden recuperarse años después tal como ocurrieron, por ejemplo con hipnosis».

Realidad: el apoyo a la represión inconsciente es débil, la creencia en ella está muy extendida (alrededor del 58 % de 4.745 personas) y las técnicas sugestivas pueden crear recuerdos falsos (Otgaar et al., 2019). Brewin (2021) matiza parte de estos argumentos, pero ambos coinciden en no aceptar sin reservas recuerdos recuperados que no estén corroborados.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Criterio A	Exposición a muerte, lesión grave o violencia sexual, real o como amenaza
Expresión retardada	Especificador del TEPT cuando los criterios completos aparecen 6 meses o más tras el suceso
Estructura de miedo	Red de memoria del trauma que se modifica al activarla con información nueva (Foa y Kozak, 1986)
Amenaza actual	Sensación de peligro presente que mantiene el TEPT (Ehlers y Clark, 2000)
TEPT complejo	Diagnóstico de la CIE-11: TEPT más alteraciones de la autoorganización
Trastorno de estrés agudo	Síntomas postraumáticos entre 3 días y 1 mes tras el suceso (DSM-5-TR)
Trastorno de adaptación	Malestar desproporcionado ante un estresor, iniciado en 3 meses y resuelto en 6
Duelo prolongado	Anhelo o preocupación por el fallecido 12 meses o más (DSM-5-TR) o más de 6 meses (CIE-11)

Clave PIR

Prioridad alta. Se preguntan el criterio A y sus vías, el número de síntomas por grupo, las duraciones y las diferencias entre sistemas. Trampas típicas: confundir el estrés agudo (3 días-1 mes) con el TEPT (más de un mes), creer que el TEPT complejo existe en el DSM-5-TR, olvidar que la reacción de estrés agudo no es un trastorno en la CIE-11 y mezclar los 12 meses del duelo prolongado del DSM-5-TR con los 6 de la CIE-11.

Autoevaluación

1. Dos semanas después de un accidente grave, una persona presenta intrusiones, evitación, disociación y alerta. Según el DSM-5-TR, el diagnóstico más adecuado es…
a) trastorno de estrés agudo
b) trastorno de estrés postraumático
c) TEPT con expresión retardada

2. El TEPT complejo es un diagnóstico que…
a) recogen tanto el DSM-5-TR como la CIE-11
b) solo aparece en el DSM-5-TR
c) solo aparece en la CIE-11

3. En adultos, el DSM-5-TR exige para el duelo prolongado que hayan pasado desde la muerte…
a) más de 6 meses
b) al menos 12 meses
c) al menos 2 años

4. Según Ehlers y Clark (2000), el TEPT se mantiene por…
a) una sensación de amenaza actual y una memoria del trauma mal elaborada
b) la represión inconsciente de todos los recuerdos del suceso
c) un déficit específico de habilidades sociales previo al trauma

5. En la CIE-11, la reacción de estrés agudo…
a) es un trastorno que dura de 3 días a 1 mes
b) es un subtipo del trastorno de adaptación
c) no se considera un trastorno mental

Soluciones

1 a. Han pasado menos de un mes; el TEPT exige más de un mes de duración. **2 c.** Es una aportación de la CIE-11 que el DSM-5-TR no incluye. **3 b.** La CIE-11 fija más de 6 meses, y el DSM-5-TR, 6 meses solo en niños y adolescentes. **4 a.** Las valoraciones negativas y la memoria poco contextualizada hacen que el trauma se viva como presente. **5 c.** Se considera una respuesta esperable y se clasifica entre los factores que influyen en el estado de salud.

Capítulo 5 · Estado de ánimo y psicosis

En 1899, Kraepelin separó la locura maníaco-depresiva, de curso episódico, de la *dementia praecox*, de curso más deteriorante. Más de un siglo después, esa división sigue organizando los manuales, aunque hoy se sabe que las fronteras son menos nítidas de lo que él pensaba. Este capítulo estudia primero los trastornos depresivos y bipolares, con sus modelos psicológicos y biológicos, y después la esquizofrenia y los demás trastornos psicóticos.

Unidad 10 · Depresión y trastorno bipolar

Objetivos: describir el episodio depresivo mayor y los demás trastornos depresivos según el DSM-5-TR y la CIE-11; explicar los modelos psicológicos de la depresión, incluida la revisión de la indefensión aprendida; valorar con espíritu crítico las hipótesis biológicas y los mitos sobre la serotonina y los genes candidatos; distinguir manía, hipomanía, trastorno bipolar I, bipolar II y ciclotimia.

10.1 Los trastornos depresivos: clínica, especificadores y epidemiología

Estar triste no es estar deprimido. La tristeza es una emoción normal que suele ceder con el tiempo. La **depresión** clínica es un síndrome: un cambio persistente del ánimo que arrastra el pensamiento, la conducta, el sueño, el apetito y la energía. Desde el DSM-5, los trastornos depresivos y los bipolares ocupan capítulos separados.

El episodio depresivo mayor. Exige **5 o más de 9 síntomas** durante **al menos 2 semanas**, que supongan un cambio respecto al funcionamiento previo. Al menos uno debe ser el **ánimo deprimido** o la **anhedonia** (pérdida de interés o de placer). Los demás son: cambio de peso o de apetito (más del 5 % del peso en un mes), insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento psicomotor observable por otros, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para concentrarse o decidir, y pensamientos de muerte, ideación o intento de suicidio. Debe causar malestar o deterioro y no deberse a una sustancia ni a otra afección médica. En niños y adolescentes, el ánimo puede ser **irritable**. El trastorno de depresión mayor requiere, además, que nunca haya habido un episodio maníaco o hipomaníaco.

Un ejemplo: Lucía lleva tres semanas sin disfrutar de nada. Se despierta a las cinco, ha perdido el apetito, le cuesta leer un correo entero y piensa que en el trabajo estarían mejor sin ella. No es un mal día: es un cambio sostenido.

El duelo. Desde el DSM-5 no hay exclusión por duelo: si tras una pérdida se cumplen los criterios, el clínico valora si existe además un episodio depresivo. En el duelo normal el dolor llega en oleadas centradas en la persona perdida y la autoestima se conserva; en la depresión el ánimo bajo es persistente y aparecen culpa e inutilidad generalizadas. El trastorno de duelo prolongado es otra categoría (Unidad 9).

Especificadores. Con ansiedad, con características mixtas, melancólicas, atípicas (reactividad del ánimo, hiperfagia, hipersomnia, «parálisis plúmbea» y sensibilidad al rechazo), psicóticas congruentes o no congruentes con el ánimo, con catatonía, con inicio en el periparto y con patrón estacional.

Otros trastornos depresivos:

- **Trastorno depresivo persistente**: ánimo deprimido la mayor parte del día, la mayoría de los días, durante **al menos 2 años** (1 año en menores, con ánimo que puede ser irritable), con al menos 2 de 6 síntomas y sin periodos libres de más de 2 meses.

- **Trastorno disfórico premenstrual**: síntomas afectivos intensos (labilidad, irritabilidad, ánimo bajo, ansiedad) en la semana previa a la menstruación, que mejoran al empezar esta.
- **Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo**: entre los 6 y los 18 años, con inicio antes de los 10; rabietas graves al menos 3 veces por semana e irritabilidad persistente durante al menos 12 meses.
- **Trastorno del estado de ánimo no especificado**: categoría nueva del DSM-5-TR para cuadros afectivos en los que aún no se puede decidir entre lo depresivo y lo bipolar.

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Síntomas del episodio	≥5 de 9	≥5 de 10 (añade la desesperanza)
Duración	≥2 semanas	≥2 semanas
Síntoma obligatorio	Ánimo deprimido o anhedonia	Al menos uno del grupo afectivo
Organización	Lista única	Grupos afectivo, cognitivo-conductual y neurovegetativo
Ansiedad y depresión	Especificador «con ansiedad»	Mantiene el trastorno mixto de ansiedad y depresión

Epidemiología. En el estudio ESEMeD-España, el episodio depresivo mayor fue el trastorno más frecuente: 3,9 % anual y 10,5 % a lo largo de la vida (Haro et al., 2006). Desde la adolescencia es aproximadamente el doble de frecuente en mujeres. Según el Global Burden of Disease, es la segunda causa mundial de años vividos con discapacidad. En muchas personas el curso es **recurrente**.

10.2 Modelos psicológicos de la depresión

La indefensión aprendida. Seligman y Maier (1967) y Overmier y Seligman (1967) usaron un **diseño triádico** con perros. En una primera fase, un grupo recibía descargas que podía interrumpir; otro, acoplado al primero, recibía exactamente las mismas descargas sin poder controlarlas; un tercero no recibía ninguna. En la segunda fase, todos pasaban a una caja de lanzadera en la que bastaba con saltar una barrera para escapar.

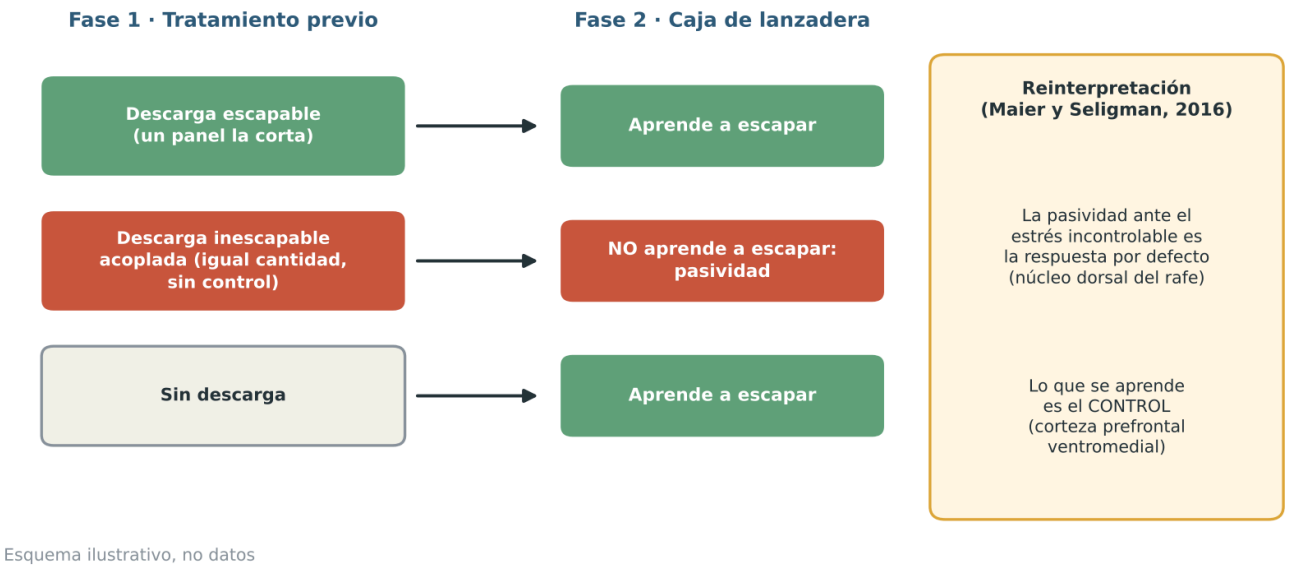


Figura 10.1. **El diseño triádico de la indefensión.** Tres grupos (descarga escapable, inescapable acoplada y sin descarga) pasan después a una caja de lanzadera; solo el grupo inescapable no aprende a escapar. El recuadro resume la reinterpretación de 2016: la pasividad es la respuesta por defecto y lo que se aprende es el control. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.1, solo el grupo que no había tenido control se quedaba quieto. La clave no era la cantidad de descarga, idéntica en los dos primeros grupos, sino su **incontrolabilidad**. Hiroto (1974) obtuvo

efectos parecidos en personas con ruido inescapable. La explicación original fue que el animal **aprendía** que sus respuestas no servían de nada.

Maier y Seligman (2016) revisaron esa explicación con datos neurocientíficos. La pasividad ante un estrés incontrolable es la **respuesta por defecto**, mediada por el núcleo dorsal del rafe; lo que se aprende es la **detección del control**, que depende de la corteza prefrontal ventromedial e inhibe esa respuesta. En sus propias palabras, la teoría original lo entendió al revés. Los fundamentos del condicionamiento se estudian en la asignatura de Aprendizaje.

Atribuciones y desesperanza. La **reformulación atribucional** (Abramson, Seligman y Teasdale, 1978) llevó la teoría al terreno cognitivo: la vulnerabilidad depende de atribuir los fracasos a causas **internas** («es culpa mía»), **estables** («siempre será así») y **globales** («me pasa en todo»). Quien suspende un examen y piensa «soy torpe» corre más riesgo que quien piensa «este examen era raro». La **teoría de la desesperanza** (Abramson, Metalsky y Alloy, 1989) propuso un subtipo de depresión por desesperanza, resultado de un estilo inferencial negativo (diátesis) que se activa ante sucesos estresantes.

El modelo cognitivo de Beck (1967). Su núcleo es la **tríada cognitiva**: una visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro.

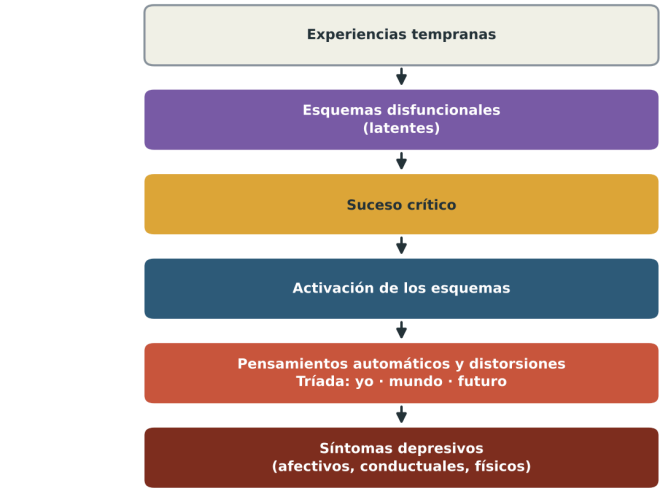


Figura 10.2. **Modelo cognitivo de la depresión de Beck.** Las experiencias tempranas forman esquemas disfuncionales; un suceso crítico los activa y aparecen pensamientos automáticos y distorsiones sobre el yo, el mundo y el futuro, que producen los síntomas depresivos. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como resume la figura 10.2, los **esquemas** depresógenos permanecen latentes hasta que un suceso los activa. A partir de ahí, la información se procesa con **distorsiones cognitivas**: abstracción selectiva, sobregeneralización, inferencia arbitraria, maximización y minimización, personalización y pensamiento dicotómico.

Otros modelos.

- **Lewinsohn (1974)**: la depresión surge de una baja tasa de **refuerzo positivo contingente a la respuesta**, por pocas actividades gratificantes, déficit de habilidades sociales o un entorno pobre. Es la base de la activación conductual (asignatura de Tratamientos).
- **Nolen-Hoeksema (1991)**, teoría de los estilos de respuesta: la **rumiación**, centrarse de forma repetitiva en los síntomas y en sus causas, prolonga e intensifica la depresión. Las mujeres rumian más, lo que explicaría parte de la diferencia entre sexos. La rumiación es hoy un proceso transdiagnóstico (Unidad 4).
- **Rehm**: déficits de **autocontrol** en la autoobservación, la autoevaluación y el autorrefuerzo.
- **Modelos interpersonales** (Coyne): la búsqueda insistente de apoyo puede acabar generando rechazo en el entorno.

10.3 Bases biológicas de la depresión y mitos

Genética. La heredabilidad de la depresión mayor es de alrededor del 37 % (Sullivan, Neale y Kendler, 2000): moderada y menor que la del trastorno bipolar o la esquizofrenia. Como en el resto de trastornos, la arquitectura genética es **poligénica**: muchas variantes de efecto muy pequeño. No existe un «gen de la depresión», sino muchas contribuciones pequeñas que se suman.

Durante años se buscaron genes concretos de gran efecto. El estudio más citado fue el de Caspi et al. (2003): las personas con el alelo corto del polimorfismo **5-HTTLPR**, del gen del transportador de serotonina, parecían deprimirse más tras sucesos vitales estresantes.

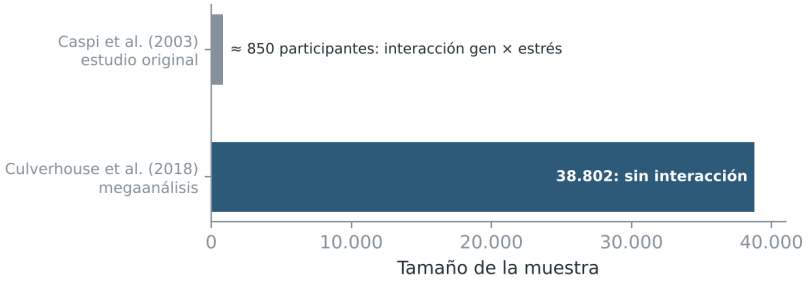


Figura 10.3. **Tamaño muestral y genes candidatos.** Barras horizontales con el número de participantes del estudio de Caspi et al. (2003), de aproximadamente 850, frente al de Culverhouse et al. (2018), de 38.802: con muestras grandes, la interacción no se replica. Datos reales (tamaños de muestra). Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.3, el estudio de Culverhouse et al. (2018), con 38.802 participantes, no replicó la interacción. Border et al. (2019) comprobaron además que 18 genes candidatos clásicos de la depresión no se asociaban con ella más que genes elegidos al azar. La lección es metodológica: los estudios pequeños de genes candidatos producen muchos **falsos positivos**.

Monoaminas. La hipótesis monoaminérgica clásica atribuyó la depresión a un déficit de catecolaminas (Schildkraut, 1965) o de serotonina, apoyándose en que los antidepresivos actúan sobre esos sistemas. La revisión paraguas de Moncrieff et al. (2022), con 17 estudios, no encontró una asociación consistente entre depresión y serotonina: ni en su metabolito 5-HIAA ni en la serotonina plasmática. La revisión no demuestra que los ISRS sean ineficaces, y ha recibido críticas metodológicas (Kasper, 2023). Que un fármaco alivie un síntoma no prueba que la causa sea la falta de lo que el fármaco aporta: el ibuprofeno quita el dolor de cabeza y nadie diría que este se debe a un déficit de ibuprofeno. Los mecanismos de los antidepresivos corresponden a la asignatura de Psicofarmacología.

Otros sistemas.

- **Eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA)**: en parte de las personas con depresión hay **hipercortisolemia** y falta de supresión del cortisol en la prueba de supresión con dexametasona.
- **Inflamación y neuroplasticidad**: se estudian marcadores inflamatorios y alteraciones de las neurotrofinas, sin que ninguno funcione hoy como prueba diagnóstica.
- **Sueño**: además del insomnio o la hipersomnia, se ha descrito una **latencia REM acortada**. La fisiología del sueño se estudia en Psicología Fisiológica y se amplía en la Unidad 13.

Ninguno de estos hallazgos basta por sí solo. El cuadro es multicausal: una vulnerabilidad genética poligénica, sistemas de estrés alterados y factores psicológicos y sociales que interactúan, en línea con el modelo de vulnerabilidad-estrés (Unidad 2).

10.4 Trastornos bipolares

Manía e hipomanía. Un **episodio maníaco** es un periodo de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, **junto con** un aumento anormal de la actividad o la energía, durante **al menos 7 días** (o

cualquier duración si requiere hospitalización), la mayor parte del día. Se exigen al menos 3 síntomas, o 4 si el ánimo es solo irritable: autoestima exagerada o grandiosidad, menor necesidad de dormir, verborrea o presión del habla, fuga de ideas, distraibilidad, aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación, e implicación en actividades de riesgo. La manía causa **deterioro marcado**, requiere hospitalización o incluye síntomas psicóticos.

El **episodio hipomaníaco** tiene los mismos síntomas durante **al menos 4 días consecutivos**, con un cambio inequívoco que los demás observan, pero **sin** deterioro marcado, hospitalización ni psicosis. Si aparecen síntomas psicóticos, el episodio es, por definición, maníaco.

Un ejemplo: Álvaro duerme tres horas y se levanta lleno de energía, habla sin parar y ha pedido un préstamo para montar tres negocios a la vez. Si dura una semana y le hace perder el trabajo, es manía. Una versión más leve, de cinco días, que sus compañeros notan pero que no le impide trabajar, sería hipomanía.

Los trastornos.

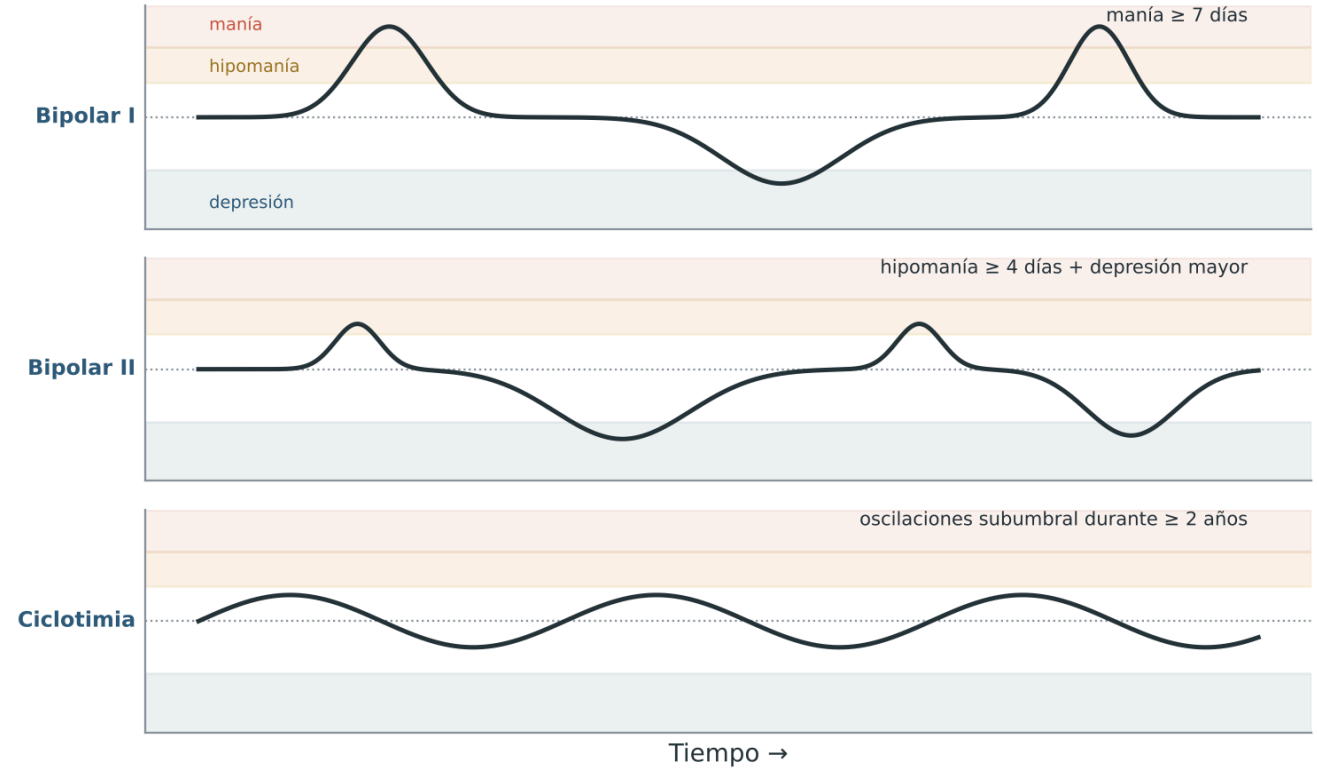


Figura 10.4. **Tres perfiles bipolares.** Ánimo frente al tiempo en el trastorno bipolar I (manía de al menos 7 días), el bipolar II (hipomanía de al menos 4 días y episodios depresivos mayores) y la ciclotimia (oscilaciones que no alcanzan el umbral durante al menos 2 años). Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.4:

- **Bipolar I**: basta con **un episodio maníaco**. Los episodios depresivos son frecuentes, pero **no** son necesarios para el diagnóstico.
- **Bipolar II**: al menos un episodio hipomaníaco y al menos un episodio depresivo mayor, **sin manía nunca**.
- **Ciclotimia**: durante al menos 2 años (1 en menores), periodos con síntomas hipomaníacos y depresivos que **no cumplen** los criterios de episodio.

Hay dos especificadores importantes. **Con ciclos rápidos** se aplica cuando hay al menos 4 episodios en 12 meses. **Con características mixtas** se usa cuando, en un episodio de un polo, aparecen síntomas del polo contrario. Además, un episodio maníaco que aparece durante un tratamiento antidepresivo, pero persiste con intensidad sindrómica más allá del efecto fisiológico del tratamiento, cuenta para el diagnóstico de bipolar I.

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Duración de la manía	≥7 días	≥1 semana
Duración de la hipomanía	≥4 días	Varios días
Síntomas mixtos	Especificador	Episodio mixto (implica bipolar I)
Bipolar II	Categoría propia	Categoría nueva en la CIE-11

Epidemiología. Las cifras son aproximadas: bipolar I alrededor del 0,6 % y bipolar II entre el 0,3 % y el 0,8 %. Suele empezar en la adultez temprana, el bipolar I tiene una frecuencia similar en ambos sexos y la heredabilidad se sitúa aproximadamente entre el 60 % y el 85 %. El riesgo de suicidio es alto.

Ser bipolar no es cambiar de humor varias veces al día: los episodios duran días o semanas, y entre ellos el ánimo puede ser normal.

Consenso y debate

Consenso: la depresión es un trastorno frecuente, recurrente y muy incapacitante, de origen multicausal. Las hipótesis de un déficit simple de serotonina o de un gen de gran efecto no se sostienen, y la arquitectura genética es poligénica (Border et al., 2019).

Debate: qué peso tienen la inflamación, el eje HHA y la neuroplasticidad, y cómo interpretar la revisión de Moncrieff et al. (2022) frente a sus críticos (Kasper, 2023). También se discute el alcance de la reinterpretación de Maier y Seligman (2016), basada sobre todo en estudios con animales.

Mito frecuente

Mito: «La depresión se debe a un desequilibrio químico: falta serotonina en el cerebro».

Realidad: la revisión paraguas de Moncrieff et al. (2022) no halló apoyo consistente a un déficit de serotonina en la depresión, aunque no cuestiona por ello la eficacia de los antidepresivos (Kasper, 2023). Tampoco se ha replicado la interacción del 5-HTTLPR con el estrés (Culverhouse et al., 2018; Border et al., 2019).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Anhedonia	Pérdida de interés o de capacidad para disfrutar de casi todas las actividades
Episodio depresivo mayor	≥5 de 9 síntomas durante ≥2 semanas, con ánimo deprimido o anhedonia (DSM-5-TR)
Trastorno depresivo persistente	Ánimo deprimido la mayoría de los días durante ≥2 años (1 en menores)
Diseño triádico	Comparación de descarga escapable, inescapable acoplada y ausencia de descarga
Tríada cognitiva	Visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro (Beck, 1967)
Rumiación	Centrarse de forma repetitiva en los síntomas y sus causas (Nolen-Hoeksema, 1991)

Concepto	Definición
Hipomanía	Episodio de ≥4 días con síntomas maníacos, sin deterioro marcado ni psicosis
Ciclotimia	Oscilaciones hipomaníacas y depresivas subumbral durante ≥2 años

Clave PIR

Prioridad alta. Se preguntan los criterios y las duraciones (2 semanas, 2 años, 4 y 7 días), las diferencias entre bipolar I, bipolar II y ciclotimia, y los modelos de Beck, la indefensión y la desesperanza. Trampas típicas: creer que el bipolar I exige un episodio depresivo, olvidar que la hipomanía con psicosis pasa a ser manía y atribuir a la indefensión original la idea de que lo aprendido es el control.

Autoevaluación

1. Para diagnosticar un trastorno bipolar I según el DSM-5-TR es necesario…
a) al menos un episodio depresivo mayor y otro hipomaníaco
b) al menos un episodio maníaco, haya o no depresión
c) oscilaciones del ánimo durante un mínimo de dos años

2. Según la revisión de Maier y Seligman (2016), en la indefensión lo que se aprende es…
a) que las propias respuestas no sirven para nada
b) la pasividad ante cualquier estímulo aversivo
c) la detección del control, que inhibe la pasividad

3. ¿Qué síntoma añade la CIE-11 a la lista del episodio depresivo del DSM-5-TR?
a) La desesperanza
b) La anhedonia
c) La fatiga

4. Un estudiante atribuye su suspenso a «soy torpe para todo y siempre lo seré». Según la reformulación atribucional, es una atribución…
a) externa, inestable y específica
b) interna, inestable y global
c) interna, estable y global

5. El estudio de Culverhouse et al. (2018) sobre el 5-HTTLPR mostró que…
a) el alelo corto duplica el riesgo de depresión tras el estrés
b) la interacción con el estrés no se replica con muestras grandes
c) el efecto solo aparece en mujeres con estrés en la infancia

Soluciones

1 b. Basta un episodio maníaco; la depresión es frecuente pero no necesaria. **2 c.** La pasividad es la respuesta por defecto; lo aprendido es el control, mediado por la corteza prefrontal ventromedial. **3 a.** La CIE-11 tiene 10 síntomas e incluye la desesperanza. **4 c.** «Soy torpe» es interna, «siempre» es estable y «para todo» es global. **5 b.** Con 38.802 participantes no se halló la interacción descrita por Caspi et al. (2003).

Unidad 11 · Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Objetivos: describir los síntomas, las dimensiones y el curso de la esquizofrenia según el DSM-5-TR y la CIE-11; explicar las hipótesis genéticas, dopaminérgica, glutamatérgica y del neurodesarrollo; valorar el papel de los factores psicosociales y descartar las teorías históricas sin apoyo; diferenciar los demás trastornos psicóticos por sus síntomas y duraciones.

11.1 La esquizofrenia: síntomas, dimensiones y curso

La **psicosis** es una pérdida del contacto con la realidad, con delirios, alucinaciones o desorganización. La esquizofrenia es el trastorno psicótico más estudiado, pero también hay psicosis en la depresión, la manía o el consumo de sustancias.

Una historia de nombres. Kraepelin (1899) llamó *dementia praecox* a un cuadro de inicio temprano y curso deteriorante. Bleuler (1911) lo rebautizó como **esquizofrenia**, «mente escindida», para referirse a la escisión entre las funciones psíquicas (pensamiento, afecto y voluntad), no a una división de la personalidad.

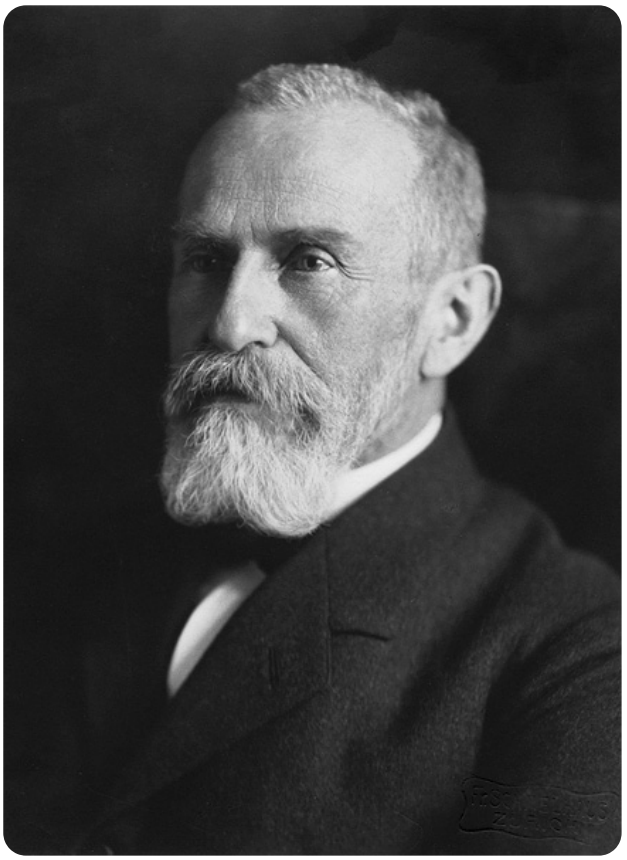


Figura 11.1. **Eugen Bleuler (1857-1939)**, que acuñó el término «esquizofrenia» en 1911. Fuente: Clínica Burghölzli, Wikimedia Commons, dominio público.

Bleuler, retratado en la figura 11.1, consideró **fundamentales** las «cuatro A»: alteración de las **asociaciones**, **afecto** aplanado o inapropiado, **ambivalencia** y **autismo** (retraimiento en el mundo interno). Los delirios y las alucinaciones eran, para él, síntomas **accesorios**. Schneider propuso después sus síntomas de primer rango (Unidad 5), que hoy tienen menos peso diagnóstico.

Criterios actuales. El DSM-5-TR exige **2 o más** de estos síntomas durante una parte significativa de **1 mes**, y al menos uno de los tres primeros: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico y síntomas negativos (expresión emotiva disminuida o abulia). Debe haber deterioro del funcionamiento y signos continuos durante **al menos 6 meses**, contando las fases prodrómica y residual. El

DSM-5 eliminó los subtipos clásicos (paranoide, desorganizado, catatónico, indiferenciado y residual) y el privilegio de los síntomas schneiderianos.

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Duración mínima	≥6 meses en total, ≥1 mes de fase activa	≥1 mes
Subtipos	Eliminados	Eliminados
Dimensiones	Escala de gravedad de los síntomas	Descriptores: positivos, negativos, depresivos, maníacos, psicomotores y cognitivos
Curso	Especificadores de episodio y remisión	Especificadores de curso

Dimensiones de síntomas. Varias propuestas han ordenado la heterogeneidad del trastorno:

- **Crow (1980)**: el **tipo I**, con síntomas positivos, buena respuesta a los antipsicóticos y relación con la dopamina, frente al **tipo II**, con síntomas negativos, peor respuesta, dilatación ventricular y deterioro.
- **Andreasen**: la distinción entre síntomas **positivos** y **negativos**, evaluada con las escalas SAPS y SANS (asignatura de Evaluación Psicológica).
- **Liddle**: tres síndromes: **distorsión de la realidad** (delirios y alucinaciones), **desorganización** y **pobreza psicomotriz**.

Los síntomas negativos incluyen alogia, abulia, anhedonia, asocialidad y aplanamiento afectivo (Unidad 6). La **cognición** también se altera: atención, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento y cognición social. Estos déficits pesan mucho en el funcionamiento diario.

Curso y epidemiología. Se distinguen las fases premórbida, prodrómica, activa y residual. El curso es heterogéneo: unas personas se recuperan, otras recaen y otras sufren un deterioro persistente. Las cifras son aproximadas: la prevalencia vital está entre el 0,3 % y el 0,7 %, y el inicio es unos 3 a 5 años más temprano en los varones; en las mujeres hay además un segundo pico. La esperanza de vida está notablemente reducida, el consumo de tabaco y otras sustancias es muy frecuente y el riesgo de suicidio es elevado.

¿Violencia? El estigma asocia la esquizofrenia con la peligrosidad.

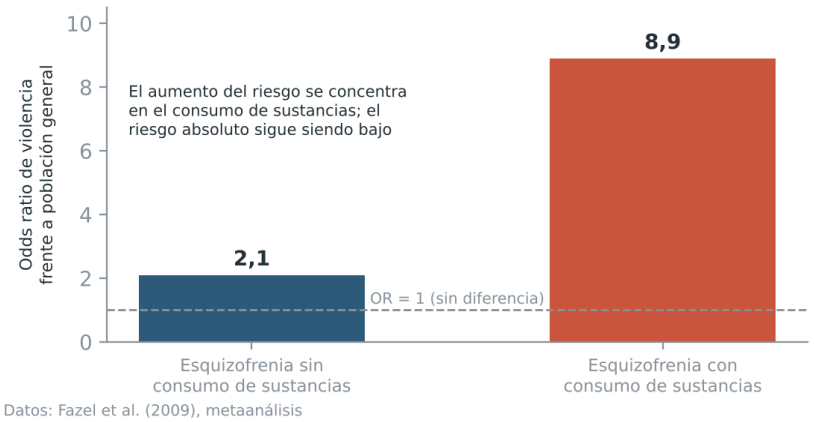


Figura 11.2. **Esquizofrenia, sustancias y violencia.** Odds ratio de violencia de aproximadamente 2,1 en personas con esquizofrenia sin consumo de sustancias y de 8,9 con consumo; el riesgo absoluto es bajo. Datos reales (Fazel et al., 2009). Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.2, el aumento del riesgo depende sobre todo del **consumo de sustancias**: con consumo, el riesgo es similar al de las personas que consumen sin tener psicosis (Fazel et al., 2009). La gran mayoría de las personas con esquizofrenia nunca es violenta.

11.2 Etiología biológica

Genética. La esquizofrenia es uno de los trastornos más heredables: los estudios de gemelos estiman una heredabilidad de aproximadamente el 81 % (Sullivan, Kendler y Neale, 2003); según el método, la mayoría de las estimaciones van del 60 % al 80 % o algo más. El riesgo aumenta con el parentesco y es máximo en el gemelo monocigótico de una persona afectada, aunque no llega al 100 %, lo que deja espacio a factores no genéticos.

Los estudios de adopción permiten separar genes y crianza. **Heston (1966)** comparó a hijos de madres con esquizofrenia separados de ellas al nacer y adoptados con un grupo de adoptados control: hubo varios casos de esquizofrenia en el primer grupo y ninguno en el segundo.

Los estudios de asociación del genoma completo confirman la **poligenia**. El Psychiatric Genomics Consortium identificó **287 loci**, con hasta 76.755 casos y 243.649 controles; los genes implicados se expresan en neuronas excitatorias e inhibitorias y participan en la biología sináptica (Trubetskoy et al., 2022). Existen además variantes raras de mayor efecto, como la deleción 22q11.2.

La hipótesis dopaminérgica. En su versión clásica, la esquizofrenia se debía a un exceso de dopamina. Dos datos la apoyaban: la potencia de los antipsicóticos se relaciona con su afinidad por los receptores D2 y la anfetamina, que aumenta la dopamina, puede inducir psicosis. La versión revisada distingue una **hiperactividad mesolímbica y estriatal**, ligada a los síntomas positivos, y una **hipoactividad mesocortical**, ligada a los negativos y cognitivos. Howes y Kapur (2009) situaron el problema en una hiperactividad **presináptica** estriatal, que sería la vía final común de la psicosis.

La teoría de la **saliencia aberrante** (Kapur, 2003) conecta la dopamina con la experiencia psicótica. La dopamina marca qué estímulos son importantes. Si se dispara sin motivo, detalles irrelevantes (una matrícula, una mirada en el metro) se viven como cargados de significado, y el delirio aparece como un intento de explicarlos.

La hipótesis glutamatérgica. Propone una **hipofunción de los receptores NMDA**. La fenciclidina y la ketamina, que los bloquean, producen síntomas positivos, negativos y cognitivos parecidos a los de la esquizofrenia (Javitt y Zukin, 1991). Los mecanismos de neurotransmisión se estudian en Psicología Fisiológica y los de los antipsicóticos, en Psicofarmacología.

Neurodesarrollo. Hay pruebas de que la vulnerabilidad empieza antes de los síntomas: complicaciones obstétricas, infecciones prenatales y un efecto pequeño de nacer en invierno o primavera. En el cerebro se observan, como diferencias de grupo, ventrículos laterales aumentados, menor volumen de sustancia gris y reducción del hipocampo. Una poda sináptica excesiva en la adolescencia ayudaría a explicar la edad de inicio.

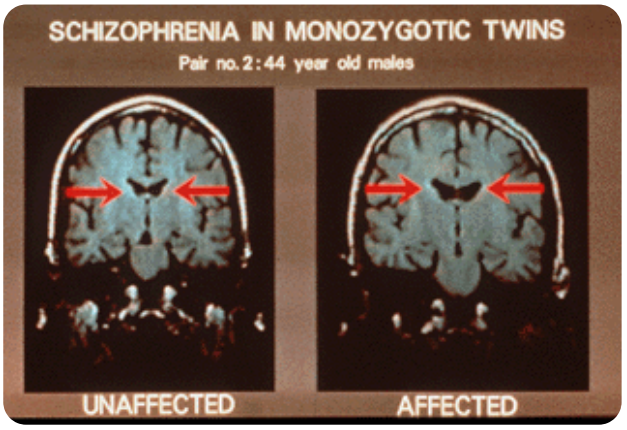


Figura 11.3. **Ventrículos laterales en gemelos monocigóticos discordantes.** Resonancia magnética coronal de dos gemelos de 44 años: el afectado de esquizofrenia («affected», derecha) tiene los ventrículos laterales más amplios (flechas) que su hermano («unaffected»). Es una diferencia de grupo, no una prueba diagnóstica. Fuente: Daniel Weinberger, NIMH, Wikimedia Commons, dominio público.

La figura 11.3 ilustra esa dilatación ventricular en dos gemelos con los mismos genes, lo que sugiere también la intervención de factores no genéticos.

Factores ambientales. El consumo de **cannabis**, sobre todo de alta potencia y a diario, se asocia a un mayor riesgo de psicosis (Unidad 15). También influyen la urbanicidad, la migración y el trauma infantil.

11.3 Factores psicosociales

Que la esquizofrenia sea muy heredable no significa que el ambiente no importe: el entorno influye en si la vulnerabilidad se expresa y en cómo evoluciona el trastorno.

El estudio finlandés de adopción. Tienari et al. (2004) siguieron a hijos de madres con esquizofrenia adoptados por otras familias y a adoptados sin ese riesgo. El riesgo genético se expresaba más cuando la familia adoptiva funcionaba mal. Es un ejemplo de **interacción gen-ambiente**: ni los genes ni la familia bastan por separado para explicar el resultado.

La emoción expresada. Es un índice del clima emocional de la familia hacia la persona afectada, con tres componentes principales:

- **Comentarios críticos**: «Te pasas el día tirado, no haces nada».
- **Hostilidad**: rechazo dirigido a la persona, no solo a una conducta concreta.
- **Sobreimplicación emocional**: protección excesiva, autosacrificio o dramatización («Desde que estás así no vivo»).

Se evalúa con la entrevista Camberwell Family Interview. Brown, Birley y Wing (1972) y Vaughn y Leff (1976) observaron que las personas que volvían a un hogar con **emoción expresada alta** recaían más, y el metaanálisis de Butzlaff y Hooley (1998) confirmó la asociación. Conviene interpretarlo bien: la emoción expresada **no causa** la esquizofrenia. Influye en el **curso** y en las recaídas, y es una reacción comprensible de familias que conviven con un problema grave y a menudo sin apoyo. Por eso se trabaja con intervenciones familiares psicoeducativas, que se estudian en la asignatura de Tratamientos.

Un ejemplo: Sergio, de 23 años, vuelve a casa tras su primer ingreso. Su madre, angustiada, revisa a cada rato si toma la medicación y lo critica por no buscar trabajo. Sin pretenderlo, ese clima añade estrés en un momento de mucha vulnerabilidad.

El modelo de vulnerabilidad-estrés. Zubin y Spring (1977) propusieron que cada persona tiene un grado de vulnerabilidad relativamente estable, y que los episodios aparecen cuando el estrés supera su umbral (Unidad 2). El modelo integra los datos genéticos, del neurodesarrollo y psicosociales, y explica por qué una misma situación desencadena un episodio en una persona y no en otra.

Teorías históricas descartadas. A mediados del siglo XX se buscó la causa de la esquizofrenia en la familia:

Teoría	Propuesta	Estado actual
Madre esquizofrenógena (Fromm-Reichmann)	Una madre fría y controladora causaría el trastorno	Sin apoyo empírico
Doble vínculo (Bateson)	Mensajes contradictorios de los padres producirían la psicosis	Sin apoyo empírico
Emoción expresada	El clima familiar influye en las recaídas	Apoyada, pero como factor de curso, no de causa

Las dos primeras se recuerdan hoy como ejemplos históricos, no como explicaciones válidas, y cargaron a las familias con una culpa injustificada. La emoción expresada, en cambio, no atribuye a la familia la causa del trastorno, sino una influencia sobre su evolución.

11.4 Otros trastornos psicóticos y catatonía

El DSM-5-TR agrupa estos cuadros en el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos: trastorno esquizotípico de la personalidad (que figura también entre los trastornos de la personalidad; Unidad 12), delirante, psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia, esquizoafectivo, inducido por sustancias o medicamentos, debido a otra afección médica y catatonía. La **duración** es el primer criterio para distinguirlos.

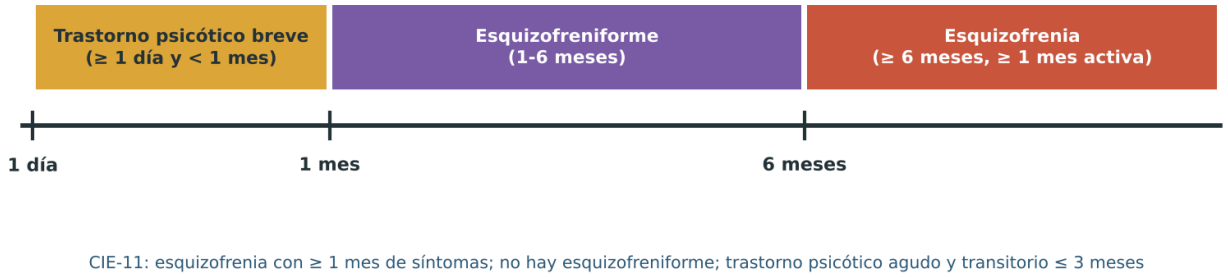


Figura 11.4. **Duraciones en los trastornos psicóticos.** Barra temporal con umbrales de 1 día, 1 mes y 6 meses: trastorno psicótico breve (de 1 día a menos de 1 mes), esquizofreniforme (de 1 a 6 meses) y esquizofrenia (6 meses o más). Una nota recoge que en la CIE-11 la esquizofrenia exige al menos 1 mes y el trastorno psicótico agudo y transitorio no supera los 3 meses. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.4:

- **Trastorno psicótico breve**: al menos un síntoma psicótico (delirios, alucinaciones, discurso desorganizado o comportamiento muy desorganizado o catatónico) durante **al menos 1 día y menos de 1 mes**, con vuelta completa al nivel previo. Se especifica si hay un estresor marcado, si no lo hay o si empieza en el posparto. En la CIE-11 se llama **trastorno psicótico agudo y transitorio**: inicio brusco, síntomas cambiantes y una duración de hasta 3 meses.
- **Trastorno esquizofreniforme**: cumple el criterio A de la esquizofrenia, pero dura **entre 1 y 6 meses** y no exige deterioro funcional. Se especifica si tiene características de buen pronóstico. No existe en la CIE-11.
- **Trastorno delirante**: uno o más delirios durante **al menos 1 mes**, sin cumplir el criterio A de la esquizofrenia. Si hay alucinaciones, no son prominentes y se relacionan con el tema del delirio. Fuera del delirio, el funcionamiento está poco afectado. Los tipos son erotomaníaco, de grandeza, celotípico, persecutorio, somático y mixto, y se especifica si el contenido es extravagante. Por ejemplo, Carmen lleva meses convencida de que su vecino la espía con micrófonos, aunque trabaja y cuida de su casa con normalidad. La CIE-11 exige al menos 3 meses.
- **Trastorno esquizoafectivo**: un episodio mayor del estado de ánimo (maníaco o depresivo) coincide con el criterio A de la esquizofrenia, y además hay delirios o alucinaciones durante **al menos 2 semanas sin** episodio afectivo. Los síntomas afectivos deben estar presentes la mayor parte de la duración total. Tiene tipos bipolar y depresivo. La CIE-11 lo refiere al episodio actual.
- **Inducido por sustancias o medicamentos** y **debido a otra afección médica**: la psicosis es efecto fisiológico directo de la sustancia o la enfermedad.
- El antiguo **trastorno psicótico compartido** (*folie à deux*) pasa en el DSM-5 a la categoría «otro especificado».

Trastorno	DSM-5-TR	CIE-11
Esquizofrenia	≥6 meses (≥1 mes activa)	≥1 mes
Esquizofreniforme	1-6 meses	No existe

Trastorno	DSM-5-TR	CIE-11
Psicótico breve / agudo y transitorio	1 día-1 mes	≤3 meses
Delirante	≥1 mes	≥3 meses
Catatonía	Especificador o diagnóstico asociado	Agrupación propia

Catatonía. Es un síndrome psicomotor (Unidad 5) que se diagnostica con **al menos 3 de 12 síntomas**: estupor, catalepsia, flexibilidad cérea, mutismo, negativismo, adopción de posturas, manierismo, estereotipia, agitación, muecas, ecolalia y ecopraxia. En el DSM-5-TR no es exclusiva de la esquizofrenia: puede asociarse a otros trastornos mentales o a una afección médica. La CIE-11 le dedica una agrupación propia.

Consenso y debate

Consenso: la esquizofrenia es muy heredable (Sullivan, Kendler y Neale, 2003) y poligénica (Trubetskoy et al., 2022), con contribución de factores del neurodesarrollo y ambientales como el cannabis de alta potencia. La hiperactividad dopaminérgica presináptica estriatal se relaciona con los síntomas positivos (Howes y Kapur, 2009). La emoción expresada alta predice recaídas, pero no causa el trastorno (Butzlaff y Hooley, 1998).

Debate: cómo encajan la hipótesis dopaminérgica y la glutamatérgica, y qué explica los síntomas negativos y cognitivos. También se discute si la esquizofrenia es una entidad o el extremo de un continuo, como sugieren los descriptores dimensionales de la CIE-11.

Mito frecuente

Mito: «Tener esquizofrenia es tener varias personalidades».

Realidad: cuando Bleuler (1911) acuñó el término, la «escisión» se refería a la desconexión entre pensamiento, afecto y voluntad, no a la existencia de varias identidades. La esquizofrenia es un trastorno psicótico; la presencia de dos o más estados de identidad corresponde al trastorno de identidad disociativo (Unidad 14).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Psicosis	Pérdida del contacto con la realidad, con delirios, alucinaciones o desorganización
Las cuatro A de Bleuler	Asociaciones, afecto, ambivalencia y autismo, síntomas fundamentales (Bleuler, 1911)
Síntomas negativos	Pérdida de funciones normales: alogia, abulia, anhedonia, asocialidad, aplanamiento
Tipo I y tipo II de Crow	Esquizofrenia de síntomas positivos frente a la de negativos y deterioro (Crow, 1980)
Saliencia aberrante	Atribución de importancia a estímulos irrelevantes por exceso de dopamina (Kapur, 2003)
Emoción expresada	Críticas, hostilidad y sobreimplicación familiar que predicen recaídas
Esquizoafectivo	Episodio afectivo con criterio A, más ≥2 semanas de psicosis sin síntomas afectivos

Concepto	Definición
Catatonía	Síndrome psicomotor con ≥3 de 12 síntomas, asociado a varios trastornos o afecciones

Clave PIR

Prioridad alta. Se preguntan sobre todo las duraciones (1 día-1 mes, 1-6 meses, 6 meses), los 2 síntomas del criterio A con al menos uno de los tres primeros, las 2 semanas del esquizoafectivo y el mes del delirante frente a los 3 meses de la CIE-11. También aparecen Crow, Liddle, las cuatro A de Bleuler y Schneider. Trampas típicas: atribuir a Bleuler la división de Kraepelin, creer que el DSM-5-TR conserva los subtipos y pensar que la emoción expresada causa la esquizofrenia.

Autoevaluación

1. Una persona tiene delirios y alucinaciones desde hace tres meses, sin deterioro claro. Según el DSM-5-TR, el diagnóstico más probable es…
a) trastorno psicótico breve
b) esquizofrenia
c) trastorno esquizofreniforme

2. ¿Qué afirma la teoría de la saliencia aberrante (Kapur, 2003)?
a) La dopamina carga de importancia estímulos irrelevantes y el delirio intenta explicarlos
b) El déficit de glutamato en los receptores NMDA produce los síntomas negativos
c) La poda sináptica excesiva en la adolescencia causa las alucinaciones auditivas

3. En el estudio finlandés de adopción de Tienari et al. (2004), el riesgo genético…
a) se expresaba igual con cualquier tipo de familia adoptiva
b) se expresaba más en familias adoptivas disfuncionales
c) desaparecía por completo con una crianza adecuada

4. Según Crow (1980), la esquizofrenia de tipo II se caracteriza por…
a) síntomas negativos, dilatación ventricular y peor respuesta
b) síntomas positivos, buena respuesta y relación con la dopamina
c) desorganización del discurso como síntoma predominante

5. En el trastorno esquizoafectivo, los delirios o alucinaciones sin episodio afectivo deben durar al menos…
a) 1 mes
b) 6 meses
c) 2 semanas

Soluciones

1 c. Dura entre 1 y 6 meses y no exige deterioro; con menos de 1 mes sería psicótico breve y con 6 meses o más, esquizofrenia. **2 a.** La saliencia anómala de estímulos irrelevantes precede al delirio, que funciona como explicación. **3 b.** Es una interacción gen-ambiente: la vulnerabilidad se expresaba más en un entorno familiar adverso. **4 a.** El tipo I es el de síntomas positivos y buena respuesta. **5 c.** Son 2 semanas de psicosis sin síntomas afectivos importantes.

Capítulo 6 · Personalidad, sueño y sexualidad

Algunos problemas no aparecen como episodios que empiezan y terminan, sino como formas estables de ser y de relacionarse; otros afectan a funciones tan básicas como dormir o la respuesta sexual. Este capítulo estudia primero los trastornos de la personalidad, desde las diez categorías del DSM-5-TR hasta los modelos dimensionales, y después los trastornos del sueño-vigilia, las disfunciones sexuales, los trastornos parafílicos y la disforia de género.

Unidad 12 · Trastornos de la personalidad

Objetivos: definir trastorno de la personalidad y reconocer los diez tipos del DSM-5-TR con su núcleo y su umbral; comparar el modelo categorial con el modelo alternativo del DSM-5 y con el sistema dimensional de la CIE-11; explicar el trastorno límite, sus modelos y la evidencia sobre su curso y tratamiento; diferenciar el trastorno antisocial de la psicopatía.

12.1 Concepto y los diez trastornos del DSM-5-TR

Hablamos de **trastorno de la personalidad** (TP) cuando la forma estable de pensar, sentir y relacionarse se vuelve un problema en sí misma. El DSM-5-TR lo define como un **patrón perdurable** de experiencia interna y de comportamiento que se aparta notablemente de lo que espera la cultura de la persona. El patrón debe manifestarse en al menos **dos de cuatro áreas**: cognición (cómo se interpreta uno mismo, a los demás y los sucesos), afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos.

Además, el patrón tiene que ser:

- **Inflexible y generalizado**: aparece en muchas situaciones personales y sociales, no solo en una.
- **Causa de malestar o deterioro** clínicamente significativo.
- **Estable y de larga duración**, con inicio en la adolescencia o al principio de la edad adulta.

Puede diagnosticarse en menores de 18 años si los rasgos están presentes desde hace al menos un año, salvo el trastorno antisocial, que exige tener 18 años.

Una característica clínica importante es la **egosintonía**: a diferencia de las obsesiones, que se viven como intrusas y no deseadas (egodistónicas), los rasgos de un TP suelen sentirse como parte de uno mismo («yo soy así»), y el malestar se atribuye a los demás o a las circunstancias. Por eso muchas personas consultan por un problema asociado, como una depresión, y no por su personalidad.

El DSM-5-TR reúne los diez TP en tres **grupos** (*clusters*):

Trastorno	Grupo	Núcleo	Umbral
Paranoide	A (raros, excéntricos)	Desconfianza y suspicacia; se atribuye malicia a los demás	≥4 de 7
Esquizoide	A	Desapego de las relaciones y expresión emocional restringida	≥4 de 7

Trastorno	Grupo	Núcleo	Umbral
Esquizotípico	A	Malestar en relaciones íntimas, distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidad	≥5 de 9
Antisocial	B (dramáticos, emocionales, erráticos)	Desprecio y violación de los derechos de los demás	≥3 de 7
Límite	B	Inestabilidad de relaciones, autoimagen y afectos, e impulsividad marcada	≥5 de 9
Histriónico	B	Emotividad excesiva y búsqueda de atención	≥5 de 8
Narcisista	B	Grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía	≥5 de 9
Evitativo	C (ansiosos, temerosos)	Inhibición social, sentimiento de inadecuación e hipersensibilidad a la crítica	≥4 de 7
Dependiente	C	Necesidad excesiva de que se ocupen de uno, sumisión y miedo a la separación	≥5 de 8
Obsesivo-compulsivo	C	Orden, perfeccionismo y control a costa de flexibilidad y eficiencia	≥4 de 8

El esquizotípico incluye ideas de referencia, pensamiento mágico y experiencias perceptivas inusuales, pero **sin psicosis franca persistente**: es el TP más próximo a la esquizofrenia (Unidad 11). Andrés cree notar lo que piensan sus compañeros, viste de forma muy peculiar y evita las relaciones cercanas por una incomodidad que no cede con el trato, sin delirios ni alucinaciones: es un perfil esquizotípico.

Dos diagnósticos diferenciales más se preguntan a menudo:

1. **Evitativo frente a ansiedad social** (Unidad 7). El solapamiento es grande; el evitativo suele ser más generalizado y afecta a la propia imagen.
2. **Obsesivo-compulsivo de la personalidad (TPOC) frente a TOC** (Unidad 8). En el TPOC no hay obsesiones ni compulsiones, sino un estilo perfeccionista y rígido que la persona considera correcto; el TOC es egodistónico.

En cuanto al curso, muchos TP **mejoran con la edad**, sobre todo los del grupo B (apartado 12.3). Las teorías de los rasgos normales corresponden a la asignatura de Personalidad.

12.2 Modelos dimensionales: el AMPD y la CIE-11

El sistema de diez categorías tiene problemas conocidos (Unidad 4): **comorbilidad** muy alta entre TP; **heterogeneidad** (con un umbral de 5 de 9, dos personas pueden recibir el diagnóstico de límite compartiendo un único criterio); **umbrales** arbitrarios y uso frecuente del diagnóstico «no especificado». Además, los rasgos de personalidad se distribuyen de forma continua. Por eso los dos grandes sistemas han propuesto modelos dimensionales.

El modelo alternativo del DSM-5 (AMPD). Está en la Sección III, la de modelos para estudio, mientras la Sección II mantiene los diez TP. Tiene dos criterios centrales:

- **Criterio A: nivel de funcionamiento de la personalidad.** Valora el funcionamiento **propio** (identidad y autodirección) y el **interpersonal** (empatía e intimidad) con la Escala de nivel de funcionamiento de la personalidad (LPFS).
- **Criterio B: rasgos patológicos.** 25 facetas agrupadas en 5 dominios: **afectividad negativa**, **desapego**, **antagonismo**, **desinhibición** y **psicoticismo**. Se evalúan, entre otros instrumentos, con el inventario PID-5 (su psicometría se estudia en Evaluación Psicológica).

El AMPD conserva seis TP (antisocial, evitativo, límite, narcisista, obsesivo-compulsivo y esquizotípico) y añade un **TP con rasgos especificados** para el resto.

La CIE-11. Va más lejos: **abandona los tipos**. Primero se decide si hay un TP y con qué **gravedad**: **leve, moderado o grave**. Por debajo del umbral existe la **dificultad de la personalidad**, que no se considera trastorno. Después, de forma opcional, se describen los rasgos prominentes con **cinco dominios**: afectividad negativa, desapego, **disocialidad**, desinhibición y **anancastia**. Se puede añadir el especificador **patrón límite**, incluido para conservar la continuidad clínica y de investigación con el TLP. El esquizotípico sale de la personalidad y pasa al grupo de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios.

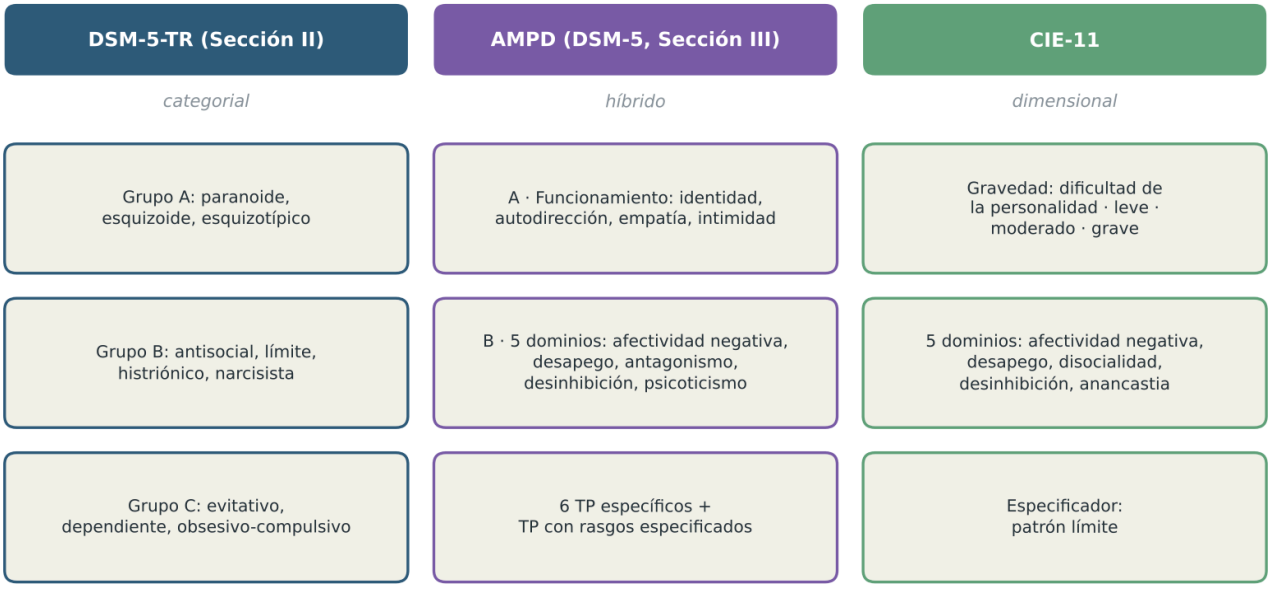


Figura 12.1. **Tres formas de clasificar los trastornos de la personalidad.** A la izquierda, los diez TP del DSM-5-TR en los grupos A, B y C; en el centro, el AMPD con el nivel de funcionamiento y cinco dominios; a la derecha, la CIE-11 con la gravedad, cinco dominios y el patrón límite. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 12.1, el AMPD y la CIE-11 comparten tres dominios y difieren en dos:

Aspecto	DSM-5-TR (Sección II)	AMPD (Sección III)	CIE-11
Enfoque	10 categorías en 3 grupos	Funcionamiento + rasgos; 6 TP	Gravedad + rasgos; sin tipos
Dominios propios	No tiene	Antagonismo, psicoticismo	Disocialidad, anancastia
Dominios comunes	—	Afectividad negativa, desapego, desinhibición	Afectividad negativa, desapego, desinhibición
TLP	Categoría	Uno de los 6 TP	Especificador patrón límite
Esquizotípico	TP del grupo A	Uno de los 6 TP	Grupo de la esquizofrenia

Los dominios se relacionan con los **Cinco Grandes** (asignatura de Personalidad): afectividad negativa con neuroticismo; desapego con baja extraversión; antagonismo con baja amabilidad; desinhibición con baja responsabilidad; y psicoticismo con apertura, aunque esta relación es débil.

Epidemiología. El metaanálisis de Winsper et al. (2020), con 46 estudios de 21 países, estimó una prevalencia de cualquier TP del 7,8 %: 3,8 % para el grupo A, 2,8 % para el B y 5,0 % para el C. Fue mayor en los países de renta alta (9,6 %) que en los de renta baja y media (4,3 %). El TLP se sitúa en torno al 1-3 % de la población (cifra aproximada) y el antisocial es más frecuente en varones.

12.3 El trastorno límite de la personalidad

El **trastorno límite de la personalidad** (TLP) es un patrón de **inestabilidad** de las relaciones, de la autoimagen y de los afectos, con **impulsividad marcada**. El DSM-5-TR exige al menos **cinco de nueve** criterios:

1. Esfuerzos desesperados por evitar un abandono real o imaginado.
2. Relaciones intensas e inestables, que oscilan entre la idealización y la devaluación.
3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido del yo inestables.
4. Impulsividad potencialmente dañina en al menos dos áreas (gasto, sexo, sustancias, conducción temeraria, atracones).
5. Conductas, amenazas o gestos suicidas recurrentes, o autolesiones.
6. Inestabilidad afectiva por una reactividad marcada del estado de ánimo.
7. Sensación crónica de vacío.
8. Ira intensa e inapropiada o dificultad para controlarla.
9. Ideación paranoide transitoria o síntomas disociativos graves relacionados con el estrés.

Un minicaso: Irene, de 24 años, pasa en pocas horas de sentir que su nueva amiga es «la persona más importante de su vida» a pensar que la desprecia porque no ha contestado un mensaje, y ese día se corta en el brazo para calmar la angustia. Sus cambios de ánimo duran horas, no días ni semanas, lo que los distingue de los episodios bipolares (Unidad 10).

El modelo biosocial de Linehan (1993). Explica el TLP como resultado de la interacción entre dos factores:

- Una **vulnerabilidad emocional** de base biológica: alta sensibilidad a los estímulos emocionales, reactividad intensa y **retorno lento a la línea base**.
- Un **ambiente invalidante**, que responde a la expresión de las emociones ignorándolas, castigándolas o trivializándolas («no es para tanto»).

De esa interacción surge una **desregulación emocional generalizada**: la persona no aprende a modular sus emociones y recurre a conductas que alivian a corto plazo, como las autolesiones. Crowell, Beauchaine y Linehan (2009) ampliaron el modelo en clave evolutiva. El modelo es la base de la **terapia dialéctica conductual** (TDC). La regulación emocional normal se estudia en Motivación y Emoción.

El modelo de mentalización. Fonagy y Bateman proponen que el núcleo del TLP es una dificultad para **mentalizar**: entender la conducta propia y ajena en términos de estados mentales (deseos, intenciones, emociones), sobre todo bajo activación emocional intensa. Si un silencio se lee siempre como rechazo, las relaciones se vuelven turbulentas. De este modelo deriva el **tratamiento basado en la mentalización** (TBM).

Curso. El estudio McLean de Zanarini et al. (2010) siguió durante años a pacientes con TLP: la **mayoría alcanzó una remisión sostenida** de los síntomas. La **recuperación funcional plena**, con buen funcionamiento social y laboral, fue menos frecuente.

Tratamiento. La revisión Cochrane de Storebø et al. (2020) concluyó que las psicoterapias específicas son útiles. Frente al tratamiento habitual, la TDC redujo la gravedad del TLP (DME −0,60; 3 ensayos, n = 149) y las autolesiones (DME −0,28; 7 ensayos, n = 376), y el TBM redujo las autolesiones y la suicidabilidad. La calidad de la evidencia se valoró como **baja**, por lo que hacen falta más estudios, pero el mensaje es claro: el TLP **sí tiene tratamiento**. Las técnicas concretas se estudian en la asignatura de Tratamientos.

Es habitual que el TLP coexista con depresión, consumo de sustancias o trastornos alimentarios. El diagnóstico arrastra todavía **estigma**, y la evidencia sobre su mejoría es el mejor argumento contra ese pesimismo.

12.4 Trastorno antisocial y psicopatía

El **trastorno antisocial de la personalidad** (TAP) es un patrón de **desprecio y violación de los derechos de los demás** que se da **desde los 15 años**. El DSM-5-TR exige al menos **tres de siete** manifestaciones:

- Incumplimiento de las normas sociales, con actos que son motivo de detención.
- Engaño: mentiras repetidas, uso de alias o estafas para obtener beneficio o placer.
- Impulsividad o incapacidad para planificar.
- Irritabilidad y agresividad, con peleas o agresiones repetidas.
- Despreocupación imprudente por la seguridad propia o ajena.
- Irresponsabilidad constante en el trabajo o en las obligaciones económicas.
- Ausencia de remordimiento.

Hay dos requisitos más que el PIR pregunta a menudo: la persona debe tener **al menos 18 años** y debe haber **evidencia de un trastorno de la conducta antes de los 15**. El TAP es, en buena medida, la continuación adulta de un trastorno de la conducta (Unidad 16). Es más frecuente en varones y tiende a atenuarse con la edad. En la CIE-11 no existe como tipo: sus rasgos se describen con el dominio de **disocialidad**.

La psicopatía. El concepto clínico procede de Cleckley (1941), que en *The Mask of Sanity* describió a personas de apariencia normal con **encanto superficial**, **ausencia de remordimiento**, **egocentrismo** y **pobreza afectiva**. Lo característico no es tanto lo que hacen como su forma fría de vivir las emociones y las relaciones.

Robert Hare operativizó el constructo con la **PCL-R** (*Psychopathy Checklist-Revised*), una escala de **20 ítems** organizada en **dos factores**:

Factor	Contenido	Ejemplos de rasgos
1. Interpersonal-afectivo	Cómo se relaciona y siente	Locuacidad y encanto superficial, mentira patológica, falta de remordimiento y de empatía
2. Estilo de vida antisocial	Cómo se comporta	Impulsividad, irresponsabilidad, conducta antisocial temprana, falta de metas realistas

Cada factor se divide a su vez en dos facetas, de modo que se habla también de **cuatro facetas**. La administración de la escala corresponde a Evaluación Psicológica.

Una relación asimétrica. TAP y psicopatía no son lo mismo. Los criterios del TAP se centran sobre todo en **conductas** antisociales, que coinciden con el factor 2. La psicopatía exige además los rasgos **interpersonales y afectivos** del factor 1. El resultado es una relación asimétrica: la **mayoría de las personas con psicopatía cumpliría criterios de TAP**, pero solo una **minoría** de quienes tienen un TAP son psicópatas. Raúl acumula robos y peleas desde la adolescencia, actúa por impulso y después se arrepiente, aunque reincide: cumple criterios de TAP sin perfil psicopático. Marcos estafa con un trato encantador, planifica con calma y habla de sus víctimas sin el menor afecto: muestra los dos factores.

El AMPD incorpora el especificador **«con rasgos psicopáticos»** para el TAP, que recoge esta dimensión interpersonal y afectiva. En la infancia y la adolescencia, el equivalente es el especificador **«con emociones prosociales limitadas»** del trastorno de la conducta, que describe rasgos de insensibilidad y frialdad: falta de remordimiento y de empatía, despreocupación por el propio rendimiento y afecto superficial (Unidad 16).

Por último, «psicópata» no es un diagnóstico del DSM-5-TR, sino un constructo de investigación y de evaluación forense.

Consenso y debate

Consenso: los rasgos de personalidad, normales y patológicos, son dimensionales, y los TP pueden describirse como posiciones extremas y desadaptativas en esas dimensiones. Los TP no son inmutables: muchos mejoran con la edad y la mayoría de las personas con TLP alcanza una remisión sostenida (Zanarini et al., 2010). TAP y psicopatía son constructos relacionados, pero distintos.

Debate: si el especificador «patrón límite» de la CIE-11 es redundante respecto a los cinco dominios o necesario para no perder la tradición clínica y la investigación sobre el TLP. También está abierto cómo convivirán en la práctica el modelo categorial de la Sección II y los modelos dimensionales.

Mito frecuente

Mito: «El trastorno límite no tiene tratamiento: la personalidad no cambia».

Realidad: la mayoría de las personas con TLP alcanza una remisión sostenida a largo plazo, aunque la recuperación funcional plena es menos frecuente (Zanarini et al., 2010). Frente al tratamiento habitual, la terapia dialéctica conductual y el tratamiento basado en la mentalización reducen la gravedad, las autolesiones o la suicidabilidad, con una calidad de evidencia todavía baja (Storebø et al., 2020).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Trastorno de la personalidad	Patrón perdurable, inflexible y generalizado que se aparta de lo esperado y causa malestar o deterioro
Egosintonía	Vivencia de los rasgos como propios y aceptables, no como ajenos o molestos
Grupo B	TP dramáticos, emocionales o erráticos: antisocial, límite, histriónico y narcisista
AMPD	Modelo alternativo del DSM-5: nivel de funcionamiento más rasgos patológicos en 5 dominios
Dificultad de la personalidad	Categoría de la CIE-11 por debajo del umbral de trastorno; no es un TP
Anancastia	Dominio de la CIE-11 de perfeccionismo, rigidez y control de la conducta y las emociones
Ambiente invalidante	Entorno que ignora, castiga o trivializa las emociones (modelo biosocial de Linehan, 1993)
PCL-R	Escala de Hare para evaluar la psicopatía: 20 ítems, 2 factores y 4 facetas

Clave PIR

Prioridad media. Se preguntan los grupos y los umbrales de los diez TP, la egosintonía, los dominios del AMPD frente a los de la CIE-11 y los requisitos de edad del TAP. Trampas típicas: olvidar que el TAP exige 18 años y trastorno de la conducta antes de los 15; atribuir la anancastia y la disocialidad al AMPD (son de la CIE-11) o el antagonismo y el psicoticismo a la CIE-11; y creer que el esquizotípico sigue siendo un TP en la CIE-11.

Autoevaluación

1. ¿Qué dominios son exclusivos de la CIE-11 y no aparecen en el AMPD?
a) Antagonismo y psicoticismo
b) Afectividad negativa y desapego
c) Disocialidad y anancastia

2. Para diagnosticar un trastorno antisocial de la personalidad según el DSM-5-TR se exige, entre otros requisitos…
a) evidencia de un trastorno de la conducta antes de los 15 años
b) una puntuación elevada en el factor 1 de la PCL-R
c) haber cometido al menos un delito violento

3. Según el modelo biosocial de Linehan (1993), el TLP surge de la interacción entre una vulnerabilidad emocional y…
a) un déficit primario de serotonina
b) un ambiente invalidante
c) un apego seguro sobreprotector

4. En el estudio de seguimiento de Zanarini et al. (2010), la mayoría de los pacientes con TLP…
a) alcanzó una remisión sostenida de los síntomas
b) mantuvo todos los criterios a lo largo del tiempo
c) logró una recuperación funcional plena

5. ¿Qué afirmación describe mejor la relación entre TAP y psicopatía?
a) Son el mismo constructo con dos nombres distintos
b) La mayoría de las personas con TAP son psicópatas
c) La mayoría de los psicópatas cumpliría criterios de TAP

Soluciones

1 c. El AMPD tiene antagonismo y psicoticismo; la CIE-11, disocialidad y anancastia; los otros tres dominios son comunes. **2 a.** También exige tener al menos 18 años; la PCL-R no forma parte de los criterios. **3 b.** La vulnerabilidad emocional unida a un ambiente invalidante produce desregulación emocional generalizada. **4 a.** La recuperación funcional plena fue menos frecuente que la remisión sintomática. **5 c.** La relación es asimétrica: solo una minoría de quienes tienen un TAP son psicópatas.

Unidad 13 · Trastornos del sueño-vigilia y de la sexualidad

Objetivos: describir la arquitectura normal del sueño y los criterios del insomnio, la hipersomnia y la narcolepsia; diferenciar los trastornos respiratorios, circadianos y las parasomnias NREM y REM; comparar los modelos de la respuesta sexual y describir las disfunciones sexuales; distinguir parafilia de trastorno parafílico y disforia de género de incongruencia de género.

13.1 El sueño normal, el insomnio y las hipersomnias

El sueño normal. La fisiología del sueño se estudia en Psicología Fisiológica; aquí basta con lo necesario para entender sus trastornos. Durante la noche se suceden **ciclos de unos 90 minutos** que alternan dos tipos de sueño:

- **Sueño NREM**, con tres fases: **N1**, de transición; **N2**, con **husos de sueño** y **complejos K** en el EEG; y **N3**, de **ondas lentas**, el sueño más profundo, que predomina en la **primera mitad** de la noche.
- **Sueño REM**, con **atonía muscular** y sueños vívidos, que predomina en la **segunda mitad**.

El registro de referencia es la **polisomnografía** (EEG, electrooculograma y electromiograma, más otros canales), y su resumen gráfico es el **hipnograma**.

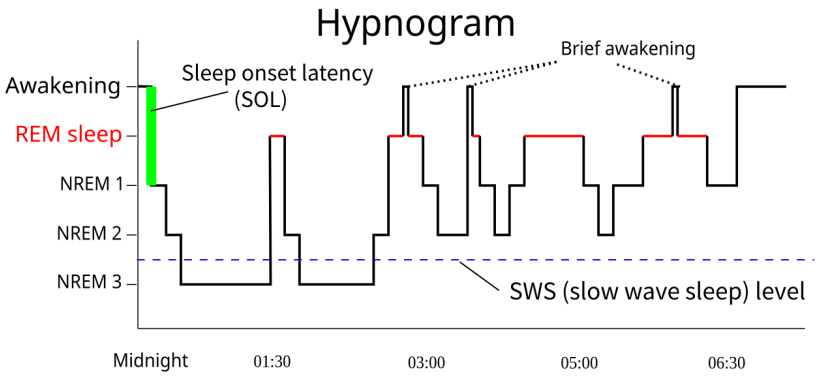


Figura 13.1. **Hipnograma de una noche.** En vertical, vigilia («awakening»), sueño REM (en rojo) y fases NREM 1-3; la línea azul marca el nivel de sueño de ondas lentas y la barra verde, la latencia de sueño. El N3 se concentra en la primera mitad de la noche y los periodos REM se alargan hacia el final. Fuente: RazerM, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (fondo blanco añadido por SAIMAP).

Como muestra la figura 13.1, la noche no es homogénea, lo que explica cuándo aparece cada parasomnia (apartado 13.2).

Insomnio. El trastorno de insomnio del DSM-5-TR consiste en **insatisfacción con la cantidad o la calidad del sueño** por dificultad para conciliarlo, para mantenerlo o por despertar precoz sin poder volver a dormir. Debe darse al menos **3 noches por semana** durante al menos **3 meses**, pese a tener una **oportunidad adecuada** para dormir, y producir malestar o deterioro diurno (cansancio, irritabilidad, problemas de concentración). Puede ser **episódico**, **persistente** o **recurrente**. Aproximadamente un tercio de los adultos tiene síntomas de insomnio, pero solo en torno al 6-10 % cumple criterios del trastorno; es más frecuente en mujeres y aumenta con la edad (cifras aproximadas).

El **modelo 3P** (Spielman et al., 1987) distingue tres factores:

Factor	Función	Ejemplos
Predisponentes	Aumentan la vulnerabilidad	Tendencia a la hiperactivación, rasgos ansiosos

Factor	Función	Ejemplos
Precipitantes	Desencadenan el problema	Estrés laboral, una enfermedad, un duelo
Perpetuantes	Lo mantienen cuando el desencadenante ya pasó	Pasar más tiempo en la cama, siestas, preocupación por dormir, asociación cama-vigilia

Con el tiempo, el insomnio se sostiene sobre todo por los **perpetuantes**. Elena duerme mal tras un despido; empieza a acostarse antes «para recuperar» y da vueltas mirando el reloj. Meses después ya tiene trabajo, pero la cama se ha convertido en una señal de vigilia. Por eso la terapia cognitivo-conductual para el insomnio usa el control de estímulos y la restricción de sueño (asignatura de Tratamientos). Otros modelos subrayan la **hiperactivación**, y el modelo cognitivo de Harvey (2002), la preocupación por el sueño.

Hipersomnia. Es una **somnolencia excesiva pese a dormir al menos 7 horas**, al menos 3 veces por semana durante 3 meses.

Narcolepsia. Consiste en periodos recurrentes de **necesidad irrefrenable de dormir**, al menos 3 veces por semana durante 3 meses, más **cataplejía**, **déficit de hipocretina (orexina)** en el líquido cefalorraquídeo, o una latencia REM de 15 minutos o menos (o una latencia media de 8 minutos o menos con dos o más inicios en REM en la prueba de latencias múltiples). El DSM-5-TR distingue la **narcolepsia tipo 1** (con cataplejía o déficit de hipocretina) y la **tipo 2** (sin ellos). La **tétrada clásica** incluye somnolencia, cataplejía (pérdida brusca del tono muscular desencadenada por emociones como la risa, con la conciencia conservada), **parálisis del sueño** y **alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas**. Es rara: en torno al 0,02-0,05 % (cifra aproximada).

13.2 Trastornos respiratorios, circadianos y parasomnias

Trastornos relacionados con la respiración. El más frecuente en la clínica es la **apnea e hipopnea obstructiva del sueño**: la vía aérea superior se cierra total o parcialmente durante el sueño aunque el esfuerzo por respirar continúa. Se manifiesta con **ronquidos**, **pausas respiratorias** que observa la pareja y **somnolencia diurna**. El diagnóstico exige polisomnografía con un **índice de apnea-hipopnea** de 5 o más por hora con síntomas, o de 15 o más aunque no haya síntomas. En la **apnea central** el problema no está en la vía aérea, sino en el control respiratorio: el esfuerzo por respirar desaparece. Existe además la **hipoventilación relacionada con el sueño**, con respiración insuficiente y aumento del CO2.

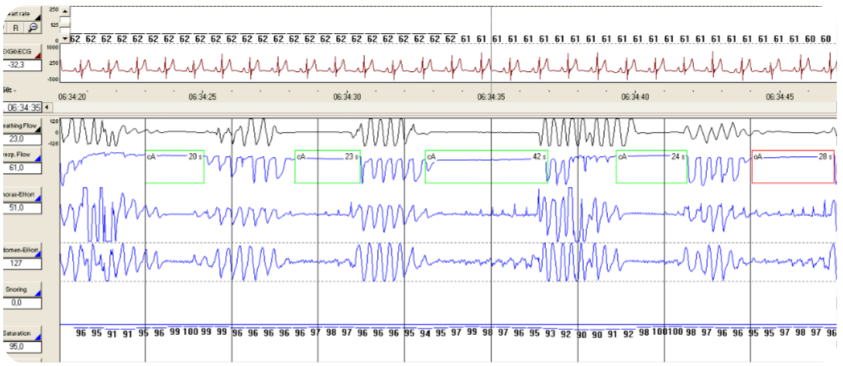


Figura 13.2. **Apneas en una polisomnografía.** Canales de frecuencia cardiaca y ECG, flujo respiratorio, esfuerzo torácico y abdominal, ronquido y saturación de oxígeno. En los recuadros verdes («cA», apneas centrales) desaparecen a la vez el flujo y el esfuerzo respiratorio; en el rojo («oA», apnea obstructiva) cesa el flujo aunque el esfuerzo continúa. Fuente: Eumetaxas, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (fondo blanco añadido por SAIMAP).

La figura 13.2 resume la diferencia que más se pregunta: en la apnea **obstructiva** el tórax y el abdomen siguen intentando respirar; en la **central**, no.

Trastornos del ritmo circadiano. Se deben a un desajuste entre el reloj biológico y el horario que exige el entorno, y producen insomnio, somnolencia o ambos. Los tipos son: **fase de sueño retrasada** (dormirse y despertarse muy tarde; típico de adolescentes), **fase avanzada** (muy temprano; más propio de mayores), **sueño-**

vigilia irregular, **no ajustado a 24 horas** y **asociado a turnos laborales**. El *jet lag* no figura como trastorno específico en el DSM-5.

Parasomnias. Son conductas o experiencias anómalas durante el sueño o sus transiciones, y se dividen según la fase:

Rasgo	Trastornos del despertar NREM	Pesadillas	Trastorno de conducta del sueño REM
Ejemplos	Sonambulismo, terrores nocturnos	Sueños angustiosos que despiertan	«Actuar» los sueños
Fase	N3	REM	REM sin atonía
Momento de la noche	Primera mitad	Segunda mitad	Más de 90 minutos tras dormirse
Al despertar	Difícil, confuso	Orientado y alerta	Alerta y orientado
Recuerdo	Amnesia total o parcial	Recuerdo vívido	Suele recordar el sueño
Perfil típico	Niños	Cualquier edad	Varones mayores

En el **sonambulismo**, la persona se levanta y camina con la mirada fija y es muy difícil despertarla. En los **terrores nocturnos** se incorpora gritando, con gran activación vegetativa (taquicardia, sudoración, midriasis), y al día siguiente no recuerda nada. Si un niño se sienta chillando a las dos horas de dormirse y por la mañana no recuerda nada, es un terror nocturno; si de madrugada se despierta llorando y cuenta que le perseguía un lobo, es una pesadilla.

El **trastorno de conducta del sueño REM** se produce por la **pérdida de la atonía** propia del REM: la persona grita o da patadas mientras sueña que se defiende. Interesa especialmente porque es un **marcador prodrómico de sinucleinopatías**, como la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy.

Síndrome de piernas inquietas. Es una necesidad de mover las piernas, con sensaciones desagradables, que **empeora en reposo y por la tarde-noche** y se **alivia con el movimiento**, al menos 3 veces por semana durante 3 meses. Afecta aproximadamente al 2-7 % de la población.

13.3 La respuesta sexual y las disfunciones sexuales

Modelos de la respuesta sexual. Tres modelos marcan cómo se describe la respuesta sexual normal.

- **Masters y Johnson (1966)** observaron en el laboratorio la respuesta fisiológica y propusieron un **modelo lineal de cuatro fases**: **excitación**, **meseta**, **orgasmo** y **resolución**, con un periodo refractario en los varones. No incluía el deseo.
- **Kaplan (1979)** añadió la fase de **deseo** y simplificó el esquema en un **modelo trifásico**: deseo, excitación y orgasmo. Su aportación permitió describir los problemas de deseo como disfunciones propias.
- **Basson (2000)** propuso un **modelo circular** de la respuesta sexual femenina. La motivación puede partir de la **intimidad** y de la **receptividad** a los estímulos, y la excitación subjetiva puede **preceder al deseo** en lugar de seguirlo. La satisfacción emocional y física retroalimenta el ciclo.

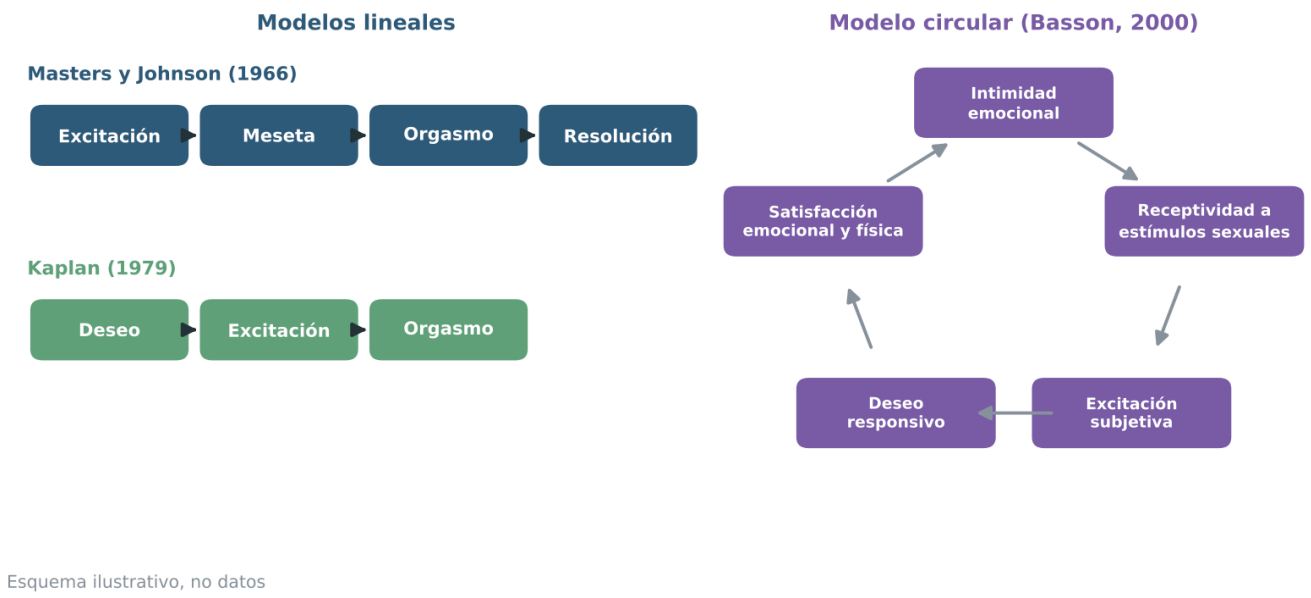


Figura 13.3. **Modelos de la respuesta sexual.** A la izquierda, el modelo lineal de Masters y Johnson (excitación, meseta, orgasmo, resolución) y el trifásico de Kaplan (deseo, excitación, orgasmo); a la derecha, el modelo circular de Basson, en el que la intimidad y la receptividad pueden llevar a la excitación y esta al deseo. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 13.3, la diferencia esencial está en la posición del deseo: ausente en Masters y Johnson, al principio en Kaplan y en cualquier punto del ciclo en Basson, lo que ayuda a no considerar patológica, sin más, la falta de deseo espontáneo al inicio.

El papel de la cognición. Barlow describió la **interferencia cognitiva**: las personas sin problemas atienden a las señales eróticas; las personas con una disfunción, a señales de **amenaza** y de rendimiento («¿y si no funciona esta vez?»). Esa atención reduce la excitación, confirma el temor y aumenta la ansiedad la vez siguiente. Enlaza con la **ansiedad de desempeño** y con el *spectatoring* descrito por Masters y Johnson: observarse desde fuera en lugar de implicarse.

Las disfunciones sexuales del DSM-5-TR. Son:

1. Eyaculación retardada.
2. Trastorno eréctil.
3. Trastorno orgásmico femenino.
4. Trastorno del interés o la excitación sexual femenino.
5. Trastorno de dolor genito-pélvico o de la penetración.
6. Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón.
7. Eyaculación prematura, que ocurre aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración y antes de que la persona lo desee.
8. Disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, y otras especificadas o no especificadas.

Comparten unos **requisitos generales**: duración de unos **6 meses** como mínimo, presencia en la mayoría de las ocasiones (en torno al 75-100 %), **malestar clínicamente significativo** y ausencia de una explicación mejor (otro trastorno mental, conflicto grave de pareja, otros estresores, sustancias o afección médica). Se especifica si es **de toda la vida o adquirida**, **generalizada o situacional** y su gravedad.

Jorge, de 35 años, tuvo un fallo de erección una noche de cansancio; desde entonces vigila su cuerpo en cada encuentro y las erecciones fallan con su pareja, pero no al despertar. Es un caso **adquirido** y **situacional** que ilustra la interferencia cognitiva.

En la **CIE-11**, las disfunciones sexuales y los trastornos de dolor sexual se trasladan a un capítulo de **afecciones relacionadas con la salud sexual**, fuera de los trastornos mentales, y **no se dividen según su causa orgánica**

o psicógena, porque a menudo intervienen factores de ambos tipos. La influencia del estrés y de la enfermedad física sobre la sexualidad se amplía en Psicología de la Salud.

13.4 Trastornos parafílicos y disforia o incongruencia de género

Parafilia frente a trastorno parafílico. El DSM-5 introdujo una distinción importante. Una **parafilia** es un interés sexual atípico, intenso y persistente. Un **trastorno parafílico** es una parafilia que **causa malestar o deterioro** a la persona, o cuya satisfacción implica **daño o riesgo de daño a otros**, o que se ha llevado a cabo con **personas que no consienten**. Debe durar al menos **6 meses**. Tener una parafilia, por sí sola, no basta para el diagnóstico.

El DSM-5-TR recoge ocho trastornos parafílicos, que aquí solo se enumeran con su definición académica:

Trastorno	Foco del interés sexual
Voyeurismo	Observar a una persona desprevenida que está desnuda o en actividad sexual
Exhibicionismo	Exponer los genitales a una persona desprevenida
Frotteurismo	Tocar o rozarse con una persona que no consiente
Masoquismo sexual	Ser humillado o sometido a sufrimiento
Sadismo sexual	El sufrimiento físico o psicológico de otra persona
Pedofilia	Niños prepúberes
Fetichismo	Objetos inanimados o partes del cuerpo no genitales
Travestismo	Vestir ropa asociada a otro sexo

En la **CIE-11**, el criterio decisivo es la **falta de consentimiento** de las otras personas implicadas o el **malestar** significativo de la propia persona. Por ello, la CIE-11 **elimina el fetichismo, el travestismo fetichista y el sadomasoquismo consentido** como trastornos (del sadismo solo conserva el trastorno de sadismo sexual coercitivo): cuando se dan entre adultos que consienten y no causan malestar, no se consideran patológicos.

Disforia de género. El DSM-5-TR la define como un **malestar clínicamente significativo** asociado a la **incongruencia entre el género experimentado o expresado y el género asignado al nacer**, durante al menos **6 meses**. Tiene criterios distintos para la infancia y para la adolescencia y la edad adulta. El DSM-5-TR actualizó la terminología y emplea las expresiones «género experimentado» y «género asignado al nacer». El punto clave es que el diagnóstico se centra en el **malestar**, no en la identidad: ser una persona trans no es en sí un trastorno.

La **CIE-11** dio un paso más. La **incongruencia de género** sale de los trastornos mentales y pasa al capítulo de **afecciones relacionadas con la salud sexual**. Se mantiene un código porque facilita el acceso a la atención sanitaria, pero se elimina la connotación de trastorno mental: es lo que se conoce como **despatologización**.

Ámbito	DSM-5-TR	CIE-11
Sueño-vigilia	Capítulo dentro del manual de trastornos mentales	Capítulo propio, fuera de los trastornos mentales
Disfunciones sexuales	Trastornos mentales; requisitos de ≈6 meses	Capítulo de salud sexual; sin división orgánica/psicógena
Trastornos parafílicos	Ocho tipos; malestar, daño o falta de consentimiento	Clave en el consentimiento o el malestar; sin fetichismo, travestismo fetichista ni sadomasoquismo consentido
Género	Disforia de género: malestar, ≥6 meses	Incongruencia de género en salud sexual, no es trastorno mental

Lo que se ha considerado trastorno en el ámbito sexual ha dependido mucho de las normas de cada época (Unidad 1); la tendencia actual es reservar el diagnóstico para el malestar, el deterioro o el daño a otras personas.

Consenso y debate

Consenso: el insomnio es un trastorno con entidad propia y no solo un síntoma de otros problemas; con el tiempo lo mantienen sobre todo los factores perpetuantes. Las parasomnias NREM y REM se distinguen por la fase, el momento de la noche y el recuerdo del episodio. En sexualidad, el diagnóstico se reserva para el malestar, el deterioro o el daño a otros: tener una parafilia no es un trastorno parafílico y la identidad de género no es patológica en sí.

Debate: dónde deben clasificarse estos problemas: la CIE-11 saca el sueño, las disfunciones sexuales y la incongruencia de género de los trastornos mentales, y el DSM-5-TR los mantiene. También se discute el alcance de los modelos de la respuesta sexual: el lineal de Masters y Johnson se basó en la fisiología de laboratorio, y el circular de Basson se propuso para describir mejor la experiencia de muchas mujeres.

Mito frecuente

Mito: «Ver figuras u oír voces justo al quedarse dormido es un signo de psicosis».

Realidad: las alucinaciones **hipnagógicas** (al dormirse) e **hipnopómpicas** (al despertar) aparecen en personas sin ningún trastorno y forman parte de la tétrada de la narcolepsia junto con la parálisis del sueño. No toda alucinación es psicótica: también pueden aparecer en el duelo, con privación sensorial o en el síndrome de Charles Bonnet (Unidad 6).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Polisomnografía	Registro simultáneo durante el sueño de EEG, EOG, EMG y otros canales fisiológicos
Modelo 3P	Insomnio por factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes (Spielman et al., 1987)
Cataplejía	Pérdida brusca del tono muscular desencadenada por emociones, con la conciencia conservada
Índice de apnea-hipopnea	Número de apneas e hipopneas por hora de sueño; ≥5 con síntomas o ≥15
Trastorno de conducta del sueño REM	Pérdida de la atonía REM con conductas que escenifican los sueños
Modelo circular de Basson	La intimidad y la excitación pueden preceder al deseo en la respuesta sexual (Basson, 2000)
Trastorno parafílico	Parafilia que causa malestar o deterioro o implica daño o falta de consentimiento
Incongruencia de género	Categoría de la CIE-11 en salud sexual, fuera de los trastornos mentales

Clave PIR

Prioridad media, y baja en parafilias. Se pregunta la duración del insomnio (3 noches por semana, 3 meses), los criterios de la narcolepsia y sus tipos, y sobre todo las diferencias entre parasomnias NREM y REM. Trampas típicas: confundir terrores nocturnos (primera mitad, amnesia) con pesadillas (segunda mitad, recuerdo vívido); atribuir la fase de deseo a Masters y Johnson en lugar de a Kaplan; y tratar como equivalentes parafilia y trastorno parafílico.

Autoevaluación

1. Un niño se incorpora gritando dos horas después de dormirse, con taquicardia y sudoración, y por la mañana no recuerda nada. Lo más probable es…
a) un trastorno de pesadillas
b) un terror nocturno
c) un trastorno de conducta del sueño REM

2. En el modelo 3P de Spielman, pasar cada vez más tiempo en la cama para «recuperar sueño» es un factor…
a) predisponente
b) precipitante
c) perpetuante

3. ¿Qué modelo de la respuesta sexual añadió la fase de deseo a la secuencia lineal?
a) El de Kaplan
b) El de Masters y Johnson
c) El de Basson

4. En una polisomnografía, el flujo respiratorio se interrumpe mientras continúa el esfuerzo torácico y abdominal. Esto indica una apnea…
a) central
b) obstructiva
c) por hipoventilación

5. Según el DSM-5-TR, ¿qué distingue un trastorno parafílico de una parafilia?
a) Que cause malestar o deterioro, o implique daño o falta de consentimiento
b) Que el interés sexual atípico sea intenso y persistente
c) Que aparezca antes de los 18 años de edad

Soluciones

1 b. Los terrores nocturnos aparecen en N3, en la primera mitad de la noche, con amnesia del episodio. **2 c.** Los perpetuantes mantienen el insomnio cuando el desencadenante ya ha desaparecido. **3 a.** Masters y Johnson no incluían el deseo y Basson propuso un modelo circular. **4 b.** En la apnea central desaparece también el esfuerzo respiratorio. **5 a.** La intensidad y la persistencia definen la parafilia, que por sí sola no es un trastorno.

Capítulo 7 · Disociación, cuerpo, adicciones e impulsos

Este capítulo reúne trastornos situados en la frontera entre la mente, el cuerpo y la conducta. Empieza por los trastornos disociativos y los de síntomas somáticos, en los que se altera la integración de la experiencia o la relación con el propio cuerpo. Sigue con las adicciones a sustancias y al juego, y termina con los trastornos de la conducta alimentaria, los disruptivos y los del control de impulsos, que comparten dificultades para regular la conducta frente a su consecuencia inmediata.

Unidad 14 · Trastornos disociativos y de síntomas somáticos

Objetivos: definir la disociación y describir los criterios del trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa y la fuga; comparar los modelos postraumático y sociocognitivo del trastorno de identidad disociativo; diferenciar la despersonalización de la psicosis y conocer las categorías disociativas de la CIE-11; distinguir el trastorno de síntomas somáticos, la ansiedad por enfermedad y el trastorno de distrés corporal; diferenciar conversión, trastorno facticio y simulación según la intención y la motivación.

14.1 Trastorno de identidad disociativo y amnesia disociativa

La **disociación** es una alteración o discontinuidad de la integración normal de funciones que solemos vivir como un todo: conciencia, memoria, identidad, emoción, percepción, representación del cuerpo, control motor y conducta. Las formas leves y pasajeras son corrientes, como llegar a casa por el trayecto de siempre sin recordar el camino. Se habla de trastorno cuando la discontinuidad es intensa o persistente, causa malestar o deterioro y no se explica por una sustancia, por otra afección médica ni por una práctica cultural o religiosa aceptada.

El DSM-5-TR incluye en este grupo el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización/desrealización y las categorías de otro trastorno disociativo especificado y no especificado.

Trastorno de identidad disociativo (TID). Su nombre antiguo era «trastorno de personalidad múltiple». Sus rasgos esenciales son:

- **Dos o más estados de personalidad diferenciados**, que en algunas culturas se viven como una experiencia de posesión. Suponen una discontinuidad marcada del sentido del yo y de la **agencia** (la sensación de ser el autor de los propios actos), con cambios en el afecto, la conducta, la conciencia, la memoria, la percepción y el funcionamiento sensoriomotor. Pueden observarlos otras personas o referirlos el propio paciente.
- **Amnesias recurrentes** de sucesos cotidianos, de información personal importante o de experiencias traumáticas, incompatibles con el olvido ordinario. Por ejemplo, encontrar en el armario ropa que uno no recuerda haber comprado.
- Malestar o deterioro, y que el cuadro **no forme parte de una práctica cultural o religiosa** aceptada. En los niños no debe explicarse mejor por compañeros imaginarios o juegos de fantasía.

La prevalencia del TID varía mucho según el método de evaluación y el entorno en que se estudia, por lo que conviene no dar cifras cerradas.

Amnesia disociativa. Es la incapacidad de recordar información autobiográfica importante, normalmente de carácter traumático o estresante, que no encaja con el olvido normal. Puede ser **localizada** (un periodo concreto, como las horas que siguieron a un accidente), **selectiva** (solo algunos aspectos de ese periodo) o **generalizada** (toda la identidad y la historia vital, mucho más rara). A diferencia de las amnesias orgánicas (Unidad 5), no suele afectar a la capacidad de aprender información nueva ni sigue la ley de Ribot.

La **fuga disociativa** es un especificador de la amnesia disociativa: un viaje aparentemente intencionado o un vagabundeo sin rumbo acompañado de amnesia de la identidad. Un hombre aparece en una estación de otra provincia, bien vestido y con billete en el bolsillo, pero sin saber cómo ha llegado ni poder decir su nombre. En la CIE-11 la fuga también figura como calificador de la amnesia disociativa.

Dos modelos enfrentados. El origen del TID es uno de los debates más vivos de la psicopatología:

Aspecto	Modelo postraumático	Modelo sociocognitivo
Autores de referencia	Dalenberg et al. (2012)	Spanos (1994); Lilienfeld et al. (1999)
Causa principal	Trauma infantil grave que impide integrar la identidad	Sugestión, expectativas e influencia terapéutica y cultural
Papel de la disociación	Defensa frente a experiencias insoportables	Representación de un papel aprendido y reforzado

Las propuestas integradoras añaden al trauma las alteraciones del sueño y la **propensión a la fantasía**. El debate enlaza con el de los recuerdos recuperados: la represión inconsciente tiene un apoyo empírico débil y las técnicas sugestivas pueden generar recuerdos falsos (Otgaar et al., 2019). Brewin (2021) matiza esta crítica, pero hay acuerdo en no aceptar sin reservas recuerdos recuperados que no se puedan corroborar (Unidad 9).

14.2 Despersonalización, desrealización y disociación en la CIE-11

El **trastorno de despersonalización/desrealización** consiste en experiencias persistentes o recurrentes de dos tipos, que pueden darse juntas o por separado:

- **Despersonalización**: sensación de irrealidad, de distanciamiento o de ser un observador externo de los propios pensamientos, sentimientos, sensaciones, cuerpo o acciones. «Me oigo hablar como si fuera otro», «mis manos no parecen mías».
- **Desrealización**: el entorno se vive como irreal, lejano, como en un sueño o detrás de un cristal. «Veo la calle como un decorado».

El rasgo decisivo es que el **juicio de realidad se conserva**. La persona sabe que se trata de una sensación y la describe con un «es como si». Por eso no es un síntoma psicótico: quien tiene una idea delirante de transformación corporal afirma que su cuerpo ha cambiado de verdad. La prevalencia del trastorno es aproximadamente del 1-2 %.

Las experiencias breves de despersonalización son frecuentes en población general, sobre todo con cansancio intenso, estrés, falta de sueño o consumo de sustancias. Para diagnosticar el trastorno deben ser persistentes o recurrentes, causar malestar o deterioro y no explicarse mejor por otra causa. El diagnóstico diferencial incluye las **crisis de pánico** (Unidad 7), el **TEPT con síntomas disociativos** (Unidad 9), la intoxicación por **sustancias** como el cannabis o los alucinógenos (Unidad 15) y afecciones neurológicas como la **epilepsia**. La fenomenología de estas vivencias se describe en la Unidad 5.

La disociación en la CIE-11. La CIE-11 amplía el grupo de trastornos disociativos con varias categorías:

- **Trastorno de síntomas neurológicos disociativos**: es el equivalente de la conversión, que en la CIE-11 se clasifica como disociativa (apartado 14.4).

- **Trastorno de trance**: alteración temporal y marcada del estado de conciencia o pérdida del sentido habitual de identidad, con un estrechamiento de la conciencia del entorno, sin sustitución por otra identidad.
- **Trastorno de trance de posesión**: la identidad habitual se ve sustituida por una identidad «posesora» externa, como un espíritu o una deidad, y la persona vive sus actos como controlados por ella.
- **TID parcial**: un estado de personalidad dominante dirige la vida cotidiana y otros estados irrumpen en ella, sin tomar de forma recurrente el control de la conducta.

En los dos trastornos de trance es requisito que la experiencia sea involuntaria, no deseada y ajena a una práctica colectiva cultural o religiosa aceptada.

Cuestión	DSM-5-TR	CIE-11
Conversión	En síntomas somáticos (neurológicos funcionales)	En disociativos (neurológicos disociativos)
Fuga	Especificador de la amnesia	Calificador de la amnesia
Trance y posesión	Otro disociativo especificado	Categorías propias
TID incompleto	Otro disociativo especificado	TID parcial
Despersonalización y desrealización	Disociativo	Disociativo

14.3 Síntomas somáticos, distrés corporal y ansiedad por enfermedad

El DSM-5-TR agrupa en el capítulo de **síntomas somáticos y trastornos relacionados** el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno de ansiedad por enfermedad, el trastorno de síntomas neurológicos funcionales (conversión), los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas y el trastorno facticio.

Trastorno de síntomas somáticos. Requiere:

1. Uno o más **síntomas somáticos** que causan malestar o alteran la vida diaria.
2. **Pensamientos, sentimientos o conductas excesivos** relacionados con ellos: pensamientos desproporcionados y persistentes sobre su gravedad, ansiedad elevada por los síntomas o la salud, o tiempo y energía excesivos dedicados a ellos.
3. **Persistencia** durante al menos **6 meses**, aunque el síntoma concreto puede ir cambiando.

Se especifica si cursa con **predominio de dolor**, si es persistente y su gravedad. Su prevalencia ronda aproximadamente el 5-7 %. El gran cambio respecto a los antiguos trastornos somatomorfos es que **ya no exige que los síntomas carezcan de explicación médica**. El diagnóstico se basa en la respuesta excesiva al síntoma, no en la ausencia de causa orgánica. La crítica principal es el riesgo de **sobrediagnóstico** en personas con enfermedades médicas reales, cuya preocupación puede ser comprensible.

Trastorno de ansiedad por enfermedad. Es lo que antes se llamaba hipocondría. Sus rasgos son la preocupación por padecer o contraer una **enfermedad grave**, síntomas somáticos **ausentes o leves**, ansiedad elevada por la salud y conductas de **comprobación excesiva** (buscar bultos, tomarse la tensión a diario, buscar síntomas en internet) o de **evitación desadaptativa** (no ir al médico ni ver programas sobre enfermedades). Debe durar al menos **6 meses**, aunque la enfermedad temida cambie. Se especifica el tipo **con solicitud de asistencia** o **con evitación de asistencia**. La diferencia con el trastorno de síntomas somáticos está en el foco: aquí preocupa la enfermedad que se podría tener; allí, el síntoma que se tiene.

Un ejemplo: Jorge teme desde hace meses tener un problema cardiaco por una molestia mínima en el pecho. Tres electrocardiogramas normales lo han tranquilizado solo unos días cada vez.

Según los **modelos cognitivo-conductuales**, la atención focalizada en el cuerpo amplifica sensaciones normales, que se interpretan de forma catastrófica, y las conductas de seguridad (comprobar, consultar) alivian a

corto plazo pero mantienen el problema, como en el pánico y el TOC (Unidades 7 y 8). La relación entre estrés, enfermedad y adherencia al tratamiento se estudia en Psicología de la Salud.

La CIE-11 organiza estos cuadros de otra manera:

- El **trastorno de distrés corporal** sustituye a la somatización y a los trastornos somatomorfos. Exige síntomas corporales angustiantes y una atención excesiva a ellos, a menudo con contactos repetidos con los servicios sanitarios, y se gradúa como leve, moderado o grave.
- La **hipocondría** se clasifica en el grupo **obsesivo-compulsivo** y relacionados (Unidad 8), por su parecido con el TOC: pensamientos repetitivos sobre la enfermedad y conductas de comprobación o de búsqueda de tranquilización.
- La **disforia de integridad corporal** es el deseo intenso y persistente de ser físicamente discapacitado.

Cuadro	Síntomas corporales	Núcleo del problema	Ubicación en la CIE-11
Síntomas somáticos (DSM)	Presentes y molestos	Respuesta excesiva al síntoma	Equivale en gran parte al distrés corporal
Ansiedad por enfermedad (DSM)	Ausentes o leves	Miedo a tener una enfermedad grave	Hipocondría, en el grupo obsesivo-compulsivo
Distrés corporal (CIE-11)	Presentes y angustiantes	Atención excesiva a los síntomas	Grupo de distrés corporal o de la experiencia corporal

14.4 Síntomas neurológicos funcionales, trastorno facticio y factores psicológicos que influyen en otras afecciones

La historia de este grupo es la de la **histeria**, término de origen hipocrático. En el siglo XIX, Jean-Martin **Charcot** hizo de la Salpêtrière de París un centro de estudio de la histeria y de la hipnosis.



Figura 14.1. **Una lección clínica en la Salpêtrière (André Brouillet, 1887).** Charcot muestra a sus alumnos a una paciente diagnosticada de histeria, sostenida por Joseph Babinski. Fuente: André Brouillet, Wikimedia Commons, dominio público.

Como muestra la figura 14.1, la histeria se presentaba como un espectáculo clínico, algo que hoy se ve con reservas por el papel que pudo tener la sugestión. Freud, que se formó un tiempo con Charcot, explicó estos síntomas como la **conversión** de un conflicto psíquico en un síntoma corporal (*Estudios sobre la histeria*, con Breuer, 1895). De ahí viene el nombre de «trastorno de conversión» (Unidad 1).

Trastorno de síntomas neurológicos funcionales (conversión). Es el nombre del DSM-5-TR. Cursa con uno o varios síntomas que afectan al movimiento voluntario o a la sensibilidad: debilidad o parálisis, movimientos anómalos, alteraciones de la deglución o del habla, crisis no epilépticas psicógenas, anestesia o pérdida sensitiva, o síntomas sensoriales como la ceguera. La clave diagnóstica son los hallazgos clínicos que muestran **incompatibilidad** con las enfermedades neurológicas conocidas, es decir, **signos positivos**. En el **signo de Hoover**, la extensión de una cadera que parece paralizada recupera fuerza de forma involuntaria cuando la persona flexiona la otra pierna contra resistencia.

Dos cambios importan para el examen:

- **Ya no se exige identificar un factor psicológico** desencadenante, aunque puede especificarse si lo hay.
- **Ya no se exige descartar que el paciente finja**. El fingimiento no es parte del cuadro: los síntomas no se producen de forma intencionada.

La *belle indifférence*, la aparente despreocupación ante un síntoma grave, **no es específica** y no sirve para diagnosticar.

Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Se diagnostican cuando hay una enfermedad médica y factores psicológicos o conductuales que la empeoran: alteran su curso, interfieren con el tratamiento o aumentan los riesgos. Por ejemplo, una persona con diabetes que deja la insulina en épocas de estrés.

Trastorno facticio. Consiste en **falsificar** signos o síntomas físicos o psicológicos, o en inducir una lesión o enfermedad, con un **engaño identificado** y **sin incentivos externos evidentes**. Puede ser:

- **aplicado a uno mismo**, antes llamado síndrome de Münchausen;
- **aplicado a otro**, antes «por poderes»: se provocan o inventan síntomas en otra persona, a menudo un menor. El diagnóstico se asigna a quien causa el engaño, no a la víctima, y constituye una forma de maltrato.

Simulación. No es un trastorno mental, sino una afección que se registra con un código V/Z. Consiste en producir de forma intencionada síntomas falsos o muy exagerados movida por un **incentivo externo**: dinero, evitar el trabajo, el servicio militar o una condena. Hay que sospecharla ante un contexto médico-legal, una gran discrepancia entre las quejas y lo observado, o una falta de colaboración con la evaluación y el tratamiento.

Cuadro	¿Produce los síntomas a propósito?	¿Hay incentivo externo?	¿Es trastorno mental?
Síntomas neurológicos funcionales	No	No es lo que lo explica	Sí
Trastorno facticio	Sí	No evidente	Sí
Simulación	Sí	Sí	No (código V/Z)

Consenso y debate

Consenso: la despersonalización conserva el juicio de realidad. El trastorno de síntomas somáticos se define por la respuesta excesiva al síntoma y no por su falta de explicación médica. Los síntomas neurológicos funcionales se diagnostican por signos positivos de incompatibilidad, no solo por exclusión. Facticio y simulación comparten la intención de engañar y se diferencian por la motivación.

Debate: el origen del TID enfrenta al modelo postraumático (Dalenberg et al., 2012) con el sociocognitivo (Spanos, 1994; Lilienfeld et al., 1999), con propuestas integradoras que añaden el sueño y la propensión a la fantasía. También se discute si eliminar el requisito de síntomas médicamente inexplicados lleva a sobrediagnosticar a personas con enfermedades reales.

Mito frecuente

Mito: «Los alter de una persona con TID son personas distintas que conviven en un mismo cuerpo, y eso es lo que tiene quien sufre esquizofrenia».

Realidad: los estados de identidad del TID son partes fragmentadas de la identidad de una misma persona, no individuos independientes. Y la esquizofrenia no tiene nada que ver con la «personalidad múltiple»: es un trastorno psicótico, y Bleuler (1911) hablaba de escisión de las funciones psíquicas, no de la personalidad (Unidad 11).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Disociación	Discontinuidad en la integración de conciencia, memoria, identidad, percepción y control motor
Trastorno de identidad disociativo	Dos o más estados de personalidad diferenciados con amnesias recurrentes
Fuga disociativa	Viaje o vagabundeo aparentemente intencionado con amnesia de la identidad

Concepto	Definición
Despersonalización	Sensación de irrealidad o de ser observador de uno mismo, con juicio de realidad conservado
Trastorno de síntomas somáticos	Síntomas somáticos con pensamientos, emociones o conductas excesivos durante ≥6 meses
Trastorno de distrés corporal	Categoría de la CIE-11: síntomas corporales angustiantes con atención excesiva a ellos
Trastorno facticio	Falsificación o inducción de síntomas con engaño y sin incentivo externo evidente
Simulación	Producción intencionada de síntomas por un incentivo externo; no es trastorno mental

Clave PIR

Prioridad baja. Cuando aparece, se pregunta la diferencia entre conversión, trastorno facticio y simulación, la diferencia entre despersonalización y psicosis, y dónde se clasifica la hipocondría en cada sistema. Trampas típicas: creer que el trastorno de síntomas somáticos exige síntomas sin explicación médica, atribuir al facticio un incentivo económico y situar la conversión entre los disociativos del DSM-5-TR, cuando eso solo ocurre en la CIE-11.

Autoevaluación

1. Una persona describe que ve su casa «como un decorado de teatro», pero sabe que nada ha cambiado. Es un ejemplo de…
a) delirio de transformación del entorno
b) desrealización con juicio de realidad conservado
c) alucinación visual compleja

2. ¿Qué diferencia la simulación del trastorno facticio?
a) La presencia de un incentivo externo evidente
b) La producción intencionada de los síntomas
c) La existencia de un engaño sobre la salud

3. En el DSM-5-TR, el trastorno de síntomas somáticos…
a) exige síntomas sin explicación médica
b) exige una duración mínima de 12 meses
c) se basa en la respuesta excesiva al síntoma

4. En la CIE-11, la hipocondría se clasifica en el grupo de…
a) trastornos de distrés corporal
b) trastornos disociativos
c) trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados

5. Para diagnosticar un trastorno de síntomas neurológicos funcionales, el DSM-5-TR pide…
a) hallazgos clínicos incompatibles con una enfermedad neurológica
b) identificar un conflicto psicológico desencadenante
c) observar la *belle indifférence* ante el síntoma

Soluciones

1 b. La persona sabe que se trata de una sensación, por lo que no es un síntoma psicótico. **2 a.** Ambos implican producción intencionada y engaño; solo en la simulación hay incentivo externo. **3 c.** Desde el DSM-5 ya no se exige que el síntoma carezca de explicación médica, y la duración mínima es de 6 meses. **4 c.** La CIE-11 la sitúa junto al TOC por sus pensamientos repetitivos y comprobaciones. **5 a.** Se exigen signos positivos de incompatibilidad; el factor psicológico ya no es obligatorio y la *belle indifférence* no es específica.

Unidad 15 · Sustancias y conductas adictivas

Objetivos: definir intoxicación, abstinencia, tolerancia y craving; comparar los criterios del DSM-5-TR y de la CIE-11 para los trastornos por consumo; explicar los modelos del proceso oponente, de la sensibilización del incentivo, de la alostasis y del aprendizaje; describir los rasgos clínicos principales de cada clase de sustancia; conocer los criterios del trastorno por juego y del trastorno por videojuegos.

15.1 Conceptos y modelos de la adicción

Algunos conceptos básicos atraviesan todo el capítulo:

- **Intoxicación**: síndrome reversible, propio de cada sustancia, con cambios conductuales o psicológicos problemáticos durante el consumo o poco después.
- **Abstinencia**: síndrome propio de cada sustancia que aparece al dejarla o reducirla tras un consumo prolongado.
- **Tolerancia**: necesidad de dosis mayores para lograr el mismo efecto, o efecto menor con la misma dosis.
- **Craving**: deseo intenso o urgencia de consumir.

El DSM-5-TR distingue entre **trastornos por consumo** y **trastornos inducidos** por sustancias (intoxicación, abstinencia y cuadros psicóticos, depresivos, de ansiedad o del sueño inducidos). Reconoce diez clases de sustancias y un único trastorno sin sustancia: el **trastorno por juego** (apartado 15.4).

El **trastorno por consumo de sustancias** del DSM-5 unificó el abuso y la dependencia del DSM-IV en un solo continuo. Tiene **11 criterios** en cuatro grupos:

1. **Control deficitario**: consumir más o durante más tiempo de lo previsto; deseo o intentos fallidos de reducir; mucho tiempo dedicado a conseguir, consumir o recuperarse; craving.
2. **Deterioro social**: incumplir obligaciones; seguir consumiendo pese a problemas sociales; abandonar actividades.
3. **Consumo de riesgo**: consumir en situaciones peligrosas; seguir pese a saber que causa problemas físicos o psicológicos.
4. **Criterios farmacológicos**: tolerancia y abstinencia.

Se diagnostica con **2 o más criterios en 12 meses**, y la gravedad es **leve (2-3)**, **moderada (4-5)** o **grave (6 o más)**. El DSM-5 eliminó el criterio de problemas legales y añadió el craving. La tolerancia y la abstinencia **no cuentan** cuando el fármaco se toma bajo supervisión médica: un paciente con opioides pautados para el dolor no tiene por ello un trastorno.

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Estructura	Un continuo con 11 criterios	Consumo nocivo y dependencia
Umbral	≥2 criterios en 12 meses	Dependencia: ≥2 de 3 rasgos en 12 meses (o ≥3 meses si el consumo es continuo, diario o casi diario)
Gravedad o categorías	Leve, moderada, grave	Episodio nocivo, patrón nocivo, dependencia (categorías, no grados)
Juego	Trastorno por juego	Trastorno por juego
Videojuegos	Sección III (para estudio)	Diagnóstico oficial

En la CIE-11, los tres rasgos de la **dependencia** son el control deficitario, la prioridad creciente del consumo frente a otras actividades y los rasgos fisiológicos (tolerancia y abstinencia).

Modelos explicativos.

- **Proceso oponente** (Solomon y Corbit, 1974). Cada dosis provoca un proceso a, placentero, y después un proceso b, opuesto, que se fortalece con la repetición. Con el tiempo el placer se reduce (tolerancia) y el malestar posterior crece (abstinencia). El consumo deja de buscar placer y pasa a evitar malestar.
- **Sensibilización del incentivo** (Robinson y Berridge, 1993). La repetición sensibiliza el sistema dopaminérgico mesolímbico que atribuye **saliencia de incentivo** («querer») a la droga y a sus señales. Ese sistema se disocia del placer («gustar»), de modo que el deseo crece aunque el disfrute no.
- **Alostasis** (Koob y Le Moal). El consumo desplaza el punto de equilibrio hedónico y recluta sistemas de estrés como el CRF: es el «lado oscuro» de la adicción, dominado por el **refuerzo negativo**.
- **Enfermedad cerebral** (Volkow, Koob y McLellan, 2016), criticada por los modelos de **aprendizaje, elección y contexto**.
- **Aprendizaje** (véase la asignatura de Aprendizaje). Por condicionamiento clásico, las señales asociadas al consumo provocan craving. En la **tolerancia condicionada** descrita por Siegel, el contexto habitual desencadena respuestas compensatorias, lo que eleva el riesgo de sobredosis cuando se consume en un lugar nuevo. A ello se suman el refuerzo positivo y negativo, el aprendizaje social y las expectativas.
- **Prevención de recaídas** (Marlatt). Tras un consumo aislado, el **efecto de violación de la abstinencia** («ya lo he estropeado todo») facilita la recaída completa. El modelo transteórico del cambio (Prochaska y DiClemente) se estudia en Tratamientos.

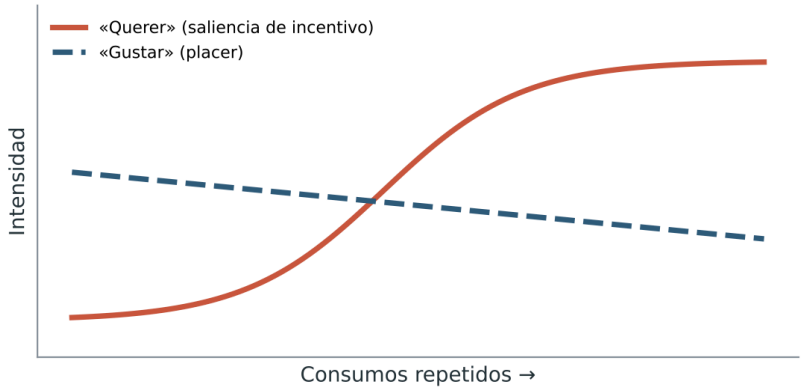


Figura 15.1. **«Querer» frente a «gustar».** A lo largo de los consumos repetidos, la curva del «querer» (saliencia de incentivo) sube, mientras la del «gustar» (placer) se mantiene o baja. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 15.1, se puede desear con intensidad algo que ya apenas se disfruta.

15.2 Alcohol, tabaco y cafeína

Los mecanismos de acción y los efectos adversos se estudian en Psicofarmacología. Aquí interesan sus cuadros clínicos.

Alcohol. Es un **depresor** del sistema nervioso central que potencia la acción del GABA y reduce la del glutamato. Es la sustancia que causa más trastornos por consumo, que son más frecuentes en varones. La heredabilidad del trastorno por consumo de alcohol es aproximadamente del 50 %.

- **Intoxicación**: habla farfullante, incoordinación, marcha inestable, nistagmo, alteración de la atención o la memoria y, en casos graves, estupor o coma.
- **Abstinencia**: hiperactividad autonómica (sudoración, taquicardia), temblor de manos, insomnio, náuseas, ansiedad, agitación, alucinaciones o ilusiones transitorias y posibles convulsiones. Su forma más grave es el

delirium tremens, con alteración de la conciencia y alucinaciones, que es una urgencia médica.

- **Trastornos inducidos**: el alcohol puede provocar cuadros depresivos, de ansiedad, del sueño o psicóticos. Si los síntomas persisten mucho tiempo después de dejar de beber, en torno a un mes o más, hay que pensar en un trastorno independiente.
- **Síndrome de Wernicke-Korsakoff**: se debe al **déficit de tiamina** (vitamina B1). La encefalopatía de Wernicke, aguda, combina confusión, ataxia y alteraciones de los movimientos oculares. El síndrome de Korsakoff deja una amnesia anterógrada grave con **confabulaciones** (Unidad 5).

Un ejemplo: Javier, de 48 años, bebe a diario desde hace años. Ingresa por una fractura y a los dos días empieza a temblar, a sudar y a ver insectos en la pared. Es un síndrome de abstinencia que hay que tratar como urgencia.

Tabaco. La **nicotina** es la sustancia responsable de la mayor carga de mortalidad. El DSM-5-TR reconoce el trastorno por consumo de tabaco y la abstinencia, pero no una intoxicación por tabaco. La abstinencia incluye irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, aumento del apetito, inquietud, ánimo deprimido e insomnio. Por eso muchos fumadores creen que fumar los calma, cuando gran parte del alivio consiste en suprimir la abstinencia, un buen ejemplo de **refuerzo negativo**.

Cafeína. Es la sustancia psicoactiva de uso más cotidiano. El DSM-5-TR reconoce la **intoxicación** por cafeína tras un consumo elevado (nerviosismo, inquietud, insomnio, rubor, molestias digestivas, taquicardia, agitación) y la **abstinencia** (cefalea, fatiga o somnolencia, ánimo disfórico o irritable, dificultad para concentrarse y síntomas parecidos a los de la gripe). El **trastorno por consumo de cafeína** solo figura en la Sección III, como afección que requiere más estudio. La cefalea del fin de semana en quien toma mucho café de lunes a viernes suele ser una abstinencia leve.

Sustancia	Acción principal	Intoxicación (rasgos típicos)	Abstinencia (rasgos típicos)
Alcohol	Depresor (GABA, glutamato)	Habla farfullante, incoordinación, nistagmo	Temblor, hiperactividad autonómica, convulsiones, delirium tremens
Tabaco	Nicotina, estimulante	No se reconoce en el DSM-5-TR	Irritabilidad, ansiedad, apetito, insomnio
Cafeína	Estimulante	Nerviosismo, insomnio, taquicardia	Cefalea, fatiga, disforia

15.3 Cannabis, opiáceos, estimulantes, sedantes, alucinógenos e inhalantes

Cannabis. Su principal componente psicoactivo es el **THC**. La intoxicación produce inyección conjuntival (ojos rojos), aumento del apetito, sequedad de boca y taquicardia, además de cambios en la percepción del tiempo y en la coordinación. El DSM-5 incorporó el **síndrome de abstinencia de cannabis**: irritabilidad, nerviosismo o ansiedad, dificultades para dormir, pérdida de apetito, inquietud, ánimo deprimido y malestar físico.

La creencia de que el cannabis «no crea abstinencia» no se sostiene. En un metaanálisis de 47 estudios con 23.518 participantes, el 47 % de los consumidores regulares o dependientes presentaba un síndrome de abstinencia (IC 95 %: 41-52 %) (Bahji et al., 2020).

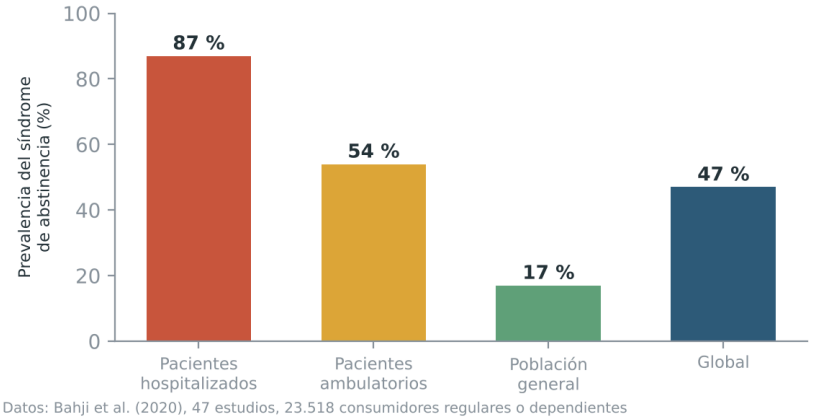


Figura 15.2. **Prevalencia del síndrome de abstinencia de cannabis.** Porcentaje de consumidores regulares o dependientes con abstinencia según el tipo de muestra: hospitalizados 87 %, ambulatorios 54 %, población general 17 % y global 47 %. Datos reales (Bahji et al., 2020). Elaboración propia.

Como muestra la figura 15.2, la abstinencia es más frecuente en las muestras clínicas, pero aparece también en población general. La relación entre cannabis y psicosis se trata en la Unidad 11.

Opiáceos (heroína, morfina, fentanilo y otros analgésicos opioides). Actúan sobre todo en los **receptores μ**. La intoxicación produce **miosis** (pupilas puntiformes), somnolencia y habla farfullante. En la **sobredosis** aparece una **depresión respiratoria** que puede ser mortal. La abstinencia es muy desagradable, aunque rara vez peligrosa en sí misma: ánimo disfórico, náuseas, dolores musculares, **lagrimeo y rinorrea**, **midriasis**, **piloerección**, sudoración, diarrea, **bostezos**, fiebre e insomnio. Es útil recordar que los signos de la abstinencia son, en buena parte, los opuestos a los de la intoxicación, como predice el proceso oponente.

Estimulantes (cocaína y anfetaminas). Aumentan la actividad **dopaminérgica**. La intoxicación produce euforia, hipervigilancia, taquicardia, midriasis, hipertensión y, a dosis altas, ideas paranoides. La abstinencia cursa con **disforia**, fatiga, sueños vívidos y desagradables, insomnio o **hipersomnia** y aumento del apetito.

Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, sobre todo las **benzodiacepinas**. Su intoxicación se parece a la del alcohol, y combinarlos con alcohol u opioides aumenta el riesgo de depresión respiratoria. Su **abstinencia es peligrosa**, con riesgo de convulsiones, por lo que la retirada debe ser gradual y supervisada.

Alucinógenos (LSD, psilocibina; la fenciclidina tiene categoría propia). Alteran la percepción, el estado de ánimo y el pensamiento. El DSM-5-TR no recoge un síndrome de abstinencia para ellos, pero sí el **trastorno perceptivo persistente por alucinógenos**: reexperimentación de alteraciones perceptivas (*flashbacks*) mucho después del consumo.

Inhalantes (disolventes, pegamentos, gasolina). Su consumo es más propio de **adolescentes** y produce mareo, incoordinación, habla farfullante y euforia.

Patología dual. Es la coexistencia de un trastorno adictivo y otro trastorno mental en la misma persona. Es frecuente en los servicios de tratamiento y obliga a preguntarse qué fue primero. Los cuadros inducidos por sustancias, como una psicosis tras consumir cocaína, deben distinguirse de los trastornos independientes que se agravan con el consumo.

15.4 Juego y videojuegos

El DSM-5 trasladó el antiguo **juego patológico** desde el capítulo de control de impulsos al de adicciones, con el nombre de **trastorno por juego**. Es el único trastorno adictivo sin sustancia del manual. Se apoyó en sus semejanzas con las adicciones a sustancias: pérdida de control, tolerancia, síntomas parecidos a la abstinencia y activación de los sistemas de recompensa.

El diagnóstico exige un juego problemático persistente con malestar o deterioro y **4 o más de 9 criterios en 12 meses**:

1. Necesidad de apostar cantidades crecientes para lograr la excitación deseada.
2. Nerviosismo o irritabilidad al intentar reducir o dejar el juego.
3. Intentos repetidos y fallidos de controlarlo.
4. Preocupación frecuente por el juego.
5. Apostar cuando se siente malestar.
6. Volver a jugar para **«recuperar»** lo perdido (*chasing*).
7. Mentir para ocultar el grado de implicación.
8. Poner en peligro o perder relaciones, trabajo o estudios.
9. Pedir dinero a otros para aliviar la situación económica.

La gravedad es **leve (4-5)**, **moderada (6-7)** o **grave (8-9)**. Hay que descartar que el juego se explique mejor por un **episodio maníaco**, en el que se puede gastar mucho dinero de forma repentina (Unidad 10). Los criterios 1 y 2 equivalen a la tolerancia y la abstinencia; el criterio 6 (*chasing*) es uno de los más característicos.

Un ejemplo: Daniel, de 26 años, empezó apostando en el móvil a partidos de fútbol. Ahora apuesta cada noche, cuando pierde aumenta la apuesta «para recuperar», ha pedido dos préstamos sin que su pareja lo sepa y se pone irritable si no puede jugar. Cumple al menos cuatro criterios (irritabilidad al no jugar, *chasing*, mentir y pedir dinero), suficientes para el diagnóstico.

Varios mecanismos de aprendizaje y cognitivos ayudan a entenderlo:

- **Refuerzo intermitente** de razón variable: los premios son impredecibles, lo que hace la conducta muy resistente a la extinción (Aprendizaje).
- **Ilusión de control**: creer que la habilidad o un ritual influyen en un resultado aleatorio.
- **Falacia del jugador**: pensar que tras varias pérdidas «toca» ganar.
- **Casi aciertos**: resultados que «casi» son premio y que se viven como señales de que se está cerca.

Videojuegos. La CIE-11 incluye el **trastorno por videojuegos** como diagnóstico oficial, con tres rasgos: **control deficitario** sobre el juego (inicio, frecuencia, duración), **prioridad creciente** del juego frente a otros intereses y actividades, y **continuación pese a consecuencias negativas**. Debe causar un deterioro significativo y suele exigir un periodo de **al menos 12 meses**, que puede ser menor si los síntomas son graves. Se especifica si es predominantemente en línea o fuera de línea. La CIE-11 incluye también el trastorno por juego (de apuestas) con la misma estructura.

En el DSM-5-TR, en cambio, el **trastorno por juego en internet** sigue en la **Sección III**, como afección que requiere más estudio. La diferencia entre ambos sistemas refleja una discusión abierta: preocupa no tratar a quien sufre un problema real, pero también **patologizar** una afición muy extendida. Jugar muchas horas no basta: lo que define el trastorno es la pérdida de control y el deterioro.

Aspecto	Trastorno por juego (DSM-5-TR)	Trastorno por videojuegos (CIE-11)
Estatus	Diagnóstico oficial	Diagnóstico oficial (en el DSM, solo Sección III)
Criterios	≥4 de 9 en 12 meses	Control deficitario, prioridad creciente, continuación pese a daños
Duración	12 meses	Normalmente ≥12 meses
Gravedad	Leve, moderada, grave	No se gradúa igual; se especifica en línea o fuera de línea

Consenso y debate

Consenso: el trastorno por consumo es un continuo de gravedad, y la tolerancia y la abstinencia no son necesarias ni suficientes para diagnosticarlo. El cannabis produce un síndrome de abstinencia real (Bahji et al., 2020). En la adicción intervienen el aprendizaje, la sensibilización del incentivo y la

neuroadaptación, y el «querer» puede disociarse del «gustar» (Robinson y Berridge, 1993). El juego comparte con las sustancias criterios y mecanismos.

Debate: si la adicción es ante todo una enfermedad cerebral (Volkow, Koob y McLellan, 2016) o se explica mejor con modelos de aprendizaje, elección y contexto, y si el trastorno por videojuegos merece un diagnóstico propio, como en la CIE-11, o necesita más estudio, como en el DSM-5-TR.

Mito frecuente

Mito: «El cannabis no crea abstinencia; quien lo deja solo necesita fuerza de voluntad».

Realidad: alrededor de la mitad de los consumidores regulares o dependientes presenta un síndrome de abstinencia, el 47 % según el metaanálisis de Bahji et al. (2020), y el DSM-5 lo incorporó como diagnóstico. Explicar la adicción como falta de voluntad contradice la evidencia sobre aprendizaje, sensibilización del incentivo y neuroadaptación (Robinson y Berridge, 1993; Volkow, Koob y McLellan, 2016).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Tolerancia	Necesidad de más dosis para el mismo efecto, o menor efecto con la misma dosis
Abstinencia	Síndrome específico de una sustancia al dejarla o reducirla tras un consumo prolongado
Craving	Deseo intenso de consumir; criterio añadido en el DSM-5
Proceso oponente	El proceso b, opuesto al placer, se fortalece con la repetición (Solomon y Corbit, 1974)
Sensibilización del incentivo	El «querer» crece con el consumo aunque el «gustar» no (Robinson y Berridge, 1993)
Tolerancia condicionada	Respuesta compensatoria provocada por el contexto habitual de consumo (Siegel)
Efecto de violación de la abstinencia	Un consumo aislado se vive como fracaso total y facilita la recaída (Marlatt)
Patología dual	Coexistencia de un trastorno adictivo y otro trastorno mental

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta el número de criterios del trastorno por consumo y sus niveles de gravedad, la diferencia entre el continuo del DSM-5-TR y el consumo nocivo y la dependencia de la CIE-11, los 4 de 9 criterios del juego y la distinción entre «querer» y «gustar». Trampas típicas: creer que el DSM-5-TR mantiene el abuso y la dependencia, o el criterio de problemas legales, y olvidar que el trastorno por videojuegos solo es diagnóstico oficial en la CIE-11.

Autoevaluación

1. En el DSM-5-TR, una persona que cumple 4 criterios del trastorno por consumo de alcohol en 12 meses tiene un trastorno…
a) leve
b) grave
c) moderado

2. Según Robinson y Berridge (1993), con el consumo repetido…
a) aumenta el «querer» aunque el «gustar» no aumente
b) aumentan por igual el «querer» y el «gustar»
c) disminuye el «querer» y aumenta el «gustar»

3. ¿Qué signo es propio de la intoxicación por opiáceos?
a) Midriasis
b) Miosis
c) Piloerección

4. En el DSM-5-TR, el trastorno por juego requiere…
a) 4 o más de 9 criterios en 12 meses
b) 2 o más de 11 criterios en 12 meses
c) 3 rasgos durante al menos 6 meses

5. El trastorno por videojuegos…
a) es diagnóstico oficial en el DSM-5-TR y en la CIE-11
b) no aparece en ninguno de los dos sistemas
c) es diagnóstico oficial en la CIE-11 y figura en la Sección III del DSM-5-TR

Soluciones

1 c. Leve es 2-3 criterios, moderado 4-5 y grave 6 o más. **2 a.** La saliencia de incentivo se sensibiliza y se disocia del placer. **3 b.** La miosis es típica de la intoxicación; la midriasis y la piloerección aparecen en la abstinencia. **4 a.** Los 2 de 11 corresponden al trastorno por consumo de sustancias. **5 c.** En el DSM-5-TR el trastorno por juego en internet es una afección para estudio.

Unidad 16 · Conducta alimentaria, conducta disruptiva y control de impulsos

Objetivos: describir los criterios de la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y el ARFID en el DSM-5-TR y la CIE-11; explicar el modelo transdiagnóstico de Fairburn y los factores de riesgo de los trastornos alimentarios; diferenciar el trastorno negativista desafiante del trastorno de la conducta; describir el trastorno explosivo intermitente, la piromanía, la cleptomanía y la conducta sexual compulsiva.

16.1 Anorexia, bulimia, atracones y ARFID

El capítulo de trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta del DSM-5-TR incluye la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, el trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos (**ARFID**), la pica y el trastorno de rumiación.

Anorexia nerviosa. Tiene tres rasgos:

1. **Restricción de la ingesta** que lleva a un **peso significativamente bajo** para la edad, el sexo, el desarrollo y la salud física.
2. **Miedo intenso a ganar peso** o a engordar, o conducta persistente que impide ganar peso.
3. **Alteración de la percepción** del peso o la figura, influencia excesiva de estos en la autoevaluación o falta de reconocimiento de la gravedad del bajo peso.

La **amenorrea dejó de ser criterio** en el DSM-5. Hay dos subtipos: **restrictivo** y **con atracones/purgas**. En adultos, la gravedad se gradúa por el índice de masa corporal (IMC): leve ≥17, moderada 16-16,99, grave 15-15,99 y extrema <15. La anorexia tiene una mortalidad elevada, de las más altas entre los trastornos mentales en muchos estudios.

Bulimia nerviosa. Combina **atracones recurrentes**, es decir, comer en un periodo determinado una cantidad claramente mayor de lo habitual con **sensación de pérdida de control**, y **conductas compensatorias inapropiadas**: vómito, laxantes, ayuno o ejercicio excesivo. Ambos deben darse **al menos una vez por semana durante 3 meses**. La autoevaluación está excesivamente influida por el peso y la figura, y el cuadro no aparece solo durante episodios de anorexia. El peso suele ser normal o con sobrepeso, y eso la distingue de la anorexia con purgas.

Trastorno por atracón. Hay atracones al menos una vez por semana durante 3 meses, **sin conductas compensatorias** regulares, con malestar intenso y al menos tres de estos rasgos: comer muy rápido, hasta sentirse desagradablemente lleno, sin tener hambre, a solas por vergüenza, y sentir asco, culpa o tristeza después. Es aproximadamente el trastorno alimentario más frecuente en adultos.

ARFID. Es una evitación o restricción de la comida por **falta de interés**, por sus **características sensoriales** (textura, olor, color) o por **miedo a consecuencias aversivas**, como atragantarse o vomitar. Produce pérdida de peso, déficit nutricional, dependencia de suplementos o interferencia psicosocial, pero **no hay preocupación por el peso ni por la figura**. Un niño que tras atragantarse con una espina solo acepta purés tendría este perfil.

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Peso en la anorexia	Gravedad por IMC (leve ≥17 a extrema <15)	Bajo peso: IMC <18,5; peligrosamente bajo: <14
Amenorrea	No es criterio	No es criterio
Duración de bulimia y atracón	≥1 vez/semana durante 3 meses	Orientativo: ≥1 vez/semana durante ≥1 mes

Aspecto	DSM-5-TR	CIE-11
Trastorno por atracón y ARFID	Incluidos desde el DSM-5	Incluidos como categorías nuevas

La CIE-11, como en otros capítulos, describe características esenciales con más flexibilidad clínica y evita los umbrales numéricos salvo en el peso.

16.2 Modelos de los trastornos alimentarios

El modelo transdiagnóstico de Fairburn (2003). Fairburn y su equipo propusieron que la anorexia, la bulimia y los cuadros atípicos comparten un mismo núcleo psicopatológico: la **sobrevaloración del peso, la figura y su control** como base de la autoevaluación. La mayoría de las personas se valoran por varias áreas de su vida (estudios, trabajo, relaciones, aficiones); en estos trastornos, el valor personal depende casi por completo de comer poco, pesar poco y tener una figura determinada.

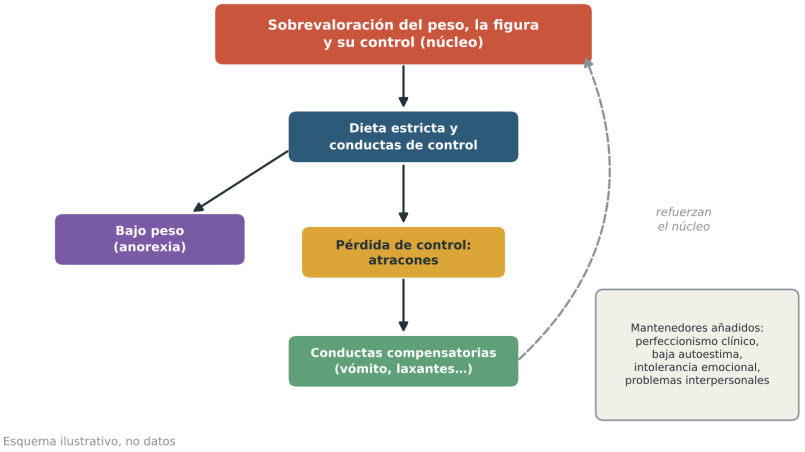


Figura 16.1. **Modelo transdiagnóstico de Fairburn.** El núcleo, la sobrevaloración del peso y la figura, lleva a una dieta estricta que favorece la pérdida de control y los atracones; estos provocan conductas compensatorias que refuerzan el núcleo. En la anorexia predomina el bajo peso, y se añaden mantenedores como el perfeccionismo, la baja autoestima, la intolerancia emocional y los problemas interpersonales. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.1, el modelo describe un círculo que se mantiene a sí mismo:

1. La sobrevaloración del peso conduce a una **dieta estricta**, con reglas rígidas («nada de pan», «menos de tantas calorías»).
2. La dieta estricta favorece, por privación y por la ruptura de reglas tan exigentes, la **pérdida de control** y los **atracones**.
3. Tras el atracón aparecen la culpa y el miedo a engordar, y con ellos las **conductas compensatorias**.
4. Las compensaciones alivian a corto plazo, pero **refuerzan el núcleo** y la dieta, y el ciclo vuelve a empezar.

En la anorexia, la restricción tiene éxito y el **bajo peso** mantiene a su vez el trastorno: la desnutrición aumenta la preocupación por la comida, el aislamiento y la rigidez.

Fairburn añadió cuatro **mantenedores adicionales** que aparecen en algunos pacientes: **perfeccionismo clínico**, **baja autoestima nuclear**, **intolerancia emocional** (comer, purgarse o restringir para regular emociones intensas) y **dificultades interpersonales**. De este modelo deriva la terapia cognitivo-conductual mejorada (TCC-E), que se estudia en Tratamientos.

La idea sobrevalorada. La convicción de estar gorda en una persona con un peso muy bajo suele considerarse una **idea sobrevalorada**, no un delirio: es una creencia intensa, cargada de afecto y coherente con valores

culturales, que domina la vida de la persona (Unidad 6). A veces el *insight* es muy pobre, pero no se trata de un trastorno psicótico.

Otros factores de riesgo. Ningún factor basta por sí solo, en la línea del modelo de vulnerabilidad-estrés (Unidad 2):

- **Socioculturales**: el ideal de delgadez, la presión sobre el cuerpo y la **insatisfacción corporal**. Hacer **dieta** es uno de los antecedentes más habituales.
- **Biológicos**: la heredabilidad es moderada-alta.
- **De personalidad**: el **perfeccionismo** y el **neuroticismo** (Personalidad).
- **Demográficos**: la **adolescencia** y el **sexo femenino**. La gran mayoría de los casos de anorexia de las series clínicas son mujeres, aunque los trastornos alimentarios en varones existen y probablemente se detectan menos.

Un ejemplo: Irene, de 15 años, empieza una dieta tras un comentario sobre su cuerpo en el vestuario. Las reglas se vuelven cada vez más estrictas, pesa la comida y se siente orgullosa cada vez que baja de peso. Cuando un día rompe una regla, se siente «un fracaso total» y come sin control, y al día siguiente ayuna. El ciclo de la figura 16.1 ya está en marcha.

16.3 Trastorno negativista desafiante y trastorno de la conducta

El DSM-5-TR agrupa en los **trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta** el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de la conducta, el trastorno de la personalidad antisocial (codificado también en este capítulo), la piromanía y la cleptomanía. Comparten problemas de autocontrol emocional y conductual que llevan a violar los derechos de otros o normas sociales importantes. El desarrollo típico de la conducta infantil y el apego se estudian en Psicología del Desarrollo.

Trastorno negativista desafiante (TND). Se caracteriza por tres tipos de síntomas que se repiten: **ánimo irritable o enfadado**, **conducta desafiante y discutidora** y **vengatividad**:

- al menos **4 síntomas** de esas tres categorías, durante **al menos 6 meses**;
- con **al menos una persona que no sea un hermano**;
- con una frecuencia mínima: **casi a diario en menores de 5 años** y **al menos una vez por semana a partir de los 5 años**.

La gravedad se especifica por el número de entornos en que aparece (casa, colegio, amigos). Es frecuente la comorbilidad con el TDAH y la ansiedad, y puede preceder al trastorno de la conducta. Hay que distinguirlo de las rabietas propias de la edad y del trastorno de **desregulación disruptiva del estado de ánimo** (Unidad 10), en el que predomina una irritabilidad crónica con arrebatos graves.

Trastorno de la conducta. Es un patrón repetitivo y persistente de violación de los derechos básicos de otros o de normas sociales importantes. Se exigen **al menos 3 de 15 criterios en los últimos 12 meses**, con al menos 1 en los últimos 6, repartidos en cuatro categorías:

1. **Agresión a personas y animales**: intimidar, iniciar peleas, usar armas, crueldad física.
2. **Destrucción de la propiedad**: provocar incendios o destruir bienes ajenos.
3. **Engaño o robo**: entrar en casas o coches ajenos, mentir para obtener beneficios, robar.
4. **Incumplimiento grave de normas**: salir de noche pese a la prohibición o hacer novillos desde edades tempranas, escaparse de casa.

Se distinguen los subtipos de **inicio infantil** (al menos un síntoma antes de los **10 años**), de inicio adolescente y no especificado. El inicio infantil tiene **peor pronóstico**, es más frecuente en varones y se asocia más a un trastorno antisocial posterior.

El especificador **«con emociones prosociales limitadas»** recoge los rasgos de **insensibilidad-frialdad** (*callous-unemotional*): falta de remordimientos o culpa, falta de empatía, despreocupación por el rendimiento y afecto superficial. Identifica un subgrupo más grave y conecta con el estudio de la psicopatía (Unidad 12). Si la persona tiene 18 años o más y cumple criterios de trastorno de la personalidad antisocial, se diagnostica este último.

Rasgo	TND	Trastorno de la conducta
Núcleo	Enfado, desafío y vengatividad	Violación de derechos ajenos y de normas
Agresión física y robo	No forman parte del cuadro	Son criterios centrales
Umbral	≥4 síntomas, ≥6 meses	≥3 de 15 en 12 meses
Especificadores	Gravedad por número de entornos	Edad de inicio; emociones prosociales limitadas
Trayectoria posible	Puede preceder al trastorno de la conducta	Puede preceder al trastorno antisocial

En la CIE-11, el TND y el **trastorno de conducta disocial** forman un grupo de **comportamiento disruptivo o disocial**, separado de los trastornos del control de los impulsos.

16.4 Explosivo intermitente, piromanía, cleptomanía y conducta sexual compulsiva

Muchos trastornos del control de los impulsos siguen un **ciclo** característico: tensión o activación creciente, acto, alivio, placer o gratificación y, en ocasiones, culpa posterior. A diferencia de la compulsión del TOC, que busca neutralizar un malestar sin placer (Unidad 8), aquí el acto suele resultar gratificante en el momento. El DSM-5 sacó de este capítulo la tricotilomanía, que pasó al grupo obsesivo-compulsivo, y el juego patológico, que pasó a las adicciones (Unidad 15).

Trastorno explosivo intermitente. Son arrebatos recurrentes por falta de control de los impulsos agresivos, con dos formas posibles:

- agresión verbal o física **sin daños** de media **2 veces por semana durante 3 meses**;
- o **3 arrebatos** con daño o destrucción de la propiedad o con lesiones físicas **en 12 meses**.

Los arrebatos son **desproporcionados** respecto a la provocación, **no premeditados** ni instrumentales, y la persona debe tener al menos **6 años**. Hay que descartar que la agresividad se explique por un trastorno psicótico, un episodio maníaco, un trastorno de la personalidad antisocial o límite, una sustancia o una lesión cerebral. Un ejemplo: un hombre rompe el móvil contra la pared porque el tren se ha retrasado cinco minutos y después se siente avergonzado; le ocurre varias veces al mes.

Piromanía. Es la provocación **deliberada e intencionada** de incendios en más de una ocasión, con tensión o activación previa, **fascinación por el fuego** y su contexto, y placer, gratificación o alivio al provocarlos o al presenciar sus consecuencias. No hay **motivo económico, ideológico ni de venganza**, ni se debe a un delirio o a un juicio alterado. Es rara. Hay que distinguirla del **incendiario** con una motivación instrumental, que quema un bosque para recalificar un terreno o para cobrar un seguro: eso no es piromanía.

Cleptomanía. La persona no logra resistir, una y otra vez, el impulso de llevarse objetos que **no necesita** ni le interesan por su valor. Hay tensión antes del robo y placer o alivio durante él, y el acto no responde a la ira, la venganza, un delirio ni una alucinación. Es rara y más frecuente en mujeres. A menudo los objetos se regalan, se tiran o se devuelven a escondidas, y la persona siente culpa después.

Conducta sexual compulsiva. Es una categoría de la **CIE-11**: un patrón persistente de fracaso en controlar impulsos sexuales intensos y repetitivos, que lleva a una conducta sexual repetitiva durante un periodo prolongado. La actividad sexual se convierte en el centro de la vida, hay intentos fallidos de reducirla, continúa

pese a sus consecuencias o a obtener poca satisfacción, y causa malestar o deterioro. El malestar que procede solo de juicios morales o de la desaprobación de los propios impulsos **no basta** para diagnosticarla. El DSM-5-TR no la incluye como diagnóstico.

Cuadro	DSM-5-TR	CIE-11
Explosivo intermitente	Disruptivos, control de impulsos y conducta	Control de los impulsos
Piromanía y cleptomanía	Disruptivos, control de impulsos y conducta	Control de los impulsos
Conducta sexual compulsiva	No existe como diagnóstico	Control de los impulsos
TND y trastorno de la conducta	Mismo capítulo que los impulsos	Grupo aparte de comportamiento disruptivo o disocial
Juego	Adicciones	Adicciones

Consenso y debate

Consenso: los trastornos alimentarios comparten un núcleo de sobrevaloración del peso y la figura que los mantiene (Fairburn et al., 2003), y la amenorrea ya no es criterio de anorexia. El trastorno de la conducta de inicio infantil y con emociones prosociales limitadas tiene peor pronóstico. En la piromanía y la cleptomanía falta el motivo instrumental que define al incendiario o al ladrón común.

Debate: dónde situar las conductas problemáticas sin sustancia: la CIE-11 coloca la conducta sexual compulsiva entre los trastornos del control de los impulsos y no entre las adicciones, y el DSM-5-TR no la reconoce. También se discute la frontera entre la conducta disruptiva infantil y las variaciones normales del desarrollo, y el poco conocimiento que hay sobre trastornos tan raros como la piromanía y la cleptomanía.

Mito frecuente

Mito: «Si no está muy delgada ni ha perdido la regla, no tiene un trastorno alimentario».

Realidad: la bulimia y el trastorno por atracón suelen cursar con peso normal o sobrepeso, y el atracón es aproximadamente el trastorno alimentario más frecuente en adultos. Desde el DSM-5 la amenorrea tampoco es criterio de anorexia (APA, 2022). Lo que comparten estos trastornos no es el peso, sino la sobrevaloración del peso y la figura (Fairburn et al., 2003).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Anorexia nerviosa	Restricción con peso significativamente bajo, miedo a engordar y alteración de la imagen corporal
Bulimia nerviosa	Atracones y conductas compensatorias ≥1 vez por semana durante 3 meses
Trastorno por atracón	Atracones recurrentes con malestar intenso y sin conductas compensatorias regulares

Concepto	Definición
ARFID	Restricción de la ingesta por desinterés, sensorialidad o miedo, sin preocupación por la figura
Sobrevaloración del peso y la figura	Núcleo transdiagnóstico de los trastornos alimentarios (Fairburn et al., 2003)
Emociones prosociales limitadas	Especificador del trastorno de la conducta con rasgos de insensibilidad-frialdad
Piromanía	Incendios deliberados por tensión y fascinación por el fuego, sin motivo instrumental
Cleptomanía	Impulso irresistible de robar objetos innecesarios, con tensión previa y alivio posterior

Clave PIR

Prioridad alta en trastornos alimentarios y baja en control de impulsos. Se pregunta que la amenorrea ya no es criterio, la diferencia entre bulimia y anorexia con purgas (el peso), el atracón sin compensación, el ARFID sin preocupación por la figura y el modelo de Fairburn. En la parte de conducta, las trampas típicas son confundir el TND con el trastorno de la conducta, olvidar la edad de 10 años del inicio infantil y tomar por piromanía un incendio provocado por dinero o venganza.

Autoevaluación

1. Una paciente con bajo peso, miedo intenso a engordar y vómitos frecuentes se diagnostica de…
a) anorexia nerviosa, subtipo con atracones/purgas
b) bulimia nerviosa con peso bajo
c) trastorno por atracón con compensación

2. ¿Qué rasgo distingue el ARFID de la anorexia nerviosa?
a) La pérdida de peso significativa
b) El inicio habitual en la infancia
c) La ausencia de preocupación por el peso y la figura

3. En el modelo de Fairburn (2003), el núcleo común de los trastornos alimentarios es…
a) la impulsividad ante la comida
b) la sobrevaloración del peso, la figura y su control
c) el déficit de serotonina hipotalámica

4. El trastorno de la conducta de inicio infantil exige al menos un síntoma antes de los…
a) 6 años
b) 10 años
c) 13 años

5. Un hombre quema el almacén de un competidor para hundir su negocio. Se trata de…
a) un incendio con motivación instrumental, no de piromanía
b) una piromanía con fascinación por el fuego
c) un trastorno explosivo intermitente

Soluciones

1 a. El bajo peso orienta a la anorexia aunque haya purgas; en la bulimia el peso suele ser normal. **2 c.** En el ARFID la restricción no responde al deseo de adelgazar. **3 b.** De ella derivan la dieta estricta, los atracones y las compensaciones. **4 b.** Antes de los 10 años se habla de inicio infantil, con peor pronóstico. **5 a.** La piromanía excluye los motivos económicos, ideológicos o de venganza.

Apéndices

Estudios y datos clave

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Wakefield (1992)	Trastorno como «disfunción perjudicial»: fallo de una función natural más un juicio de daño	1
McGrath et al. (2023)	Encuestas Mundiales de Salud Mental: riesgo acumulado de un trastorno a los 75 años del 46,4 % en hombres y del 53,1 % en mujeres; mediana de inicio, 19-20 años	1
Haro et al. (2006), ESEMeD-España	Prevalencia vital del 19,5 % y anual del 8,4 %; el episodio depresivo mayor es el trastorno más frecuente (10,5 % vital)	1
Polderman et al. (2015)	Metaanálisis de gemelos: heredabilidad media de los rasgos humanos ≈49 %	2
Engel (1977); Zubin y Spring (1977)	Modelo biopsicosocial; modelo de vulnerabilidad-estrés	2
First et al. (2023)	Cambios del DSM-5-TR: duelo prolongado, códigos de conducta suicida y autolesión, criterios aclarados en más de 70 trastornos	3
Reed et al. (2019)	Innovaciones de la CIE-11: características esenciales, dimensiones en personalidad y psicosis, nuevas categorías	3
Caspi et al. (2014)	Factor p: un factor general de psicopatología en la cohorte de Dunedin	4
Kotov et al. (2017)	HiTOP: taxonomía jerárquica empírica de la psicopatología	4
Andreasen (1979)	Escala TLC: definiciones operativas de los trastornos formales del pensamiento	6
Watson y Rayner (1920)	Miedo condicionado en un bebé («Albert»); caso único sin grupo control	7
Mowrer (1947)	Teoría bifactorial: adquisición clásica y mantenimiento por evitación	7
Seligman (1971); Rachman (1977)	Preparación filogenética; tres vías de adquisición del miedo	7
Clark (1986)	Modelo cognitivo del pánico: interpretación catastrófica de las sensaciones corporales	7
Wells (1995); Dugas et al. (1998)	Preocupación tipo 1 y tipo 2; intolerancia a la incertidumbre en el TAG	7
Salkovskis (1985); Rachman (1997)	Responsabilidad excesiva; fusión pensamiento-acción en el TOC	8
Wegner et al. (1987); Abramowitz et al. (2001)	Efecto rebote del «oso blanco»; en metaanálisis, pequeño-moderado	8
Ehlers y Clark (2000)	Modelo cognitivo del TEPT: sensación de amenaza actual	9
Otgaar et al. (2019)	Apoyo débil a la represión de recuerdos traumáticos y riesgo de recuerdos falsos	9

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Seligman y Maier (1967); Maier y Seligman (2016)	Diseño triádico de la indefensión; reinterpretación: lo que se aprende es el control	10
Beck (1967); Nolen-Hoeksema (1991)	Tríada cognitiva; estilo rumiativo de respuesta	10
Caspi et al. (2003); Border et al. (2019)	5-HTTLPR × estrés; los genes candidatos de la depresión no se replican	10
Moncrieff et al. (2022)	Revisión paraguas sin apoyo consistente a la hipótesis de déficit de serotonina	10
Heston (1966); Tienari et al. (2004)	Estudios de adopción en esquizofrenia; interacción entre riesgo genético y ambiente familiar	11
Trubetskoy et al. (2022)	GWAS de esquizofrenia: 287 loci asociados	11
Fazel et al. (2009)	Violencia en la esquizofrenia: OR ≈2,1 sin consumo de sustancias y ≈8,9 con consumo	11
Winsper et al. (2020)	Prevalencia mundial de cualquier trastorno de la personalidad: 7,8 %	12
Linehan (1993); Storebø et al. (2020)	Modelo biosocial del TLP; eficacia de la TDC y la TBM	12
Spielman et al. (1987)	Modelo 3P del insomnio: factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes	13
Masters y Johnson (1966); Kaplan (1979); Basson (2000)	Modelos lineales y circular de la respuesta sexual	13
Robinson y Berridge (1993)	Sensibilización del incentivo: crece el «querer», no el «gustar»	15
Bahji et al. (2020)	Síndrome de abstinencia de cannabis en el 47 % de los consumidores regulares o dependientes	15
Fairburn et al. (2003)	Modelo transdiagnóstico de los trastornos alimentarios	16

Mitos y correcciones

Mito	Corrección	Unidad
En la Edad Media la locura solo se explicaba por posesión demoníaca	Convivieron explicaciones naturales y hospitales, como el de los Inocentes de Valencia (1409)	1
El estudio de Rosenhan demostró que el diagnóstico psiquiátrico no sirve	Fue muy influyente, pero se han planteado dudas serias sobre su veracidad	1
El DSM-5-TR es el DSM-6	Es una revisión de texto del DSM-5; el futuro DSM solo existe como propuestas	3, 4
Toda alucinación indica psicosis	Hay alucinaciones hipnagógicas, en el duelo o por privación sensorial sin psicosis	6
La ansiedad social es timidez	La timidez es un rasgo frecuente; la mayoría de los tímidos no cumple criterios	7

Mito	Corrección	Unidad
Un ataque de pánico puede matarte	Es intenso pero no peligroso en sí; la interpretación catastrófica lo mantiene	7
Tener TOC es ser ordenado	El TOC es egodistónico y produce malestar; el perfeccionismo egosintónico es el TPOC	8
Los recuerdos traumáticos reprimidos se recuperan con fiabilidad	El apoyo a la represión es débil y las técnicas sugestivas crean recuerdos falsos	9
La depresión es un déficit de serotonina	La hipótesis no tiene apoyo consistente; la depresión es multicausal	10
La indefensión es algo que se aprende	La pasividad es la respuesta por defecto; lo que se aprende es el control	10
Ser bipolar es cambiar de humor a menudo	Son episodios que duran días o semanas	10
La esquizofrenia es tener varias personalidades	Es un trastorno psicótico; la «personalidad múltiple» corresponde al TID	11
Las personas con esquizofrenia son violentas	El riesgo se concentra en el consumo de sustancias y el riesgo absoluto es bajo	11
El trastorno límite no tiene tratamiento	Hay terapias eficaces y la mayoría alcanza la remisión a largo plazo	12
Los «alter» del TID son personas distintas	Son estados de identidad fragmentados de una misma persona	14
El cannabis no produce abstinencia	El síndrome de abstinencia es frecuente en consumidores regulares	15
La adicción es falta de voluntad	Intervienen aprendizaje, incentivo, neuroadaptación y contexto	15

Bibliografía

Manuales de referencia

- American Psychiatric Association (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5.ª ed., texto revisado; DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing.
- World Health Organization (2024). *Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural or neurodevelopmental disorders (CDDR)*. World Health Organization.
- Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (eds.). *Manual de psicopatología* (vols. I y II, 3.ª ed.). McGraw-Hill.
- Caballo, V. E., Salazar, I. C. y Carrobles, J. A. (dirs.). *Manual de psicopatología y trastornos psicológicos* (2.ª ed.). Pirámide.
- Jaspers, K. (1913). *Allgemeine Psychopathologie*. Springer.

Artículos seleccionados

- Abramowitz, J. S., Tolin, D. F. y Street, G. P. (2001). Paradoxical effects of thought suppression: A meta-analysis of controlled studies. *Clinical Psychology Review*, 21(5), 683-703. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(00)00057-X

- Bahji, A., Stephenson, C., Tyo, R., Hawken, E. R. y Seitz, D. P. (2020). Prevalence of cannabis withdrawal symptoms among people with regular or dependent use of cannabinoids: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Network Open*, 3(4), e202370. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.2370
- Border, R. et al. (2019). No support for historical candidate gene or candidate gene-by-interaction hypotheses for major depression across multiple large samples. *American Journal of Psychiatry*, 176(5), 376-387. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.18070881
- Brewin, C. R. (2021). Tilting at windmills: Why attacks on repression are misguided. *Perspectives on Psychological Science*, 16(2), 443-453. https://doi.org/10.1177/1745691620927674
- Caspi, A. et al. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? *Clinical Psychological Science*, 2(2), 119-137. https://doi.org/10.1177/2167702613497473
- Culverhouse, R. C. et al. (2018). Collaborative meta-analysis finds no evidence of a strong interaction between stress and 5-HTTLPR genotype contributing to the development of depression. *Molecular Psychiatry*, 23, 133-142.
- Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196(4286), 129-136.
- Fazel, S., Gulati, G., Linsell, L., Geddes, J. R. y Grann, M. (2009). Schizophrenia and violence: Systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine*, 6(8), e1000120. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000120
- First, M. B. et al. (2023). DSM-5-TR: Rationale, process, and overview of changes. *Psychiatric Services*, 74(8), 869-875. https://doi.org/10.1176/appi.ps.20220334
- Haro, J. M. et al. (2006). Prevalencia de los trastornos mentales y factores asociados: resultados del estudio ESEMeD-España. *Medicina Clínica*, 126(12), 445-451.
- Kotov, R. et al. (2017). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies. *Journal of Abnormal Psychology*, 126(4), 454-477. https://doi.org/10.1037/abn0000258
- Maier, S. F. y Seligman, M. E. P. (2016). Learned helplessness at fifty: Insights from neuroscience. *Psychological Review*, 123(4), 349-367. https://doi.org/10.1037/rev0000033
- McGrath, J. J. et al. (2023). Age of onset and cumulative risk of mental disorders: A cross-national analysis of population surveys from 29 countries. *Lancet Psychiatry*, 10(9), 668-681. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00193-1
- Moncrieff, J. et al. (2022). The serotonin theory of depression: A systematic umbrella review of the evidence. *Molecular Psychiatry*, 28, 3243-3256. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01661-0
- Öngür, D. et al. (2026). The future of DSM: A report from the Structure and Dimensions Subcommittee. *American Journal of Psychiatry*. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.20250876
- Oquendo, M. A. et al. (2026). Initial strategy for the future of DSM. *American Journal of Psychiatry*. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.20250878
- Otgaar, H. et al. (2019). The return of the repressed: The persistent and problematic claims of long-forgotten trauma. *Perspectives on Psychological Science*, 14(6), 1072-1095. https://doi.org/10.1177/1745691619862306
- Polderman, T. J. C. et al. (2015). Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies. *Nature Genetics*, 47, 702-709. https://doi.org/10.1038/ng.3285
- Reed, G. M. et al. (2019). Innovations and changes in the ICD-11 classification of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. *World Psychiatry*, 18(1), 3-19. https://doi.org/10.1002/wps.20611
- Storebø, O. J. et al. (2020). Psychological therapies for people with borderline personality disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, CD012955. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012955.pub2
- Trubetskoy, V. et al. (2022). Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. *Nature*, 604, 502-508. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04434-5
- Winsper, C. et al. (2020). The prevalence of personality disorders in the community: A global systematic review and meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 216(2), 69-78. https://doi.org/10.1192/bjp.2019.166

- Zubin, J. y Spring, B. (1977). Vulnerability: A new view of schizophrenia. *Journal of Abnormal Psychology*, 86(2), 103-126.

Créditos de las ilustraciones

Las figuras 1.1, 1.6, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2, 11.4, 12.1, 13.3, 15.1, 15.2 y 16.1 son de **elaboración propia** de SAIMAP (esquemas y gráficos). Las marcadas como esquema son ilustrativas y no representan datos; las que muestran datos citan su fuente en el pie.

Las imágenes siguientes proceden de Wikimedia Commons y se usan según sus licencias. Se reproducen sin cambios salvo el tamaño y, donde se indica, el fondo.

Figura	Autoría	Licencia	Archivo
1.2 Cráneos trepanados de la Edad del Bronce	Wisi eu	CC BY-SA 4.0	Crânes trépanation âge du bronze.jpg
1.3 *El padre Jofré protegiendo a un loco*	Joaquín Sorolla	Dominio público	Jofre sorolla.jpg
1.4 *En Bedlam*	William Hogarth (Yale Center for British Art)	CC0	William Hogarth - A Rake's Progress, Plate VIII, In Bedlam - B1981.25.1418 - Yale Center for British Art.jpg
1.5 Pinel en la Salpêtrière	Tony Robert-Fleury	Dominio público	Philippe Pinel à la Salpêtrière.jpg
1.7 Emil Kraepelin	Wellcome Collection	CC BY 4.0	Portrait Emil Kraepelin. Wellcome L0030730.jpg
2.1 Sigmund Freud	Max Halberstadt	Dominio público	Sigmund Freud, by Max Halberstadt (cropped).jpg
7.2 El pequeño Albert	John B. Watson	Dominio público	Little-albert.jpg
11.1 Eugen Bleuler	Clínica Burghölzli	Dominio público	Eugen Bleuler.jpg
11.3 Ventrículos laterales en gemelos discordantes	Daniel Weinberger, NIMH	Dominio público	Enlarged lateral ventricles in schizophrenia.png
13.1 Hipnograma (fondo blanco añadido)	RazerM	CC BY-SA 3.0	Sleep Hypnogram.svg
13.2 Apneas en una polisomnografía (fondo blanco añadido)	Eumetaxas	CC BY-SA 3.0	Polysomnography.png
14.1 *Una lección clínica en la Salpêtrière*	André Brouillet (1887)	Dominio público	Une leçon clinique à la Salpêtrière.jpg